Abstract

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Konzept der Drogenkonsumräume, der praktischen Umsetzung dieses Konzeptes in Stuttgart und wirft dabei ebenfalls einen Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen einer solchen Einrichtung. Ausgangslage ist die Eröffnung der Einrichtung „KOMBO“ im Mai vergangenen Jahres. KOMBO ist damit der ersten und einzige Drogenkonsumraum in Stuttgart. Die rechtlichen Rahmenbedingungen und eine Legaldefinition eines Drogenkonsumraums liefert der im Jahr 1999 erlassene §10a BtMG. Demnach ist ein Drogenkonsumraum eine Einrichtung, „in deren Räumlichkeiten Betäubungsmittelabhängigen eine Gelegenheit zum Verbrauch von mitgeführten ärztlich nicht verschriebenen Betäubungsmitteln verschafft oder gewährt wird“. Nach §10a BtMG wird zum Betreiben einer solchen Einrichtung eine Erlaubnis benötigt und ermächtigt die Landesregierungen zum Erlassen von Rechtsverordnungen, die das Erteilen einer solchen Erlaubnis regeln. Dabei gibt §10a BtMG lediglich zehn Mindeststandards der zu erlassenen Rechtsverordnungen vor. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat im Jahr 2019 eine solche Landesverordnung erlassen, um das Einrichten eines Drogenkonsumraums in Karlsruhe zu ermöglichen. Da diese Einrichtung stets positive Ergebnisse erzielen konnte, wurde auch in Stuttgart, nach Evaluation des Bedarfs, im Jahr 2025 eine solche Einrichtung eröffnet. Diese Arbeit trägt zunächst Hintergrundinformationen über die bundesweite Entstehung von Drogenkonsumräumen zusammen, stellt den Bedarf einer solchen Einrichtung dar und befasst sich kritisch mit potenziellen und bereits eingetretenen Auswirkungen. Danach werden die rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert und darauf eingegangen, wie §10a BtMG in der DrogKRV BW umgesetzt wird. Zum Abschluss wird mithilfe eines Experteninterviews die praktische Umsetzung in Stuttgart erläutert und mit den zuvor erarbeiteten Ergebnissen kritisch in Bezug gesetzt. Die Arbeit kommt zum Ergebnis, dass auch KOMBO positive aber auch negative Ergebnisse erzielt und auf der einen Seite für viele seiner Nutzer einen durchaus positiven Mehrwert bietet, aber auch vielen Nutzern schaden kann. Es wird gezeigt, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen in bestimmten Einzelfällen auch das Gegenteil der angestrebten Zielsetzung erreichen kann und dass stets Handlungsbedarf bezogen auf §10a BtMG und die DrogKRV BW besteht. Des Weiteren wird herausgearbeitet, dass Drogenkonsumräume auf keinen Fall eine Art „Musterlösung“ der Problematik sind und zu den positiven Ergebnissen mehrere Faktoren gehören, die zuvor oder parallel eintreten müssen, damit eine solche Einrichtung ihren positiven Nutzen entfalten kann.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT ..... **I**

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ..... **III**

GENDERERKLÄRUNG ..... **V**

I. EINLEITUNG **1**

1 GANG DER DARSTELLUNG 2
2 HINWEIS 2

II. HAUPTTEIL **3**

1 GESELLSCHAFTSPOLITISCHE AUSGANGSLAGE DER SCHAFFUNG VON DROGENKONSUMRÄUMEN 3
1.1 Hintergrundinformationen zu Drogenkonsumräumen *3*
1.2 Bedarf eines Drogenkonsumraums in Stuttgart *6*
1.3 Funktionsweise des Drogenkonsumraums in Stuttgart *9*
1.4 Chancen und Bedenken *10*
1.5 Nutzung und Auswirkung von Drogenkonsumräumen *14*
1.6 Kritik an Drogenkonsumräumen *15*
2 RECHTLICHER RAHMEN DES DROGENKONSUMRAUMS 18
2.1 §10a BtMG *18*
2.2 Straflosigkeit der Nutzer und des Personals *27*
2.3 Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg über den Betrieb von Drogenkonsumräumen *29*
3 EXPERTENINTERVIEW 33
3.1 Auswahl der Expertin und Kontaktaufnahme *33*
3.2 Gesprächsablauf *33*
3.3 Analyse *34*

III. FAZIT **52**

1 AUSBLICK UND WEITERER FORSCHUNGSBEDARF 52

LITERATURVERZEICHNIS ..... **VI**

ANHANGSVERZEICHNIS ..... **VII**

Abkürzungsverzeichnis

a.F.	alte Fassung
Abs.	Absatz
ALBVVG	Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz
Art.	Artikel
Ausschl.	Ausschließlich
BeckOK	Beck Onlinekommentar
BfArM	Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte
Bspw.	Beispielsweise
Btm	Betäubungsmittel
BtMG	Betäubungsmittelgesetz
BW	Baden-Württemberg
DKR	Drogenkonsumraum / Drogenkonsumräume
DrogKRV BW	Verordnung der Landesregierung über den Betrieb von Drogenkonsumräumen Baden-Württemberg
Et al.	Et alii (und andere)
Gem.	Gemäß
GG	Grundgesetz
Ggf.	Gegebenenfalls
Grds.	Grundsätzlich
i.d.R.	In der Regel
Mind.	Mindestens
Nr.	Nummer
OLG	Oberlandesgericht

Rn.	Randnummer
S.	Seite / Satz (im gesetzlichen Kontext)
s.h.	Siehe
StA	Staatsanwaltschaft
StGB	Strafgesetzbuch
StPO	Strafprozessordnung
v.a.	Vor allem
Vgl.	Vergleiche
Zw.	Zwischen

Gendererklärung

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit ausschließlich das generische Maskulin verwendet. Bezieht sich eine Personenbezeichnung auf ein bestimmtes Geschlecht, wird explizit darauf hingewiesen. Ohne entsprechenden Hinweis sind stets alle Geschlechtsidentitäten gemeint.

I. Einleitung

Der Drogenkonsum, besonders die Drogensucht und die damit einhergehenden Probleme werden ein immer präsenteres Thema und immer mehr deutsche Städte sehen sich mit dem Problem offener Drogenszenen konfrontiert. Diese Probleme äußern sich beispielsweise (bspw.) in großen Szenenansammlungen an öffentlichen Plätzen, immer häufigeren Funden von gebrauchtem Konsumbesteck in der Öffentlichkeit oder auch durch eine immer weiter steigende Zahl der Drogentoten. Neben den Gesundheitsrisiken durch die konsumierten Substanzen, sind Drogenkonsumenten besonders gefährdet, an Infektionskrankheiten wie Hepatitis oder HIV zu erkranken oder im schlimmsten Fall sogar in Folge des Drogenkonsums zu sterben. Grund dafür sind oftmals äußerst unhygienische Konsumbedingungen, wie beispielsweise das Teilen einer Spritze zum Heroinkonsum oder das Wiederverwenden von Drogenfiltern. Besonders schwer Betäubungsmittelabhängigen fehlt aufgrund ihrer Lebenssituation außerhalb des Drogenkonsums oft die Möglichkeit für hygienische Konsumbedingungen oder ein geschütztes Umfeld für den Konsum. So finden sich Konsumenten oft in Hinterhöfen, Parkhäusern oder öffentlichen Toiletten wieder, wo sie keiner beim Konsumieren sehen und stören kann, sie aber auch im Falle einer Überdosierung oder eines Notfalls meist zu spät gefunden werden. Hier sollen Drogenkonsumräume (DKR) ansetzen und dieser Konsumentengruppe einen geschützten Rahmen für den Drogenkonsum bieten. In erster Linie liegt es nahe, an Städte wie Frankfurt oder Berlin zu denken, in denen der Bedarf einer solchen Einrichtung auf den ersten Blick offensichtlich erscheint. Jedoch haben sich in den vergangenen Jahren insgesamt 19 deutsche Städte[1] dazu entschieden, einen DKR einzurichten. So auch Stuttgart. Im vergangenen Jahr, am 21. Mai 2025, wurde die Einrichtung KOMBO in der Lazarettstraße 8 in 70182 Stuttgart im Leonhardsviertel eröffnet[2]. Gepaart mit einem Kontaktcafé im gleichen Haus soll KOMBO den Betäubungsmittelabhängigen in Stuttgart eine geschützte Konsumumgebung bieten und die Öffentlichkeit von der örtlichen Drogenszene in Stuttgart entlasten.

Die folgende Arbeit soll die Frage klären, inwiefern eine solche Einrichtung in Stuttgart gebraucht wird, was Chancen und mögliche Bedenken einer solchen Einrichtung sind, wie der DKR in Stuttgart angenommen wird, was KOMBO bislang ins Positive aber auch vielleicht ins Negative verändert hat und insbesondere wie eine solche Einrichtung rechtliche behandelt und erfasst wird.

[1] Vgl. Informationen zu Drogenkonsumräumen: in: Deutsche Aidshilfe, n.d. https://www.aidshilfe.de/drogen/informationen-zu-drogenkonsumraeumen aufgerufen: 19.07.2026 08:58 Uhr.
[2] Vgl. Kubietziel 2025, KOMBO soll Leben retten https://www.caritas-stuttgart.de/presse/presse/kombo-soll-leben-retten-436bd61f-089b-4b20-95e0-c2f691191c0c aufgerufen: 01.10.2026. 22:31 Uhr.

1 Gang der Darstellung

Zur Erarbeitung dieser Themenbereiche wird der Hauptteil der Arbeit in drei Abschnitte geteilt. Zunächst werden die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eines DKRs dargestellt. Hier wird geklärt, was man unter einem DKR versteht, wie die örtliche Drogensituation in Stuttgart aussieht, wie ein DKR funktioniert, was Chancen und Bedenken bundesweit aber auch in Stuttgart sind, wie DKR auf Bundesebene angenommen werden und was an dem Konzept eines DKRs verbessert werden kann. Im zweiten Teil werden die rechtlichen Rahmenbedingungen aufgearbeitet. Hierfür wird insbesondere die Entstehungs- und Veränderungsgeschichte des §10a BtMG dargestellt, die Frage geklärt, wie das Personal und die Nutzer vor gerichtlicher Verfolgung geschützt werden und wie §10a BtMG in der Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg (BW) über den Betrieb von Drogenkonsumräumen (DrogKRV BW) umgesetzt wird. Zu guter Letzt wird mithilfe eines Experteninterviews die Umsetzung eines DKRs in Stuttgart praktisch aufgearbeitet und die Übertragbarkeit der in den vorherigen Teilen erarbeiteten Ergebnisse auf KOMBO geprüft.

2 Hinweis

Das Suchthilfesystem in Stuttgart umfasst neben der ambulanten Suchthilfe auch den Bereich der Prävention. Wenn im Folgenden vom Suchthilfesystem gesprochen wird, ist damit ausschließlich (ausschl.) das Feld der ambulanten Suchthilfe gemeint.

II. Hauptteil

1 Gesellschaftspolitische Ausgangslage der Schaffung von Drogenkonsumräumen

1.1 Hintergrundinformationen zu Drogenkonsumräumen

Zum Anfang der Arbeit werden Hintergrundinformationen zu DKR zusammengetragen. Dafür werden zunächst DKR definiert, die Ziele dieser Einrichtungen dargestellt, die Situation in Deutschland und Europa aufgearbeitet und den Wandel der Herausforderungen der Drogenszene angesprochen.

1.1.1 Definition

Ein DKR wird gemäß (gem.) des §10a (1) S. 1 BtMG als eine Einrichtung, „in deren Räumlichkeiten Betäubungsmittelabhängigen eine Gelegenheit zum Verbrauch von mitgeführten, ärztlich nicht verschriebenen Betäubungsmitteln (Btm) verschafft oder gewährt wird“ definiert. DKR sind Teil des Netzwerks der ambulanten Suchthilfe[3] und befinden sich in der Regel (i.d.R.) in Gegenden nahe offener Drogenszenen, „die durch einen hohen Anteil des öffentlichen Drogenkonsums gekennzeichnet sind“[4].

Drogenkonsumräume gibt es sowohl stationär als auch mobil, wobei das Konzept der mobilen DKR bisher noch nicht weit verbreitet ist[5]. In der Praxis werden stationäre DKR vor allem (v.a.) in zwei Modelle unterschieden. Einerseits „integrierte Drogenkonsumräume“[6], bei welchen die DKR direkt an niedrigschwellige Einrichtungen angegliedert sind, in denen die Überwachung des Konsums nur eine der dort angebotenen Leistungen ist. Weitere Leistungen neben dem DKR umfassen beispielsweise: Duschen, eine Unterkunft, psychosoziale Betreuung, Überweisung zur Behandlung des Drogenkonsums und teilweise auch Zugang zu Beschäftigungsprogrammen[7]. Ein integrierter DKR wäre also

[3] Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart (2019): Konzept eines Drogenkonsumraums in der Landeshauptstadt Stuttgart, Anlage 3 zu GRDrs 533/2019 (S. 9).
[4] Europäische Beratungsstelle für Drogen und Drogensucht (2024), Gesundheitliche und soziale Maßnahmen zur Bewältigung drogenbedingter Probleme: ein europäischer Leitfaden (S. 3).
[5] Vgl. Informationen zu Drogenkonsumräumen, n.d..
[6] Europäische Beratungsstelle für Drogen und Drogensucht (2024), S. 4.
[7] Europäische Beratungsstelle für Drogen und Drogensucht (2024), S. 4.

beispielsweise ein DKR in einer Notunterkunft, wo die Nutzung des DKRs nur einen Teil der Leistungen dieser Notunterkunft darstellt.

Andererseits „spezialisierte Drogenkonsumräume“. Diese bieten im Vergleich zu den integrierten Einrichtungen ein begrenztes Spektrum an Leistungen an, die im direkten Zusammenhang mit dem überwachten Konsum stehen[8]. Diese spezialisierten Einrichtungen sind als physisch getrennter Teil des lokalen Hilfenetzwerks zu betrachten, worüber Nutzer Zugang zu weiteren Gesundheits- und Sozialdiensten haben. Die Angebote eines spezialisierten DKRs umfassen unter anderem die Bereitstellung von Konsumutensilien für den hygienischen Drogenkonsum, die Beratung bei Fragen über den sicheren Drogenkonsum (Safer-Use) und die Intervention bei Notfällen[9]. Somit ist ein spezialisierter DKR eine eigenständige Einrichtung, welche in das Netzwerk der Suchthilfe der betroffenen Stadt einbezogen ist und Nutzer je nach Bedarf an weitere Dienste verweisen kann. Vergleicht man beide Praxismodelle wird klar, dass in beiden Modellen ähnliche Dienstleistungen angeboten werden. Sie unterscheiden sich lediglich in der Umsetzung und Anbindung an andere Einrichtungen.

1.1.2 Ziele eines Drogenkonsumraums

Die Ziele der DKR lassen sich in drei Säulen unterscheiden: gesundheitspräventive, drogentherapeutische und ordnungspolitische Ziele[10]. Gesundheitspräventive Ziele umfassen dabei drei wesentliche Punkte: Das Vermeiden von Infektionen und schweren Folgeerkrankungen, das Verhindern von Überdosierungen und Drogentodesfällen im DKR und die Verbesserung des Kenntnisstands zu Risiken des Drogenkonsums[11]. Drogentherapeutische Ziele beziehen sich v.a. darauf, schwer erreichbare Drogenkonsumenten zu erreichen[12], also die Gruppe an Konsumenten, die über die bisherigen Angebote nicht erreicht wurden. Dieser Kontakt soll gepflegt werden, damit auch dieser Konsumentengruppe bei der Verbesserung ihrer Lebenssitatuion geholfen werden kann[13]. Ordnungspolitische Ziele konzentrieren sich zentral darauf, die Belastung der Öffentlichkeit durch die Dro-

[8] Europäische Beratungsstelle für Drogen und Drogensucht (2024), S. 4.
[9] Europäische Beratungsstelle für Drogen und Drogensucht (2024), S. 5.
[10] Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart (2019): Konzept eines Drogenkonsumraums in der Landeshauptstadt Stuttgart, S. 4.
[11] Vgl. Ziele und Aufgaben von Drogenkonsumräumen: in: Deutsche Aidshilfe, n.d. https://www.aids-hilfe.de/drogen/ziele-und-aufgaben-von-drogenkonsumraeumen aufgerufen: 19.07.2026 17:43 Uhr.
[12] Vgl. Ziele und Aufgaben von Drogenkonsumräumen, n.d..
[13] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen, 31. Ed. 15.06.2026, BtMG §10a Rn. 4-5.1.

genszene zu reduzieren. Mögliche Belastungen sind bspw. Verunreinigungen durch benutztes Konsumbesteck an öffentlichen Plätzen oder Szenenansammlungen[14] an szenetypischen Orten.

Somit sind DKR ein „sekundärpräventives Angebot“ und verfolgen einen „Harm Reduction“-Ansatz[15]. Sekundärprävention umfasst Maßnahmen, die der Früherkennung von Erkrankungen dienen und bieten damit die Möglichkeit einer rechtzeitigen Behandlung, wenn bereits Risikofaktoren vorliegen[16]. Harm Reduction ist „neben Prävention, Therapie und Repression eine Säule moderner Drogenpolitik“[17]. Wie der Begriff bereits andeutet, zielt Harm Reduction darauf ab, „die individuellen und gesellschaftlichen Schäden des Gebrauchs von psychoaktiven Drogen von Meschen zu reduzieren“[18]. Dabei wird zum einen der Fokus auf Konsumenten, die ihren Konsum nicht einstellen können, beziehungsweise wollen und zum anderen auf die Ursachen von gesundheitlichen Risiken und Schäden des Drogenkonsums[19] gelegt. Harm Reduction hat nicht das Ziel, den Drogenkonsum zu verhindern, sondern die gesundheitlichen Risiken, welche durch den Drogenkonsum entstehen können, zu vermeiden. Dabei geht der Harm Reduction Ansatz akzeptierend und rücksichtsvoll vor und nimmt Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse und die persönliche Situation der Konsumenten[20].

1.1.3 Situation in Europa und Deutschland

Der erste DKR in Europa wurde im Jahr 1986 in Bern in der Schweiz eröffnet. In den Folgejahrzehnten schlossen sich immer mehr europäische Länder an[21]. In Deutschland wurden die ersten DKR im Jahr 1994 in Frankfurt am Main und in Hamburg eröffnet[22]. Die ersten DKR waren als Antwort auf die in den 1980er Jahren rasche Ausbreitung von HIV gedacht, welche im Zusammenhang mit der „epidemieartigen Verbreitung“ des Heroinkonsums und des injizierenden Drogenkonsums auftrat. Durch das Einrichten der DKR erhoffte man sich die aus dem injizierenden Drogenkonsum und anderen Formen des Hochrisikokonsums resultierenden Schäden einzudämmen[23]. Heutzutage werden in Deutschland 34 stationäre und vier mobile DKR in 19 Städten und acht Bundesländern betrieben, wobei die mobilen Konsumräume bisher nur in Berlin und Köln vertreten

[14] Vgl. Ziele und Aufgaben von Drogenkonsumräumen, n.d..
[15] Zurhold /Kreutzfeldt /Degkwitz /Verthein, Drogenkonsumräume. Gesundheitsförderung und Minderung öffentlicher Belastungen in europäischen Großstädten, Freiburg i. Br. 2001, S. 11.
[16] Vgl. DocCheck, Medizinexperti*Innen Bei: Sekundärprävention – DocCheck Flexikon, n.d., https://flexikon.doccheck.com/de/Sekund%C3%A4rpr%C3%A4vention aufgerufen: 13.08.2026 17:29 Uhr.
[17] DocCheck, Medizinexperti*Innen Bei: Harm Reduction – DocCheck Flexikon, in: DocCheck Flexion, n.d.a. https://flexikon.doccheck.com/de/Harm_Reduction aufgerufen: 04.08.2026 10:31 Uhr.
[18] Vgl. DocCheck bei: Harm Reduction, n.d.a..
[19] International Harm Reduction Association 2010, Whatcis Harm Reduction?.
[20] Vgl. International Harm Reduction Association 2010.
[21] Vgl. Europäische Beratungsstelle für Drogen und Drogensucht (2024), S. 11.
[22] Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart (2019): Konzept eines Drogenkonsumraums in der Landeshauptstadt Stuttgart, S. 3.
[23] Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (2018), Drogenkonsumräume: Überblick über das Angebot und Evidenzdaten, S. 1.

sind[24]. Diese Zahlen zeigen, dass sich das Konzept eines DKRs bereits in mehreren Bundesländern etabliert hat und DKR aktiv in das Suchthilfesystem der Bundesländer integriert werden.

1.1.4 Neue Herausforderungen

Wie unter dem vorangegangenen Unterkapitel bereits thematisiert, wurden die ersten DKR als Antwort auf die Ausbreitung des injizierenden Drogenkonsums, also des Konsums mittels Spritzen, eröffnet. In den letzten Jahren ist jedoch die Konsumform des Injizierens in Europa rückläufig und der Fokus verschiebt sich auf den Missbrauch von synthetischen Opioiden, beispielsweise Fentanyl, und auf Konsumformen wie das Inhalieren der Substanzen[25]. DKR sind also kein finales Konzept, um örtliche Probleme zu lösen oder Bedürfnisse abzudecken, sondern sind einem ständigen Wandel unterzogen und müssen sich an den aktuellen Drogenmarkt anpassen[26]

1.2 Bedarf eines Drogenkonsumraums in Stuttgart

DKR bestehen bereits in mehreren deutschen Großstädten und es haben viele weitere deutsche Städte Bedarf für einen DKR. Im Folgenden wird der Bedarf einer solchen Einrichtung am Beispiel Stuttgart näher erläutert.

1.2.1 Bedarfsuntersuchung 2016-2017

Um den Bedarf in Stuttgart zu ermitteln, wurde im Mai 2016 „eine partizipative Arbeitsgruppe mit Vertretern der Selbsthilfegruppe, des Suchthilfeverbundes sowie der Sozialplanung gegründet“[27] und eine Bedarfsuntersuchung über den Zeitraum von einem Jahr durchgeführt. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden 110 Drogenkonsumierende unter anderem über ihr Konsumverhalten, ihre bisherigen Erfahrungen mit Notfallsituationen im Rahmen des Konsums und ihren bisherigen Kontakt zum Suchthilfesystem befragt[28]. Hierbei konnte erhoben werden, dass ungefähr 50% der Befragten bereits Infektionskrankheiten aufwiesen. Dies kann daraus resultieren, dass 43% der intravenös Konsumierenden nicht bei jedem Konsumvorgang frisches Injektionsbesteck benutzten und überwiegend an unhygienischen Orten wie Parkhäuser, öffentlichen Toiletten und Parks unter „katastrophalen Bedingungen“[29] konsumieren. Teilweise wurden in der Vergangenheit unter anderem Pfützen- und Toilettenwasser zum Aufkochen der Injektionslösungen verwendet[30], wodurch das Risiko für Infektionen und Drogennotfallsituationen erhöht wird.

[24] Vgl. Informationen zu Drogenkonsumräumen, n.d..
[25] Vgl. Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (2024), S. 11.
[26] Vgl. Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (2024), S. 11.
[27] Protokoll: Sozial- und Gesundheitsausschuss des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart: in: Protokoll, 09.07.2018.
[28] Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart (2019): Konzept eines Drogenkonsumraums in der Landeshauptstadt Stuttgart, S. 7.
[29] BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 1.
[30] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn.1.

Zudem hatte die Mehrheit (60%) in der Vergangenheit bereits Erfahrungen mit Drogennotfallsituationen gemacht. 59% der Befragten gaben einen Mehrfachkonsum an und konsumierten zwischen (zw.) zwei und vier Substanzen. Bemerkenswert ist, dass nur 14% der Befragten noch keinen Kontakt zum Hilfesystem hatten. Dies deutet darauf hin, dass bereits 2016 ein großer Teil der Konsumenten an das Drogenhilfesystem in Stuttgart angebunden waren. Fraglich ist jedoch, wie repräsentativ diese 14% auf die Gesamtheit der Drogenkonsumierenden sind, da die genaue Zahl der Konsumenten in Stuttgart nicht beziffert werden kann[31]. Die Untersuchung legt also nahe, dass der Drogenkonsum nicht nur durch die konsumierten Substanzen, sondern auch durch die Konsumbedingungen und -orte besondere gesundheitliche Risiken bietet, Drogennotfallsituationen weit verbreitet sind und auch nicht selten passieren.

1.2.2 Belastungen der Öffentlichkeit

Ein weiterer Punkt, der den Bedarf eines DKRs in Stuttgart verdeutlichte, war das immer größer werdende Problem mit Funden von Drogenmüll im Bereich der Jakobschule und des Leonhardsviertels. In diesem Bereich häuften sich die Funde von benutzten Spritzen und benutztem Konsumbesteck. Eine einwöchige Sammelaktion im Jahr 2017 mit anschließenden Labortests der gefundenen Konsumutensilien zeigte, dass 90% der dort gefundenen Spritzen Kokainreste enthielten. Aufgrund dieser Ergebnisse vermuteten die Träger der Suchthilfeverbände in Stuttgart, dass es sich hierbei um eine Konsumentengruppe handeln könnte, die bisher noch nicht an die Suchthilfe angegliedert war[32]. Diese Schlussfolgerung wird durch die Zahlen des Jahresberichts der ambulanten Suchthilfe 2017 bestärkt. Denn dieser Jahresbericht zeigt, dass sich das Suchthilfesystem zu dieser Zeit primär auf Opiatabhängige und andere Suchtformen spezialisiert und nur vereinzelt Kokainabhängige angesprochen hat. Im Jahr 2017 verzeichnete die ambulante Suchthilfe 2.722 Neuzugänge in den Beratungen. Davon wurden bei 12,2% (334) der Klienten Opiate und lediglich bei 2,5% (69) Kokain als vorrangige Suchtbelastung diagnostiziert. Dieser geringe Anteil beweist nicht, dass jede aufgefundene Spritze einem Konsumenten zuzuordnen ist, der noch keinen Kontakt zum Suchthilfesystem in Stuttgart hat. Er deutet dennoch darauf hin, dass die Drogenproblematik weitaus differenzierter und tiefgreifender ist als die Opiatabhängigkeit, gewisse Konsumentengruppen durch das Raster der Drogenhilfe fallen, die Drogenszene ständig im Wandel ist und sich das Suchthilfesystem immer neuen Herausforderungen gegenübersteht.

1.2.3 Jahresberichte der ambulanten Suchthilfe

Betrachtet man weitere Zahlen der Jahresberichte der ambulanten Suchthilfe, so sieht man, dass sich der Bedarf über die Jahre seit Beginn der Planung und der letztendlichen Einrichtung des DKRs immer erweitert hat. Zwar hat sich die Anzahl der Betreuungen

[31] Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart (2019): Konzept eines Drogenkonsumraums in der Landeshauptstadt Stuttgart, S. 3.
[32] Vgl. Protokoll: Sozial- und Gesundheitsausschuss des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart, 2018, S. 3.

von 2016 mit 4.536 Betreuungen auf 4.657 Betreuungen im Jahr 2024 nicht erheblich erhöht, dennoch ist hier die Zahl der neu begonnenen Betreuungen hervorzuheben. Selbst im Jahr 2024 wurden 60,5% dieser Betreuungen neu begonnen, was nochmals verdeutlicht, dass es noch immer einen großen Teil an Drogenkonsumenten gibt, die bisher noch keinen Kontakt zum Suchthilfesystem hatten oder nach Beendigung einer Behandlung nach einiger Zeit das Suchthilfesystem erneut in Anspruch nehmen. Betrachtet man die Neuzugänge in das Suchthilfesystem im Jahr 2024 sieht man, dass sich der Anteil der Konsumenten mit der Hauptdiagnose Kokain auf 3,9% erhöht hat, was nochmals auf eine zunehmende Belastung des Kokainkonsums hinweist. Zwar ist diese Zahl im Hinblick auf die Gesamtheit der Neuzugänge nicht erheblich, betrachtet man jedoch nur die Zielgruppe der DKR, so wird deutlich, dass der Anteil der Kokainkonsumenten weiter steigt.

1.2.4 Drogentodesfälle

Eines der wichtigsten Indizien für den Bedarf eines DKRs in Stuttgart ist die Anzahl der drogeninduzierten Todesfälle. Diese Zahl wird von der Polizei erfasst und beschreibt alle Todesfälle, „bei denen ein illegaler Substanzkonsum vermutet wird oder bekannt ist und bei denen durch Obduktion und chemisch-toxikologische Untersuchungen nachgewiesen wurde, dass der Substanzkonsum im kausalen Zusammenhang mit der Todesursache steht“[33]. Allein vor der Bedarfsuntersuchung 2016 ist die Zahl der drogeninduzierten Todesfälle innerhalb von zwei Jahren von zwölf (2014) auf 18 Fälle im Jahr 2016 angestiegen. Dieser Aufwärtstrend zeigt sich auch bis unmittelbar vor der Einrichtung von KOMBO im Jahr 2024. Hier stieg die Zahl auf 20 Fälle an. In 14 dieser 20 Fälle war ein Mischkonsum mehrerer Substanzen todesursächlich, drei waren auf eine Überdosierung zurückzuführen und zwei verstarben infolge der Langzeitfolgen des Konsums. Diese Statistik ist jedoch widersprüchlich, da im Jahr 2024 laut der Träger der ambulanten Suchthilfe insgesamt 31 Klienten verstarben[34]. Dieser Widerspruch wurde auch in einer Evaluationsstudie von Poschadel et al. im Jahr 2002 beleuchtet. Hier wurde anhand des Beispiels Nordrhein-Westfalen begründet, dass die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Drogenkonsum stehen, vermutlich deutlich höher ist als die Zahl, die in der Statistik aufgeführt wird. Beispielsweise wurden hier 498 Todesfälle gezählt, aber nur 85 in die tatsächliche Statistik aufgenommen[35]. Gründe hierfür könnten sein, dass der Langezeitkonsum nicht immer als todesursächlich erkannt wird und es im Ermessen des Arztes liegt, den Tod aufgrund von Infektionserkrankungen, wie Hepatitis, der Abhängigkeit

[33] Suchthilfeverbund Stuttgart, Fachgruppe Dokumentation 2026, Jahresbericht 2025 der ambulanten Suchthilfe in Stuttgart Bereiche Beratung, Betreuung und Behandlung – ausgewählte Daten, S. 13.
[34] Vgl. Suchthilfeverbund Stuttgart, Fachgruppe Dokumentation 2025, Jahresbericht 2024 der ambulanten Suchthilfe in Stuttgart Bereiche Beratung, Betreuung und Behandlung – ausgewählte Daten, S. 12.
[35] ZEUS GmbH/Poschadel/Höger/Schnitzler/Schreckenberg/Kramer/Rabczinski/Haustein/Bodamer/Gailus/Friedrichsmeier/Ellers/Niemarkt: Evaluation der Arbeit der Drogenkonsumräume in der Bundesrepublik Deutschland, 2002, S. 140.

von Drogen zuzuschreiben[36]. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Dunkelziffer, v.a. für Konsumenten, die noch nicht an das Suchthilfesystem angegliedert sind, deutlich höher ist.

1.3 Funktionsweise des Drogenkonsumraums in Stuttgart

1.3.1 Zielgruppe des Drogenkonsumraums

In der Literatur finden sich verschiedene Definitionen der Zielgruppe eines DKRs. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Schwerpunkt und die Nutzungsbeschränkungen von Einrichtung zu Einrichtung variieren können. Im Folgenden wird versucht, eine gemeinsame Zielgruppe zu definieren.

Die Zielgruppe eines DKRs besteht aus Personen, die aktuell unter einer Betäubungsmittelabhängigkeit leiden und langjährige Konsumerfahrungen teilen. Dabei können diese Personen bereits unter daraus resultierenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen[37] leiden. Es werden Konsumenten angesprochen, die riskant konsumieren oder nur begrenzte Möglichkeiten für einen hygienischen Konsum haben[38].

1.3.2 Vorgehensweise in Stuttgart

1.3.2.1 Rahmenbedingungen

Die Trägerschaft des DKRs „KOMBO“ in Stuttgart wird vom Caritasverband für Stuttgart e.V. und Release Stuttgart e.V. übernommen. KOMBO befindet sich derzeit als Interimslösung in der Lazarettstraße 8 in 70182 Stuttgart im Leonhardsviertel und besteht aus einem Kontaktcafé, einem Konsumraum, mehreren Büros für die Sozialarbeiter und verfügt seit neuestem über eine eigene Substitutionspraxis. Der eigentlich vorgesehene Standort ist die Ossietzkystraße 6 in 70174 Stuttgart[39] in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die Interimslösung hat den Grund, dass der eigentlich vorgesehene Standort zunächst umgebaut und saniert werden muss. Der Standort in der Ossietzkystraße wird voraussichtlich Ende 2029 beziehbar sein. Bis dahin wird sich der DKR im Interimsstandort befinden[40]. Fraglich ist jedoch, ob der jetzige Interimsstandort nicht vorteilhafter wäre. Denn betrachtet man erneut die öffentliche Belastung des Leonhardsviertels unter dem Aspekt, dass sich DKR i.d.R. in Gegenden in der Nähe offener Drogenszenen befinden,

[36] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 140.
[37] Vgl. Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 57.
[38] Vgl. Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (2024), S. 3.
[39] Caritasverband für Stuttgart e.V. (2026), Ein Jahr KOMBO: Drogenkonsumraum bewährt sich, Erste Bilanz zeigt: Geschütztes Angebot retter Leben und entlastet den öffentlichen Raum, https://www.caritas-stuttgart.de/presse/presse/ein-jahr-kombo-drogenkonsumraum-bewaehrt-sich-c5099b18-6b11-452e-8291-77b921cf8d42 aufgerufen: 19.07.2026 08:58 Uhr.
[40] Landeshauptstadt Stuttgart: Umbau und Sanierung des Gebäudes Ossietzkystraße 6, Stuttgart-Mitte mit Integration Drogenkonsumraum und Büronutzung für das Amt für Soziales und Teilhabe – Projektbeschluss, 2026.

so würde dies für den aktuellen Standort bereits zutreffen. Jedoch bietet der geplante Standort mehr Platz für die Beratung und tagesstrukturierende Angebote[41].

Ursprünglich war geplant, dass KOMBO sieben Tage pro Woche für mindestens (mind.) vier Stunden geöffnet hat. Dabei sollte er an Werktagen sechs Stunden und an Wochenend- und Feiertagen vier Stunden geöffnet haben[42]. Jedoch konnte durch Kürzungen in der Förderung durch die Landeshauptstadt Stuttgart die Sonntagsöffnung nicht mehr aufrechterhalten werden[43]. Derzeit hat KOMBO folgendermaßen geöffnet: Montag bis Mittwoch von 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr, donnerstags von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr, freitags ebenfalls von 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr und samstags und an Feiertagen unter der Woche von 10:00 Uhr bis 15:30 Uhr[44]. Somit wird zumindest die Öffnungsdauer gem. dem Konzept eingehalten.

1.3.2.2 Kooperationen

Die Kooperationen des DKRs werden gem. dem Konzept in interne und externe Kooperationen unterschieden[45]. Die interne Kooperation bedeutet in diesem Rahmen die Anbindung von KOMBO innerhalb der ambulanten Suchthilfe in Stuttgart. Sie regelt, dass KOMBO ein ergänzendes Angebot darstellt und als Bestandteil der ambulanten Suchthilfe zu sehen ist. Darauf aufbauend können die Angebote der ambulanten Suchthilfe kurzfristig und unbürokratisch genutzt werden[46]. Die externe Kooperation umfasst die Zusammenarbeit zw. der Trägerschaft von KOMBO und der zuständigen Polizei-, Ordnungs- und Strafverfolgungsbehörden. Diese Zusammenarbeit wird in einem Kooperationsvertrag schriftlich festgelegt. Näheres dazu ist Kapitel „2.3.4.2. Kooperationsvertrag“ zu entnehmen.

1.4 Chancen und Bedenken

Die Chancen eines solchen DKRs liegen darin, die anfangs aufgeführten Ziele eines DKRs zu erreichen und den Bedarf in den entsprechenden Städten zu decken. Hierbei sind die Chancen von dem tatsächlichen Nutzen eines DKRs abzugrenzen. Chancen beschreiben lediglich die potenziellen Verbesserungen, die durch die Maßnahmen und Angebote im Rahmen des DKRs erreicht werden können. Somit zielt dieses Kapitel darauf ab, darzustellen, mithilfe welcher Angebote welche Wirkungen erzielt werden können.

---

[41] Vgl. Ein Jahr KOMBO: Drogenkonsumraum bewährt sich, 2026.
[42] Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart (2019), Konzept eines Drogenkonsumraums in der Landeshauptstadt Stuttgart, S. 11.
[43] Vgl. Ein Jahr KOMBO: Drogenkonsumraum bewährt sich, 2026.
[44] Vgl. Ein Jahr KOMBO: Drogenkonsumraum bewährt sich, 2026.
[45] Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart (2019), Konzept eines Drogenkonsumraums in der Landeshauptstadt Stuttgart, S. 9.
[46] Vgl. Landeshauptstadt Stuttgart (2019), Konzept eines Drogenkonsumraums in der Landeshauptstadt Stuttgart, S. 9.

1.4.1 Chancen

Die Chancen eines DKRs liegen darin, den Drogenkonsum an einem Ort zu zentralisieren[47]. Dadurch kann zum einen die Belastung der Öffentlichkeit durch öffentliche Szenenbildungen und konsumspezifischen Verunreinigungen reduziert werden[48], zum anderen kann aber auch die Erreichbarkeit des Hilfesystems für die Konsumenten verbessert werden[49]. Somit bieten DKR nicht nur Verbesserungen für die Seite des Konsums, sondern auch für die Öffentlichkeit und das betroffene Umfeld der offenen Drogenszene. Denn durch das Konzept eines DKRs kann eine Konsumentengruppe erreicht werden, welche besonders vulnerabel und für das Hilfesystem oft schwer zugänglich ist[50]. Dem könnte zugrunde liegen, dass wie bereits oben angesprochen, die angebotenen Leistungen nicht gezwungenermaßen angenommen werden müssen und als Ergänzung zu den besseren Konsumbedingungen zu sehen sind. Somit können auch Konsumenten angesprochen werden, die einen DKR lediglich für die Konsumumgebung nutzen, ohne weitere Hilfen in Anspruch zu nehmen. Im weiteren Verlauf können diese Konsumenten weitere Hilfen angeboten und eine Brücke zur Perspektive jenseits des Drogenkonsums aufgebaut werden[51].

Durch die Zentralisierung und die dadurch entstehende Nähe der Mitarbeiter zur Drogenszene bekommen sie oft früh Einblicke in neue Bewegungen und neue Muster des Konsums. Dadurch können neu entstehende Trends schnell erkannt und eventuelle Anpassungen vorgenommen werden. DKR bieten somit auch einen nützlichen Rahmen für die Forschung und Weiterentwicklung der Modelle[52] der ambulanten Suchthilfe und der örtlichen Drogenpolitik. Dies könnte sich beispielsweise auf die konsumierten Substanzen beziehen. Denn wie bereits unter dem Kapitel „1.1.4 Neue Herausforderungen“ beleuchtet, ändert sich der Trend vom intravenösen Konsum von Heroin zu neuen Substanzen wie Kokain, Crack oder synthetischen Opioiden. Hierdurch kann eine Aussage über die Konsumform und das Konsumverhalten und entsprechende Anpassungen wie beispielsweise eine neue Zuweisung der Plätze oder Erhöhung der Raucherplätze getroffen werden. Die Forschung könnte sich aber auch auf im Suchthilfesystem unterrepräsentierte Konsumentengruppen beziehen, wie beispielsweise Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund. Dadurch könnten Konzepte entwickelt werden, wie diese Konsumentengruppen besser angesprochen werden können[53].

[47] Vgl. Protokoll: Sozial- und Gesundheitsausschuss des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart, 2018, S. 5.
[48] Vgl. Bergmann, H., Neumeier, E., Schäffer, D. (2026), Drogenkonsumräume in Deutschland 2024, DBDD: München & DAH: Berlin, S. 5.
[49] Vgl. Protokoll: Sozial- und Gesundheitsausschuss des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart, 2018, S. 5.
[50] Vgl. Bergmann, H. et al. 2026, S. 4.
[51] Vgl. Bergmann, H. et al. 2026, S. 5.
[52] Vgl. Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 2024, S. 13.
[53] Vgl. Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 2024, S. 13.

Ein weiterer potenziell positiver Effekt eines DKRs ist die Verringerung gesundheitlicher Risiken im Rahmen des Konsums. Die Mitarbeiter geben Safer-Use-Hinweise[54] und stellen frische Konsumutensilien zur Verfügung. Durch die frischen Konsumutensilien kann das Infektionsrisiko für Krankheiten wie HIV und Hepatitis verringert werden. Zurhold et al. zeigen, dass die Zielgruppe der DKR besonders von der Infizierung mit diesen Infektionskrankheiten belastet ist[55], was oft auf den unhygienischen Konsum und die immer schlechter werdende Qualität der Substanzen zurückzuführen ist[56]. Somit ist dieser Effekt als besonders zentral zu betrachten. Des Weiteren können durch die ständige Anwesenheit der Mitarbeiter Überdosierungen schnell erkannt werden, sofort eingegriffen[57] und somit Todesfälle verhindert werden[58].

Die Chancen beziehen sich jedoch nicht nur auf die Öffentlichkeit oder stehen in direktem Bezug zu den Konsumvorgängen. DKR können auch für die Konsumenten und Nutzer Sicherheit schaffen und bilden einen Ort, in welchem sie die Möglichkeit haben, in Ruhe und ohne Angst zu konsumieren und sich aufzuhalten[59]. Denn durch die Abschottung der Öffentlichkeit, werden die Konsumenten in den Einrichtungen weder kriminalisiert noch stigmatisiert[60]. DKR bieten nicht nur Schutz vor der Polizei oder der Öffentlichkeit, sondern auch innerhalb der Drogenszene. So werden die Konsumenten beispielsweise vor Dealern oder „Fledderer“ beschützt, also Menschen, die sie in einem hilflosen Zustand bestehlen[61].

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass im Idealfall durch die Maßnahmen und Konzepte eines DKRs für alle Teilbereiche der Zielsetzung Verbesserungen erbracht werden können. Es ist dennoch kritisch anzumerken, dass diese Verbesserungen nicht äquivalent entstehen und es auch passieren kann, dass sich zwar ein Teilbereich, wie beispielsweise der Gesundheitszustand der Konsumenten, verbessert, im Gegenzug sich ein anderer Teilbereich, beispielsweise die Belastung der Öffentlichkeit, verschlechtert[62].

1.4.2 Bedenken

Zwar bietet die Einrichtung eines DKRs zahlreiche Chancen zur Verbesserung der Situationen der einzelnen Städte, jedoch kamen in der Vergangenheit immer wieder Bedenken in Bezug auf die Einrichtung eines solchen Angebots auf.

Besonders der Punkt, dass die Drogenszene durch einen DKR an einem Ort zentralisiert wird, warf Bedenken auf. So äußerte beispielsweise ein Vertreter des Polizeipräsidiums

[54] Vgl. Bergmann, H. et al. 2026, S. 5.
[55] Vgl. Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 111.
[56] Vgl. Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 129.
[57] Vgl. Ziele und Aufgaben von Drogenkonsumräumen, n.d..
[58] Vgl. Bergmann, H. et al. 2026, S. 4.
[59] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 119 f.
[60] Vgl. Bergmann, H. et al. 2026, S. 3.
[61] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 119 f.
[62] Vgl. Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 181.

Stuttgart in einer Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses des Gemeinderats Stuttgart 2018, dass durch die Zentralisierung eher weitere Probleme entstehen könnten. Als Grund sprach er an, dass in den konsumnahen Örtlichkeiten zunehmend drogennahe Delikte, wie die Beschaffungskriminalität, oder Drogenhandel stattfinden würden. Diese Aussage kann so verstanden werden, dass sich ein großer Teil der Drogenszene in das Umfeld der Einrichtung verlagern würde und dort v.a. das direkte Umfeld in Mittleidenschaft zieht. Somit wird hier eine Erhöhung der öffentlichen Belastung befürchtet. Diese Befürchtung wurde bereits aus dem direkten Umfeld einer Einrichtung in Hamburg geäußert. Hier wurde aufgeführt, dass ein DKR in der direkten Umgebung einen wirtschaftlichen Schaden für Geschäfte bringen kann[63]. Dies könnte daraus resultieren, dass durch die dort herrschende Drogenszene und den möglichen Andrang auf die Einrichtung[64] die Umgebung des DKRs gemieden wird und einen deutlich schlechteren Ruf bekommt, wodurch Geschäfte oder Gaststätten in der direkten Umgebung weniger Kundschaft verzeichnen würden.

Weitere Bedenken gab es in Bezug auf die Sogwirkung eines DKRs. Es wurde befürchtet, dass DKR eine Art Sogwirkung haben und Konsumenten aus dem Umland anziehen könnten[65]. Dies steht im Widerspruch zur Meinung, die in Stuttgart vertreten wurde. Hier wurde im Jahr 2018 bezweifelt, dass Suchtkranke aus den äußeren Stadtbezirken die Einrichtung aufgrund des weiten Anfahrtsweges nutzen würden. Es wurde eher befürchtet, nur einen engen Kreis der Konsumenten erreichen zu können[66]. Bezogen auf die Zielsetzung einer solchen Einrichtung ist anzumerken, dass gerade die Angliederung vieler Konsumenten und v.a. der Konsumentengruppe, die bisher wenig Kontakt zum Suchthilfesystem hat, der Zielsetzung eines DKRs entspricht. Beim Vergleich dieser beiden Aussagen ist zu beachten, dass sich die Zielgruppe eines DKRs nicht durch den tatsächlichen Wohnort definiert. Es wird vielmehr darauf geachtet, wo sich die Konsumenten regelmäßig aufhalten[67]. Somit gehört ein Konsument, der beispielsweise in einem äußeren Stadtteil von Stuttgart wohnt, sich aber täglich mehrere Stunden an typischen Szeneorten in der Stuttgart Innenstadt aufhält, eher zum potenziellen Nutzerkreis, als ein Konsument, der zwar in der Innenstadt wohnt, aber sehr zurückgezogen nur zu Hause konsumiert und Szeneorte meidet. Wenn mit dem Begriff „Umland“ jedoch eine andere Stadt mit einer eigenen Drogenszene ohne DKR gemeint ist, so gehört diese Konsumentengruppe nicht zur Zielgruppe des DKRs und könnte zu Problemen führen.

In den folgenden Kapiteln wird darauf eingegangen, inwiefern sich diese Bedenken verwirklicht haben und wie Konsumräume tatsächlich genutzt werden.

[63] Vgl. Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 181.
[64] Vgl. Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 137.
[65] Vesper, Johanes: Drogenkonsumräume mit unklarem Nutzen, in: Rheinisches Ärzteblatt, 2001.
[66] Vgl. Protokoll: Sozial- und Gesundheitsausschuss des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart, 2018, S. 3.
[67] Vgl. Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 82.

1.5 Nutzung und Auswirkung von Drogenkonsumräumen

1.5.1 Statistische Erhebung 2024

Im Folgenden wird sich auf die statistische Erhebung von Bergman et al. aus dem Jahr 2026 mit dem Datenjahr 2024 bezogen. KOMBO war zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb und ist nicht Teil dieser Statistik. Zum Zeitpunkt der Erhebung waren 33 DKR zumindest zweitweise in Betrieb. Die Erhebung hat gezeigt, dass im Jahr 2024 insgesamt 21.472 Personen deutschlandweit einen DKR besuchten und insgesamt 847.946 Konsumvorgänge durchführten. Durchschnittlich wären das ungefähr 39,5 Konsumvorgänge pro Nutzer im Jahr. Jedoch darf dieser Durchschnitt nicht auf das Individualverhalten einzelner Nutzer bezogen werden, denn unter den Nutzern gibt es große Unterschiede in der Nutzungshäufigkeit. Beispielsweise gab ein großer Teil der Nutzer von DKR im Jahr 2002 Poschadel et al. an, einen DKR mehrmals täglich oder mehrmals in der Woche zu nutzen[68]. Diese Konsumentengruppe hebt somit den Durchschnitt deutlich an.

Laut Bergmann et al. betrafen knapp die Hälfte der Konsumvorgänge 2024 den Konsum von Opioiden, wobei Heroin hier den größten Anteil bildete. Die Substanz Crack nahm dabei einen Anteil von ungefähr 24% und Kokain einen Anteil von ungefähr 12% ein. In den Konsumräumen wurde zu 60% inhalativ und nur zu 34% intravenös konsumiert, was mit dem großen Anteil an Heroinkonsum leicht im Widerspruch steht, da der intravenöse Konsum die Hauptkonsumform für den Heroinkonsum darstellt[69]. Dieser Widerspruch könnte sich mit dem unterschiedlichen Konsumverhalten von Konsumenten der einzelnen Substanzen erklären lassen. Zurhold et al. zeigten in ihrer Befragung, dass Konsumenten, die ihre Drogen rauchen, täglich öfter Konsumieren als Konsumenten, die ihre Drogen spritzen. So zeigte sich, dass täglich 3,3 bis 7,5-mal geraucht und nur 2,8-mal täglich intravenös konsumiert wird. Es kann also die Aussage getroffen werden, dass die meistkonsumierte Substanz zwar Heroin war, diese jedoch unter anderem eine der wenigen Substanzen ist, die mehrheitlich intravenös konsumiert wird. Somit ist das Inhalieren weiter verbreitet und wird von einem größeren Teil der Konsumenten, unabhängig von der Substanz, praktiziert.

Im Jahr 2024 verzeichneten die DKR insgesamt 750 Notfälle, aber keinen daraus resultierenden Todesfall. Notfälle definieren Bergmann et al. als „körperliche und psychische Situationen nach dem Konsum, die das Eingreifen von Mitarbeitern notwendig machen“[70]. Berechnet man hier ebenfalls den Durchschnitt, so kommt es ungefähr alle 1.131 Konsumvorgänge zu einem Notfall. Bei ungefähr 2.323 Konsumvorgängen am Tag wären das deutschlandweit zwei Notfälle pro Tag. Diese Zahlen zeigen, dass Notfallsituationen auch in geschützten Konsumbedingungen nicht selten vorkommen, aber durch die

[68] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 117.
[69] Vgl. Konsumformen: n.d. https://www.dhs.de/suechte/illegale-drogen/heroin/konsumformen/ aufgerufen: 05.08.2026 13:56 Uhr.
[70] Bergmann et al. 2026, S. 4.

ständige Anwesenheit des Personals schnell eingegriffen werden kann und schlimmere Folgen verhindert werden können.

Bergmann et al. verdeutlichen auch den Trend, dass die Beratungen, die im Rahmen des DKRs angeboten werden, vermehrt angenommen werden. Insgesamt wurden 122.412 Beratungsgespräche geführt, worunter sowohl Beratungen oder Vermittlungen in weiterführende Angebote als auch Safer-Use-Hinweise zusammengefasst werden. Es gilt zu berücksichtigen, dass für diese Zahl lediglich Angaben von 23 Konsumräumen vorlagen und davon auszugehen ist, dass die tatsächliche Anzahl an Beratungen höher war. Kritisch anzumerken ist jedoch, dass diese Erhebung nur die Annahme der Angebote beleuchtet. Aus den Daten ist nicht ersichtlich, wie viele der durchgeführten Beratungen eine tatsächliche Verbesserung des Konsumverhaltens oder der Suchtbelastung der Konsumenten zur Folge hatte.

Bergmann et al. verdeutlichen also, dass Nutzer nicht nur zum Konsumieren den DKR aufsuchen, sondern durchaus auch die weiteren Angebote nutzen. In der statistischen Erhebung wurde dennoch nicht erhoben, wie groß der Anteil der Nutzer zum Anteil der tatsächlichen Konsumenten in den einzelnen Städten war. Aufgrund dessen kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob die DKR auch Konsumenten ansprachen, die außerhalb des DKRs zuvor keine weiteren Hilfsangebote in Anspruch nahmen.

1.6 Kritik an Drogenkonsumräumen

Die Literatur und Erfahrungsberichte der bisher bestehenden DKR besprechen zahlreiche Kritikpunkte. In diesem Kapitel werden die zentralen Kritikpunkte herausgearbeitet und diskutiert, auf die später im Experteninterview Bezug genommen wird.

1.6.1 Angesprochene Zielgruppe

Einer der zentralen Kritikpunkte an DKR ist, dass der Frauenanteil unter den Nutzern eines DKR auffallend gering ist[71]. Gem. Bergmann et al. verzeichneten die DKR 2024 einen Anteil von 83% männlicher Nutzer[72]. In der Evaluation von Poschadel et al. wurde von einem Frauenanteil zw. 11,6% und 26% unter allen Konsumvorgängen gesprochen[73]. Aus dem Grund, dass diese Zahlen bereits im Jahr 2002 erhoben wurden, lässt sich sagen, dass sich dieses Problem über die Jahre nicht geändert hat und bis heute besteht. Als möglichen Grund sehen Bergmann et al., dass Frauen als Nutzer von Konsumräumen oft andere Barrieren überwinden müssen als Männer. Diese Barrieren sind beispielsweise die Angst vor Sorgerechtsverlust der eigenen Kinder, Stigmatisierung oder Gewalterfahrungen. Als mögliche Verbesserungen werden Öffnungszeiten angebracht, zu welchen ausschl. Frauen den DKR nutzen dürfen[74]. Poschadel et al. haben bereits 2002 gezeigt, dass

[71] Vgl. Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 63.
[72] Vgl. Bergmann et al. 2026, S. 7.
[73] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 128.
[74] Vgl. Bergmann et al. 2026, S. 12.

Konsumräume mit frauenspezifisichen Angeboten tendenziell öfter von Frauen genutzt werden[75].

1.6.2 Weiterhin starke Belastung der Öffentlichkeit

Ein weiterer Bereich der Kritik an DKR betrifft die teilweise weiterhin bestehende Belastung der Öffentlichkeit. Erfahrungen haben gezeigt, dass trotz der Einrichtung von Konsumräumen der Konsum in der Öffentlichkeit nicht zwingend weniger wird und sich sogar im Umfeld erst dadurch bilden kann. Dies hatte in der Vergangenheit oft den Grund, dass sich erhofft wurde, die offene Drogenszene durch die Einrichtung eines DKRs aufzulösen. Aufgrund dessen wurden Teile der Innenstadt für die Szene gesperrt, ohne einen gleichwertigen öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen. Dies resultierte darin, dass sich die Drogenszene in und um den DKR verlagerte, die Beschaffungskriminalität und der Konsum in der Öffentlichkeit anstieg, was zu Konflikten mit dem Umfeld führte[76]. Diese Bewegung hatte dann eine Überlastung der Einrichtungen zur Folge und führte dazu, dass personelle Ressourcen an ihre Grenzen kamen[77]. Kommen die personellen Ressourcen an ihre Grenzen, können die Mitarbeiter nicht mehr auf aktuelle Entwicklungen in der Szene reagieren[78] und die Qualität der Arbeit sinkt[79]. Poschadel et al. gegenüber wurde geäußert, dass diese Bewegungen teilweise Umsatzrückgänge für Gaststätten und Geschäfte in der Nähe des DKRs zur Folge hatten. Zudem sei ein Verfall der Immobilienpreise zu verzeichnen gewesen[80]. Die Erfahrungsberichte liegen zwar jeweils 24 oder 25 Jahre zurück, jedoch zeigen sie, dass die zuvor geschilderten Bedenken durchaus eintreten können, beziehungsweise in der Vergangenheit bereits eingetreten sind. Solche Erfahrungsberichte gab es jedoch nur vereinzelt und sind nicht auf jede Einrichtung übertragbar. Denn es hängt stark davon ab, in welcher Umgebung und wo ein DKR eingerichtet wird. Beispielsweise stellten Zurhold et al. einen Erfahrungsbericht einer Hamburger Einrichtung dar, die einen sehr starken Anstieg der Öffentlichkeitsbelastung zu verzeichnen hatte[81]. Aus dieser Erfahrung ergab sich die Schlussfolgerung, dass Konsumräume möglichst anwohnerfern angesiedelt sein sollten[82].

Ein weiterer Grund für den weiteren Drogenkonsum in der Öffentlichkeit bildet v.a. aus Konsumentensicht die mangelnde Verfügbarkeit von DKR. Hiermit ist nicht das Fehlen einer Einrichtung gemeint, sondern, dass bereits bestehende Einrichtungen zum Zeitpunkt des Konsums nicht zur Nutzung verfügbar waren. Beispielsweise wenn der DKR geschlossen ist, sie eine zu lange Wartezeit haben, der DKR zu weit entfernt ist oder die Konsumenten zu starke Entzugssymptome haben, um einen DKR aufzusuchen. Das

[75] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 128.
[76] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 133.
[77] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 43.
[78] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 64.
[79] Vgl. Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 162.
[80] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 48 f.
[81] Vgl. Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 195 ff.
[82] Vgl. Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 207.

größte Problem seien aus Konsumentensicht jedoch die Öffnungszeiten der Einrichtungen[83]. Zurhold et al. sind der Meinung, dass die Öffnungszeiten eines DKRs lebenswelt- und bedarfsorientiert ausgerichtet sein müssen, also an die Konsumgewohnheiten angepasst. Nur so könnten sie ein relevantes Steuerungsinstrument darstellen[84]. Ein wichtiges Ergebnis von Zurhold et al. ist, dass ihre Befragung von Hamburger Konsumenten gezeigt hat, dass 36% der Befragten in der Nähe zum Beschaffungsort konsumieren[85]. Somit kommt es zwar zum einen auf die Öffnungszeiten der Einrichtung an, aber auch auf den Standort der Einrichtung, beziehungsweise Nähe zur Szene. Somit ist ebenfalls fraglich, ob eine Szenenbildung um den entsprechenden DKR zwingend ein Problem darstellt. Denn verlagert sich die Drogenszene in die Umgebung des DKRs, so kann davon ausgegangen werden, dass sich ebenfalls Dealer in dieser Umgebung aufhalten und die Konsumenten zwingend in die Umgebung des DKRs müssen, um sich die Btm zu beschaffen. So könnte, zumindest aus der Perspektive der Nutzung des DKRs, eine größere Gruppe an Konsumenten erreicht und zu einer Nutzung der Einrichtung verleitet werden.

Dieser Gedanke leitet direkt zum nächsten Punkt über. Oft haben DKR hohe Auflagen und Zugangsbeschränkungen, sodass Konsumenten teilweise gezwungen würden, in der Öffentlichkeit zu konsumieren. Diese Zugangsbeschränkungen könnten beispielsweise den Wohnort umfassen[86] oder auch, wie es Zurhold et al. erarbeitet haben, eine zusätzliche Belastung durch Straßenprostitution oder Obdachlosigkeit voraussetzen[87]. Grundsätzlich (grds.) sollte jedoch, in Hinblick auf die Zielsetzung, der Zugang zu DKR so niedrigschwellig wie möglich sein, ansonsten sei der Konsum in der Öffentlichkeit vorprogrammiert[88]. Wurden die Zugangsbeschränkungen überwunden, so führte das nächste Hindernis zu einer Vermeidung eines DKRs. In vielen Konsumräumen werden und wurden bereits in der Vergangenheit die Nutzer namentlich registriert[89]. Diese Deanonymisierung hat für die Einrichtungen zahlreiche positive Effekte, jedoch schreckt sie auch Nutzer ab[90]. Der positive Nutzen für die Einrichtung liegt v.a. in der steigenden Verbindlichkeit von Regeln. Dadurch könnten Regeln einfacher durchgesetzt und eingehalten werden[91]. Es ist fraglich, ob für die Einhaltung der Regeln den tatsächlichen Klarnamen jeder Person benötigt wird oder ob lediglich ein Deckname ausreicht. Denn für die Einhaltung der Regeln ist nicht der Name, sondern die eindeutige Zuordnung zur Person notwendig[92]. Verzichtet man auf eine volle Deanonymisierung durch Erhebung des Klarnamens, könnte ebenfalls die Nutzerzahl von Konsumräumen erhöht werden.

[83] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 120 f.
[84] Vgl. Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 59.
[85] Vgl. Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 107.
[86] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 133.
[87] Vgl. Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 66.
[88] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 134.
[89] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 70.
[90] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 123.
[91] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 70.
[92] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 134 f.

2 Rechtlicher Rahmen des Drogenkonsumraums

Der rechtliche Rahmen des DKRs wird sowohl durch §10a BtMG als auch durch die Rechtsverordnung über den Betrieb von DKR des entsprechenden Bundeslandes geregelt. Im Folgenden wird zunächst die Entstehungs- und Änderungsgeschichte des §10a BtMG dargestellt. Daraufhin werden die Vorschriften des §10a BtMG erläutert und diese dann in Bezug auf die Rechtsverordnungen des Landes BW zum Betrieb von DKR gesetzt. Zum Schluss wird die Umsetzung in der Praxis geprüft.

2.1 §10a BtMG

2.1.1 Entstehungsgeschichte des §10a BtMG

§10a BtMG wurde durch das dritte Gesetz zur Änderung des BtMG vom 28. März 2000 eingeführt. Dieses wurde am 31. März 2000 verkündet und trat am 1. April 2000 in Kraft[93]. Betrachtet man die Geschichte der DKR in Deutschland, so fällt auf, dass bereits vor Inkrafttreten einer rechtlichen Grundlage zum Betrieb eines DKRs DKR in Deutschland betrieben wurden. Diese Einrichtungen operierten zu dieser Zeit jedoch in einer „rechtlichen Grauzone“[94] und der Betrieb dieser Einrichtungen war in der juristischen Literatur sehr umstritten. Ein großer Teil der Literatur bejahte die Strafbarkeit der Betreiber gem. §29 (1) S. 1 Nr. 10 BtMG alte Fassung (a.F.)[95]. Gem. dieser Vorschrift machte sich unter anderem strafbar, wer eine Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch, Erwerb oder zur unbefugten Abgabe von Btm verschafft[96]. Die Akzeptanz der Einrichtungen variierte je nach Standort. So konnten Konsumräume in Frankfurt beispielsweise durch Duldung der Staatsanwaltschaft (StA) und Rückendeckung der Politik betrieben werden, was in Hamburg nicht der Fall war[97]. Aufgrund dessen wurde im Jahr 1999 der Bedarf einer gesetzlichen Regelung des Betriebs von DKR deutlich. Es kamen Bestrebungen auf, die Eröffnung und den Betrieb von DKR künftig nach einem näher geregelten Erlaubnisverfahren durchzuführen, um durch qualifizierte Beratung und Hilfeleistung die bestmögliche Sicherheit und Kontrolle beim Konsum der Btm zu gewährleisten[98]. Der in Kraft getretene §10a BtMG a.F. ging auf Gesetzesentwürfe der Fraktion der SPD und Bündnis 90/Die Grünen[99] und der Bundesregierung der 14. Legislaturperiode[100] zurück. Die Gesetzesentwürfe verdeutlichen ein Umdenken in der damaligen Drogenpolitik, in der man von nun an die Abhängigkeit als eine Krankheit anerkannte[101]. Im Entwurf der SPD und Bündnis 90/Die Grünen wurde eingeräumt, dass eine einfache Korrektur der strafrechtlichen Verbote, hier also des §29 (1) S. 1 Nr. 10 BtMG, nicht ausreichen würde, um die

[93] BGBl. 2000 I Nr. 13.
[94] Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 16.
[95] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 11.
[96] Vgl. BGBl. 1994 Nr. 13, S. 367.
[97] Vgl. Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 46.
[98] Vgl. BT-Drs. 14/1515, S. 6.
[99] Vgl. BT-Drs. 14/1515.
[100] Vgl. BT-Drs. 14/1830.
[101] Vgl. BT-Drs. 14/2345, S. 9.

rechtlichen Grenzen des Betreibens von DKR ausreichend zu bestimmen[102]. Es bedürfe viel mehr einer bundeseinheitlichen Regelung, um einheitliche Rahmenbedingungen für das Eröffnen und Betreiben von DKR zu schaffen[103]. Bei der Gesetzgebung wurde ebenfalls berücksichtigt, dass die örtlichen Drogensituationen variieren können. Ein DKR könne also nicht ohne Berücksichtigung der dort herrschenden Probleme, der bereits vorhandenen Hilfsangebote und der finanziellen Gesamtplanung der Suchtkrankenhilfe eröffnet werden[104], weshalb vorgesehen wurde, die Umsetzung der Konsumräume den Landesregierungen zu übertragen und lediglich Mindeststandards der dafür nötigen Landesverordnungen festzulegen.

Ziel der Einführung des §10a BtMG war es also, Rechtsklarheit über den Betrieb von bereits bestehenden und die Einrichtung weiterer DKR zu schaffen. Mit dem dritten Gesetz zur Änderung des BtMG wurde zum einen der §10a BtMG eingeführt und zum anderen der §29 (1) S. 1 Nr. 10, 11, 13, 14 BtMG überabeitet. Durch die Überarbeitung des §29 (1) S. 1 Nr. 10 BtMG wurde das „Verschaffen einer Gelegenheit“ aus Nummer (Nr.) zehn in Nr. elf verschoben[105]. Gem. §29 (1) S. 1 Nr. 11 BtMG ist das Verschaffen einer Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch nur strafbar, wenn keine Erlaubnis nach §10a BtMG vorliegt oder sie außerhalb einer Einrichtung nach §10a BtMG verschafft wird[106]. Das Verschaffen einer Gelegenheit zum unbefugten Erwerb oder zur unbefugten Abgabe bleibt jedoch gem. §29 (1) S. 1 Nr. 10 BtMG verboten. Dies lässt darauf schließen, dass DKR aus Sicht des Gesetzgebers ebenfalls keine Umschlagplätze der örtlichen Drogenszene darstellen sollen. Vielmehr soll der gesundheitliche und ordnungspolitische Nutzen der Einrichtungen klar im Fokus stehen.

Ein Problemfeld der Einführung des §10a BtMG waren jedoch die bereits betriebenen DKR. Denn gem. §10a (1) BtMG benötigen die Betreiber eines DKRs eine Erlaubnis der zuständigen obersten Landesbehörde. Diese Erlaubnis kann jedoch nur erteilt werden, wenn die Landesregierungen die Voraussetzungen für die Erteilung dieser Erlaubnis in einer Rechtsverordnung nach §10a (2) BtMG geregelt haben. Die Betreiber der bereits bestehenden DKR erfüllten somit zwar nicht mehr den Straftatbestand des §29 (1) S. 1 Nr. 10 BtMG, handelten aber auch nicht auf Basis einer Rechtsverordnung ihrer entsprechenden Landesregierung. Dieses Problem wurde in den Gesetzesentwürfen ebenfalls berücksichtigt. Da eine Aussetzung des Betriebs bis zur Erteilung einer Erlaubnis kontraproduktiv erschien[107], wurde §39 BtMG als Übergangsvorschrift geschaffen. Hiernach dürfen diese Einrichtungen weiter bestehen, wenn innerhalb von 24 Monaten nach Inkrafttreten des dritten BtMG-Änderungsgesetzes eine Rechtsverordnung nach §10a (2) BtMG erlassen und ein Antrag auf Erlaubnis nach §10a (1) BtMG gestellt wird. Bis zu

[102] Vgl. BT-Drs. 14/1515, S. 2.
[103] Vgl. BT-Drs. 14/1515, S. 6.
[104] Vgl. BT-Drs. 14/1515, S. 6.
[105] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 23.
[106] Vgl. BGBl. 2000 I Nr. 13, S. 303.
[107] Vgl. BT-Drs. 14/1515, S. 9.

einer Entscheidung über den Antrag müssen sich die Einrichtungen an die Standards des §10a (2) BtMG oder an ihre erlassene Rechtsverordnung halten. Diese Norm lässt darauf schließen, dass die Wichtigkeit, beziehungsweise die Vorteile, einer solchen Einrichtung insofern anerkannt waren, dass eine Schließung aufgrund einer fehlenden Regelung vermieden werden sollte.

Durch §10a BtMG wurde also ein bundeseinheitlicher Rahmen für den erlaubten Betrieb von DKR geschaffen. Die Umsetzung wurde jedoch auf die Landesregierungen übertragen.

2.1.2 Überarbeitung des §10a BtMG

Der §10a BtMG wurde bisher einmal im Jahr 2023 durch das Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) überarbeitet. Durch die Überarbeitung wurde der ursprüngliche Absatz vier gestrichen und in den neuen §10b BtMG verschoben. Der ehemalige §10a (4) BtMG regelte das Verbot zur Durchführung von Substanzanalysen der mitgeführten Btm und der aktiven Hilfeleistung beim Konsum der Btm, wie beispielsweise das Abbinden des Armes oder das Desinfizieren der Einstichstelle[108]. Diese Regelung sollte klarstellen, „dass das Verschaffen einer Gelegenheit zum Drogenkonsum nicht zu den vorrangigen Aufgaben eines Drogenkonsumraums […] gehört […]“[109] (gekürzt durch den Verfasser). Bei einer Substanzanalyse, auch „Drug-Checking“ genannt, handelt es sich nach §10b (1) BtMG um eine „qualitative und quantitative chemische Analyse von mitgeführten, nicht ärztlich […] verschriebenen Btm“. Solche Angebote bestehen bereits seit mehreren Jahren in anderen europäischen Ländern, wie beispielsweise in den Niederlanden. Dort haben sich diese Angebote etabliert und stellen eine wirkungsvolle Maßnahme der Prävention und Schadensreduzierung dar[110]. Der Bedarf für solche Angebote in Deutschland kam erstmals im Jahr 2010 auf. In einem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen aus dem Jahr 2010 wurde thematisiert, dass in den vorangegangenen Jahren vermehrt giftige Beimengungen, wie beispielsweise Milzbrandleger oder auch andere Drogen[111], in Kokain, Opiaten, Cannabis und synthetischen Partydrogen gefunden wurden[112]. Da sich Konsumenten dieser Drogen über den illegalen Drogenmarkt versorgen, haben sie keine Kenntnis über den Wirkstoffgehalt der Substanzen, was das Risiko für Überdosierungen konstant hochhält. Darüber hinaus besteht dadurch zu jedem Zeitpunkt das Risiko für besagte giftige Beimengungen, wovon oftmals eine größere Gefahr ausgeht als von den Substanzen selbst[113]. Genau diesem Risiko sollen Substanzanalysen entgegenwirken. Durch die chemische Analyse der Substanz können also Informationen über giftige Beimengungen erlangt und an den Konsumierenden weitergegeben werden. Die Kenntnis über die Stoffzusammensetzung soll

[108] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 30.
[109] BT-Drs. 14/1515, S. 7.
[110] Vgl. BT-Drs. 20/7397, S. 69.
[111] Vgl. BT-Drs. 19/28774, S. 1.
[112] Vgl. BT-Drs. 17/2050, S. 1.
[113] Vgl. BT-Drs. 19/28774, S. 1.

dann beim Konsumenten das objektiv bestehende Gefahrenpotential verdeutlichen[114] und so einer eventuellen Überdosierung oder sogar dem gesamten Konsum[115] vorbeugen. Diese Zielsetzung wurde in §10b (1) BtMG verankert und verpflichtet zu einer „Risikobewertung und gesundheitliche[n] Aufklärung über die Folgen des Konsums für die Btm besitzende Person […]". Dadurch geht das Drug-Checking über eine einfache Substanzanaylse hinaus und verdeutlicht die Zielsetzung des Gesetzgebers, das Gesundheitsrisiko der Drogenkonsumenten zu verringern[116]. Die Kenntnis über die Stoffzusammensetzung ist aber nicht nur für die Konsumentenseite sinnvoll. Sie dient auch den Gesundheits-, Ordnungs- und Sicherheitsbehörden dafür, Informationen darüber zu sammeln, welche Stoffe auf dem Drogenmarkt gehandelt werden, und schafft die Möglichkeit, potenzielle Konsumenten vor den Substanzen zu waren[117].

Eine weitere Chance von Drug-Checking-Angeboten wurde darin gesehen, potenzielle oder schwer zu erreichende Konsumenten anzusprechen, die auf dem klassischen Weg der Drogenhilfe nicht erreicht werden[118]. Diese Hoffnung deckt sich mit den Erfahrungen anderer Länder[119]. Grundlegend dafür ist v.a., dass sich diese Angebote primär an Konsumenten von „Freizeitdrogen" in der Partyszene richten[120] und als gute Grundlage, um mit den Konsumenten ins Gespräch zu kommen und klassische Safer-Use-Hinweise weiterzugeben, gesehen werden können[121]. Drug-Checking Angebote werden also primär unabhängig von DKR betrieben. Es liegt jedoch nahe, dass solche Angebote auch in der Nähe von, oder direkt in DKR eingerichtet werden[122]. §10b BtMG trifft darüber keine Konkretisierung.

Die Einrichtung eines Drug-Checking-Modellvorhabens funktioniert analog zu §10a BtMG über eine Erlaubnis der zuständigen obersten Landesbehörde aufgrund einer erlassenen Landesverordnung. Jedoch verpflichtet §10b (2) S. 1 BtMG die Landesbehörden zum Erlassen einer Landesverordnung[123]. Die verpflichtende Ermächtigung hat den Grund, dass auf diese Weise sichergestellt werden kann, dass Drug-Checking-Modellvorhaben in allen Ländern geschaffen werden und diese zeitnah umgesetzt werden können[124]. Somit sind Landesgesetzgeber nicht nur verpflichtet, eine neue Landesverordnung für die Modellvorhaben zu erlassen, sondern auch, falls darin aufgenommen, das Verbot der Substanzanalyse in Verordnungen gem. §10b (2) BtMG zu streichen[125].

---

[114] Vgl. BR-Drs. 643/20, S. 2.
[115] Vgl. BT-Drs. 17/2050, S. 2.
[116] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen, 31. Ed. 15.6.2026, BtMG, §10b Rn. 9.
[117] Vgl. BR-Drs. 643/20, S. 2.
[118] Vgl. BT-Drs. 19/28774, S. 1.
[119] Vgl. BT-Drs. 20/7397, S. 69.
[120] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10b Rn. 2.
[121] Vgl. BT-Drs. 19/28774, S. 3.
[122] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10b Rn. 8.
[123] Vgl. BT-Drs. 20/7397, S. 70.
[124] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10b Rn. 7.
[125] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 29.1.

Durch das Streichen des ehemaligen Absatzes vier ist ebenfalls das Verbot der aktiven Konsumhilfe aufgehoben. Das Personal in DKR kann nun also, entsprechend dem Harm-Reduction-Ansatz, über die hygienischen Konsumbedingungen hinaus tätig werden, sollte es im Einzelfall notwendig sein[126].

2.1.3 Regelungen des §10a BtMG

Wie bereits zuvor erörtert, handelt es sich bei §10a BtMG um keine bundeseinheitliche Regelung über Voraussetzungen für die Umsetzung eines DKRs[127]. §10a BtMG ermächtigt die Landesregierungen gem. Art. 80 (1) GG zum Erlassen von Landesverordnungen und schafft für diese einen bundeseinheitlichen Rahmen durch die einzuhaltenden Mindeststandards.

2.1.3.1 Absatz 1

Absatz eins Satz eins regelt die Voraussetzung einer Erlaubnis der zuständigen obersten Landesbehörde, welche nach Bohnen „in der Regel die für die Gesundheit zuständigen Ministerien“ sind[128], und liefert eine Legaldefinition eines DKRs (s.h. 1.1.1. Definition). In der Legaldefinition finden sich mehrere zu erläuternde Begriffe.

Eine Erlaubnis kann gem. der Definition nur Einrichtungen erteilt werden. Nach Bohnen sind Einrichtungen „Organisationen, in denen sachliche und persönliche Mittel zu einem bestimmten Zweck bereitgestellt werden“[129]. Somit ist das Erteilen einer Erlaubnis an eine Einzelperson, wie beispielsweise Ärzte, Drogentherapeuten oder Sozialarbeiter[130], die in ihren Räumen den Drogenkonsum dulden, ausgeschlossen[131]. Es ist jedoch nicht geregelt, dass diese Organisation zwingend öffentliche Mittel in Anspruch nehmen muss, weshalb auch private Organisationen Träger eines DKRs sein können[132]. Nach Patzak ist lediglich eine „Drogenhilfe-Vereinigung, die aufgrund ihrer personellen, sachlichen und finanziellen Ausstattung in der Lage ist, eine Vielzahl von Drogenabhängigen zu betreuen“[133] erforderlich.

Gem. der Definition dürfen nur mitgeführte, ärztlich nicht verschriebene Btm konsumiert werden. Somit darf das mitgeführte Btm nur von der Person konsumiert werden, die das Btm zuvor in den DKR mitgebracht hat. Hier wird also die Unzulässigkeit des Teilens und der Weitergabe von Btm deutlich[134]. Die Eingrenzung der ärztlich nicht verschriebenen Btm legt einen Rahmen der zum Konsum geduldeten Substanzen fest. Somit ist der Konsum beispielsweise von Substitutionsdrogen wie Methadon oder Diamorphin, wenn

[126] Vgl. BT-Drs. 20/7397, S. 70.
[127] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 12.
[128] BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 12.2.
[129] BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 16.
[130] Vgl. Patzak/Fabricus/Patzak, 11. Aufl. 2024, BtMG §10a Rn. 10
[131] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 16.
[132] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 16.
[133] Patzak et al. 2024, §10a Rn. 10.
[134] Vgl. Weber/Kornprobst/Maier/Dietsch/Weber/Dietsch, 7. Aufl. 2025, BtMG §10a Rn. 29.

sie ärztlich verschrieben wurden, im DKR nicht gestattet[135]. Außerdem ist der Konsum von Btm, die nicht in das Anlagesystem des BtMG aufgenommen wurden, nicht gestattet, da diese gem. §1 (1) BtMG keine Btm im Sinne des BtMG sind. Diese Regelung ist insbesondere bei neuen psychoaktiven Stoffen im Sinne des NpSG zu beachten[136] , welche bisher nicht im Anlagensystem des BtMG aufgeführt sind.

Satz zwei geht auf die Voraussetzung für die Erteilung einer Erlaubnis ein. Eine Erlaubnis kann demnach nur erteilt werden, wenn die Landesregierung die Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis in einer Rechtsverordnung, welche der Maßgabe des Absatzes zwei entsprechen muss, geregelt hat.

2.1.3.2 Absatz 2

Satz eins des Absatzes zwei ermächtigt die Landesregierungen zum Erlassen einer Rechtsverordnung, die die Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis nach Absatz eins regelt. Aus dieser Ermächtigung geht jedoch keine Verpflichtung hervor, weshalb es den Landesregierungen hier freisteht, eine solche Rechtsverordnung zu erlassen[137]. Satz zwei enthält eine Aufzählung von zehn Mindeststandards, die die erlassenen Rechtsverordnungen beinhalten müssen. Diese Mindeststandards beziehen sich auf die Sicherheit und Kontrolle beim Verbrauch von Btm in DKR. Wichtig zu erwähnen ist hier, dass es sich um keine abschließende Aufzählung handelt. Die Mindeststandards bestimmen vielmehr gem. Art. 80 (1) S. 2 GG Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung, „ohne letzte Einzelheiten festzulegen“[138] und können durch die Landesregierungen ergänzt werden[139]. Somit wird den entsprechenden Landesregierungen der Freiraum eröffnet, beim Einhalten der Mindeststandards, die Verordnungen an ihre Drogenpolitik und Drogensituation anzupassen. Im Folgenden werden diese Mindeststandards aufgezählt und ausgewählte näher erläutert, deren praktische Umsetzung im weiteren Verlauf relevant bleibt.

2.1.3.2.1 Mindeststandards

Nr. zwei setzt eine sofort einsatzfähige medizinische Notfallversorgung voraus. Hierfür muss nicht zwingend ein Arzt im DKR anwesend sein. Ausreichend sei vielmehr, wenn geschultes Personal Erste Hilfe leisten könne und ein Notarzt, beziehungsweise ein Ambulanzfahrzeug schnell erreichbar ist[140].

Nr. drei und vier regeln die vom Personal anzubietenden und durchzuführenden Beratungen. Nr. drei verpflichtet zur medizinischen Beratung und Hilfe zum Zwecke der Risikominimierung beim Konsum der Btm, also zur typischen Safer-Use-Beratung. Daran an-

[135] Vgl. Patzak et al. 2024, §10a Rn. 13.
[136] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 22.
[137] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 13.
[138] BT-Drs. 14/2345, S. 10.
[139] Vgl. Patzak et al. 2024, §10a Rn. 19.
[140] Vgl. BT-Drs. 14/2345, S. 10.

knüpfend bezieht sich Nr. vier auf die Vermittlung von weiterführenden und ausstiegsorientierten Angeboten. Diese Beratung geht über die Beratung der Nr. 3 hinaus und vermittelt an Angebote weiter, die auf Abstinenz abzielen[141]. Bohnen sieht darin das wiederkehrende Prinzip der Drogenfreiheit[142]. Somit gehört auch für den Bundesgesetzgeber sowohl die Verbesserung des Gesundheitszustandes der Konsumenten als auch die Ausstiegshilfe zu den zentralen Zielen eines DKRs. Dadurch, dass hier gezielt von einer „Vermittlung" gesprochen wird, ist hier ebenfalls die Voraussetzung für spezialisierte Konsumräume (s.h. 1.1.1. Definition) geschaffen. Die ausstiegsorientierten Angebote müssen also nicht direkt an den DKR angegliedert sein, sondern die Mitarbeiter können an Angebote des gesamten Suchthilfesystems vermitteln[143].

Nr. fünf und sechs legen die Verhinderung von Straftaten, sowohl im DKR selbst als auch im unmittelbaren Umfeld des DKRs fest. Nr. fünf bezieht sich v.a. auf den DKR selbst. Es wird gefordert, Maßnahmen zur Verhinderung von Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz zu regeln, mit Ausnahme des Besitzes von Btm nach §29 (1) S. 1 Nr. 3 BtMG zum Eigenverbrauch in geringer Menge. Der Wortlaut der „Verhinderung" setzt ein aktives Tun voraus. Es müssen also Konkretisierungen gemacht werden, wie die Straftaten zu unterbinden sind[144]. Hier wird explizit von Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz gesprochen, weshalb Maßnahmen zur Verhinderung sonstiger Straftaten nicht vorgesehen werden müssen[145]. Da es nach Katholnigg aber nicht die Intention des Gesetzgebers sein kann, sonstige Straftaten zuzulassen, können in den Rechtsverordnungen allgemeine Maßnahmen zur Verhinderung von Straftaten festgelegt werden[146]. Die mitgeführten Drogen müssen dem Eigenverbrauch dienen. Hier wird die Vorschrift der Legaldefinition erneut aufgegriffen, dass die Weitergabe an andere Personen unzulässig ist und lediglich die Person, die das Btm mitführt, es auch konsumieren darf. Die „geringe Menge" wird nicht näher definiert. Das Oberlandesgericht Hamm geht hier jedoch von bis zu drei Konsumeinheiten aus[147]. Nach Bohnen bleibt der Besitz auch weiterhin geduldet, sollte ein Besucher beispielsweise nach erfolgter Beratung vom Konsum absehen[148]. Nr. sechs bezieht sich auf die Verhinderung von Straftaten im unmittelbaren Umfeld, wofür die Betreiber die Zusammenarbeit mit den für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständigen örtlichen Behörden, i.d.R. Polizei und Ordnungsbehörden[149] festlegen müssen. Der Begriff „unmittelbares Umfeld" ist hier bewusst vage formuliert, da die genaue örtliche Lage der DKR beim Erlass der Rechtsverordnung oftmals nicht feststeht[150]. So

[141] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 40.
[142] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 40.1.
[143] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 42.
[144] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 45.
[145] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 43.
[146] Vgl. Katholnigg (NJW 2000): Die Zulassung von Drogenkonsumräumen und strengere Kriterien bei der Substitution – das dritte Gesetz zur Änderung des BtMG.
[147] Vgl. OLG Hamm Beschl. V. 17.3.2009 – 3 Ss 15/09, BeckRS 2009, 12921.
[148] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 18.
[149] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 51.
[150] Vgl. Weber et al. 2025, §10a Rn. 84.

wird demnach weniger eine Bestimmung anhand von Abständen gefordert. Nach Bohnen ist das Gebiet eingeschlossen, auf das der DKR noch Auswirkungen hat[151]. Da die Lage, bezogen auf die Anbindung an das Stadtgebiet und sonstige öffentliche Plätze in der Umgebung der Einrichtungen, für jede Einrichtung variiert, ist dieses Gebiet für jeden DKR individuell zu bestimmen. Anders als in Nr. fünf wird hier keine Abgrenzung für Straftaten des BtMG vorgenommen. In Betracht der Maßnahmen kommen also auch alle Formen der Beschaffungs- und Folgekriminalität. Durch diese Vorschrift wird also deutlich, dass DKR keinen rechtsfreien Raum darstellen sollen und Straftaten, die über den geduldeten Rahmen hinausgehen, entgegengewirkt wird. Somit wird eine Szenenbildung, ausgelöst durch den DKR, zumindest gesetzlich unterbunden.

Nach Nr. sieben muss der Benutzerkreis genau festgelegt werden. Diese Festlegung umfasst insbesondere das Alter, die Art der mitgeführten Drogen und die geduldeten Konsummuster. Außerdem sind offenkundige Erst- und Gelegenheitskonsumenten von der Benutzung auszuschließen. Diese Vorschrift gibt den Landesregierungen möglichst viel Freiheit, ihre Drogenpolitik umzusetzen[152] und ihre eigene Zielgruppe zu definieren. Es werden weder weitere Konkretisierungen zu Substanzen noch zu Konsumformen gemacht, wodurch die Landesregierungen auch dies individuell, an die örtliche Drogensituation angepasst, festlegen können. Diese offene Formulierung kann dazu führen, dass beispielsweise die geduldeten Substanzen oder das Mindestalter zw. zwei Bundesländern variieren können. Wird beispielsweise ein Btm konsumiert, das nicht in der Rechtsverordnung aufgeführt ist, so gelten für diesen Konsumvorgang die allgemeinen Regeln der Strafbarkeit[153]. Die Abgrenzung, dass offenkundige Erst- und Gelegenheitskonsumenten ausgeschlossen werden müssen, ist eine Wiederholung der Regelung aus der Legaldefinition des §10a (1) S. 1 BtMG, dass Konsumräume nur von Betäubungsmittelabhängigen genutzt werden dürfen[154]. Der Ausschluss verlangt ein aktives Tun des Personal, weshalb sich das Personal von der Betäubungsmittelabhängigkeit der Nutzer überzeugen muss[155]. Wie die Kontrollen dieser Nutzungsvoraussetzung ausfallen, wird nicht geregelt.

2.1.3.3 Absatz 3

Absatz drei regelt das Erlaubnisverfahren, welches vor Erteilung der Erlaubnis durch die oberste Landesbehörde zur Einrichtung eines DKRs durchlaufen werden muss. Hier werden abschließend §7 S. 1 und 2 Nr. 1 bis 4 und 8, §§8, 9 (2) und §10 BtMG aufgezählt. Jedoch tritt an Stelle des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) jeweils die zuständige oberste Landesbehörde und an die Stelle der obersten Landesbehörde jeweils das BfArM. Dieser Tausch kann an §8 (1) BtMG veranschaulicht werden. So trifft hier, statt des BfArM, die oberste Landesbehörde die Entscheidung über die Erlaubnis und unterrichtet das BfArM über die Entscheidung. §§5 und 6 BtMG wurden nach

[151] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 50.
[152] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 59.
[153] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 65.
[154] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 62.
[155] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 17.

Patzak et al. bewusst nicht übernommen, „da in DKR spezielle Voraussetzungen für die Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs erforderlich sind“[156]. An die Stelle der §§5 und 6 BtMG treten teilweise die Mindeststandards[157]. Verstößt die antragstellende Organisation gegen §10a (3) BtMG und die darin aufgezählten Vorschriften, so handelt sie ordnungswidrig im Sinne des §32 (1) Nr. 2 bis 4 BtMG. Im Folgenden wird genauer auf den Prozess der Erlaubniserteilung eingegangen.

2.1.3.3.1 Stellung des Antrags

Der Antrag über die Erteilung einer Erlaubnis für die Einrichtung eines DKRs ist gegenüber der obersten Landesbehörde nach Maßgabe des §7 S. 2 Nr. 1 bis 4 und 8 BtMG zu stellen. Demnach müssen dem Antrag der Name und die Anschrift der antragstellenden Organisation und der Verantwortlichen, Nachweise der Verantwortlichen über die erforderliche Sachkenntnis, eine Erklärung über die ständige Erfüllung der Verpflichtungen und eine Beschreibung der Lage der Einrichtung nach Ort, Straße, Hausnummer, Gebäude und Gebäudeteil, sowie die Bauweise des Gebäudes, beiliegen. Eine Beschreibung der vorhandenen Sicherungen gegen die Entnahme von Btm durch unbefugte Personen nach Nr. vier ist nicht erforderlich, da die Vorschrift nur entsprechend angewandt wird[158]. Nr. acht ist ebenfalls nur im Einzelfall anwendbar.

2.1.3.3.2 Erteilung der Erlaubnis

Wie bereits oben erläutert, hat die oberste Landesbehörde gem. §8 (1) BtMG drei Monate Zeit, über die Erteilung der Erlaubnis zu entscheiden. Nachdem eine Entscheidung getroffen wurde, ist das BfArM zu unterrichten. §8 (2) und (3) BtMG sind entsprechend anwendbar.

Nach §9 (2) Nr. 1 BtMG kann die Erlaubnis auch befristet erteilt werden. Die Erlaubnis kann auch mit Nebenbestimmungen oder Auflagen versehen werden, jedoch passen nach Bohnen die Voraussetzungen des §9 (2) Nr. 2 BtMG dafür nicht. Maßstab könne dafür vielmehr die Sicherung des Zwecks eines DKR, also das Erreichen der gesundheits- und ordnungspolitischen Ziele sein[159].

Gem. §10 (1) BtMG kann die Erlaubnis widerrufen werden, wenn von ihr innerhalb von zwei Jahren kein Gebrauch gemacht wurde. Diese Frist kann jedoch verlängert werden, wenn ein berechtigtes Interesse besteht. Nach Absatz zwei muss unverzüglich das BfArM über die Rücknahme oder den Widerruf der Erlaubnis unterrichtet werden.

2.1.3.3.3 Änderungen nach Erteilung der Erlaubnis

Nach §8 (3) S. 1 BtMG muss der Erlaubnisinhaber jede Änderung der Angaben nach §7 BtMG unverzüglich der obersten Landesbehörde mitteilen. Nach Satz drei wird in diesen

[156] Patzak et al. 2024, §10a Rn. 19.
[157] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 75.
[158] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 77.3.
[159] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 80.

Fällen die Erlaubnis geändert. Nach Satz zwei ist ein neuer Antrag nur zu stellen, falls sich beispielsweise die betreibende Organisation oder die Örtlichkeit des DKRs ändert. Über jegliche Änderungen der Erlaubnis ist das BfArM unverzüglich zu unterrichten.

2.2 Straflosigkeit der Nutzer und des Personals

Eine wichtige Abgrenzung eines DKR ist, dass kein rechtsfreier Raum geschaffen werden soll. Dies wird v.a. durch §10a (2) S. 2 Nr. 5 und 6 BtMG verdeutlicht, aber auch durch die Änderung des Gesetzentwurfs der Fraktion SPD und Bündnis 90/Die Grünen durch den Gesundheitsausschuss der 14. Wahlperiode. In dieser Änderung wurde u.a. der Entwurf von §10a (2) S. 2 Nr. 7 BtMG umformuliert. Ursprünglich wurde von „erlaubten Konsummustern" gesprochen, was zu „geduldeten Konsummuster[n]" geändert wurde[160]. Diese Umformulierung zeigt, dass das Mitführen der zu konsumierenden Btm weiterhin an sich verboten ist. Die Duldung des Besitzes äußert sich also nicht durch eine grds. Erlaubnis des Besitzes, sondern vielmehr durch das Absehen der Verfolgung von Straftaten durch die Strafverfolgungsbehörden. Der Übergang zw. der Strafbarkeit des Personals und der Benutzer ist dabei nahezu fließend, jedoch greifen hier unterschiedliche Regelungen.

Die Strafbarkeit, bzw. Straflosigkeit der Betreiber regelt §29 (1) S. 1 Nr. 11 BtMG. Demnach ist das Verschaffen einer Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch von Btm ohne Erlaubnis nach §10a BtMG strafbar. Daraus geht hervor, dass die Grenzen der Strafbarkeit von der erteilten Erlaubnis zum Betreiben eines DKRs gesteckt werden. Beispielsweise wird in einem DKR der Konsum von Heroin und Kokain geduldet. Führt ein Benutzer jegliche andere unerlaubte Substanz, in diesem Beispiel Crack oder Amphetamine, mit, in der Absicht diese im DKR zu konsumieren, so macht sich das Personal prinzipiell strafbar, wenn es dies gem. §10a (2) S. 2 Nr. 5 BtMG nicht unterbindet. Diese Bedingung kann sich auch auf die Nutzungsvoraussetzungen, wie bspw. das Alter oder die Betäubungsmittelabhängigkeit beziehen. Gewährt das Personal also einem Erstkonsumenten Zugang zum DKR, macht es sich ebenfalls nach §29 (1) S. 1 Nr. 11 BtMG oder mind. nach §29 (4) BtMG fahrlässig strafbar. Sollte es dann im Rahmen des Konsums zu einer Überdosierung oder einem Todesfall kommen, so kommen ebenfalls eine fahrlässige Körperverletzung gem. §229 StGB oder eine fahrlässige Tötung gem. §222 StGB in Tateinheit in Betracht[161]. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Strafbarkeit des Personals da anfängt, wo die erteilte Erlaubnis aufhört. Fraglich ist und kritisch zu reflektieren gilt jedoch, inwiefern die unerlaubten Substanzen tatsächlich erkannt werden können, da das Aussehen oft nur schwer zu unterscheiden ist.

Die Straflosigkeit der Nutzer regelt sich über §31a (1) S. 2 BtMG. Da für die Nutzer keine Erlaubnis vorliegen kann, definiert sich die Straflosigkeit hier über das Absehen der Strafverfolgung durch die StA. Somit handeln die Nutzer zwar weiterhin strafbar nach §29 (1)

[160] Vgl. BT-Drs. 14/2345, S. 5.
[161] Vgl. BeckOK BtMG/Kaluba, 31. Ed. 15.6.2026, BtMG §29 Rn. 786

S. 1 Nr. 3 BtMG, jedoch soll nach §31a (1) S. 2 BtMG von der Verfolgung abgesehen werden. Wichtig ist, dass auch hier nur der Besitz in geringer Menge und zum Eigenverbrauch geduldet ist. Geht die Menge über diese „geringe Menge“ hinaus, so greift diese Norm nicht und der Besitz ist weiterhin nach §29 (1) Sn. 1 Nr. 3 BtMG strafbar. Die Abgrenzung des §31a (1) S. 2 BtMG liegt jedoch darin, dass diese Norm allein für den Besitz innerhalb des DKRs greift. So ist die Norm für Konsumenten, die auf dem Weg in den DKR sind, nicht anwendbar[162]. Wird die StA aber in das örtliche Kooperationskonzept miteinbezogen, so kann diese nach §31a (1) S. 1 BtMG generell regeln, von Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts des Besitzes einer geringen Menge, die im DKR konsumiert werden soll, abzusehen. Eine Weisung, von Ermittlungsverfahren beim Anfangsverdacht des Besitzes einer normalen Menge oder beispielsweise des Handeltreibens abzusehen, wäre unzulässig[163]. Ein zentraler Punkt ist aber, dass sich §31a (1) S. 1 und 2 BtMG nur an die StA richtet und nur davon Gebrauch gemacht werden kann, wenn der Sachverhalt bereits ausreichend ermittelt und an die StA übergeben wurde[164]. Die Norm ermächtigt die Polizei also nicht, vom Einleiten eines Ermittlungsverfahrens abzusehen, sondern lediglich die StA, das Verfahren nicht weiter zu verfolgen. Für die Polizei gilt das Legalitätsprinzip nach §163 (1) S. 1 StPO. Sie ist demnach verpflichtet, bei Vorliegen eines Anfangsverdachts für eine Straftat, diese zu verfolgen und alle Maßnahmen zu treffen, um die Verdunkelung der Sache zu verhüten. Nach §152 (2) StPO besteht ein Anfangsverdacht, „wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Begehung einer verfolgbaren Straftat vorliegen“[165]. Der Konsum ist zwar an sich nicht verboten, jedoch gehen dem Konsum i.d.R. mind. der unerlaubte Erwerb und unerlaubte Besitz gem. §29 (1) S. 1 Nr. 1 und 3 BtMG voraus. Somit besteht sowohl für Nutzer im DKR selbst als auch für Nutzer auf dem Weg in den DKR ein Anfangsverdacht für das Vorliegen einer Straftat[166], was die Polizei nach §163 (1) S. 1 stopp zum Tätigwerden verpflichtet. Die Polizei kann jedoch Schwerpunkte setzen[167] und die Örtlichkeit des DKRs zu keinem Kontrollschwerpunkt machen. Des Weiteren darf die Polizei in Fällen, in denen aus ihrer Sicht §31a BtMG angewandt werden könnte, weitere Ermittlungen unterlassen und muss diese nur auf gesonderten Auftrag der StA durchführen[168]. Das Entstehen eines Kontrollschwerpunkts wäre ebenfalls kontraproduktiv im Hinblick auf die Erreichung der Drogenszene und neuer Nutzer. Eine gewisse Polizeipräsenz sei jedoch notwendig, um Szenenbildungen zu verhindern und die Akzeptanz des Umfeldes zu fördern[169]. Die Lösung für das Problem des Legalitätsprinzips sind aus Stuttgarter Sicht die weiteren Angebote des DKRs. Da in den Räumlichkeiten auch bspw. Weitervermittlungen und Beratungen

[162] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 48.
[163] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 57.
[164] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 9.
[165] Jurafuchs Wissen: Anfangsverdacht §152 (2) StPO; https://wissen.jurafuchs.de/definitionen/jqmldp8/anfangsverdacht-%C2%A7-152-abs-2-stpo abgerufen: 14.09.2026, 11:33 Uhr
[166] Vgl. GRDrs 533/2019, S. 4.
[167] Vgl. BeckOK BtMG/Bohnen 2026, §10a Rn. 10.
[168] Vgl. BeckOK BtMG/Wettley, 31. Ed. 15.3.2026, BtMG §31a Rn. 39.
[169] Vgl. GRDrs 533/2019, S. 4.

stattfinden, müsse man nicht zwangsläufig von einer Straftat ausgehen, da der Besuch auch lediglich dem Wahrnehmen anderer Hilfsangebote dienen kann[170]. Auch hier wird nochmal die Wichtigkeit der Zusammenarbeit und des Austausches zw. dem Träger und den Strafverfolgungsbehörden verdeutlicht, da so auf entstehende Bewegungen, bspw. einer immer größer werdenden Szenenbildung oder immer weiter sinkender Nutzerakzeptanz, mit entsprechend mehr oder weniger Polizeipräsenz und Kontrollen reagiert werden kann.

2.3 Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg über den Betrieb von Drogenkonsumräumen

2.3.1 Entstehung und Änderung der Landesverordnung

Die ersten Bestrebungen für eine Landesverordnung über den Betrieb von DKR in BW gab es bereits unmittelbar nach Inkrafttreten des §10a BtMG in den Jahren 2000 des Bündnis 90/Die Grünen und 2001 von der Fraktion der SPD. Grund hierfür war laut dem Antrag der SPD-Fraktion die überdurchschnittlich hohe Drogen-Sterberate in BW. Denn im Gegensatz zur Sterberate im Bundesdurchschnitt Mitte der 90er Jahre, welche rückläufig war, stieg die Sterberate in BW deutlich an[171]. Beide Anträge wurden von den damaligen Landesregierungen abgelehnt. Als Begründung wurde auf die Zielsetzung der Drogenpolitik in BW verwiesen. Aus Sicht der Landesregierung der 12. Legislaturperiode würde eine solche Verordnung, beziehungsweise die Einrichtung von DKR, ein falsches Signal in Richtung Drogenakzeptanz senden. Denn Ziel war es damals, „die Abhängigkeit zu überwinden und den Einzelnen aus seiner Sucht herauszuführen“[172]. Weitere Bestrebungen kamen erst im Juli 2017 wieder auf. Hier wurde dem Landtag eine Projektskizze für einen DKR in Karlsruhe vorgelegt[173]. Grund für die Anregung war die Entstehung einer offenen Drogenszene in Karlsruhe, die sich auch negativ auf das unmittelbare Umfeld auswirkte. Im November 2017 wurde ein erster Verordnungsentwurf erarbeitet und nach längeren Debatten trat schließlich am 1. April 2019 die Verordnung der Landesregierung über den Betrieb von Drogenkonsumräumen (DrogKRV BW) in Kraft.

Auch hier ist ein Wandel der Drogenpolitik von einem abstinenzorientierten hin zu einem akzeptanzorientierten Ansatz zu beobachten. Jedoch stimmt dieser Wandel nicht mit dem auf Bundesebene überein. Denn anders als §10a BtMG war die DrogKRV BW a.F. gem. §15 der Verordnung zunächst auf drei Jahre befristet. Grund dafür war das Vorhaben der Landesregierung, zu prüfen, inwiefern der DKR den Bedarf in Karlsruhe abdeckt und, ob der DKR das richtige Angebot dafür ist[174]. Zudem wurde die Einrichtung eines DKR als eine Art Notlösung angesehen, sollte die Drogenpolitik die Probleme der Drogenszene

[170] Vgl. GRDrs 533/2019, S. 4.
[171] LT-Drs. 13/21.
[172] LT-Drs. 12/4921.
[173] Vgl. LT-Drs. 16/5967.
[174] Vgl. Plenarprotokoll LT-Drs. 16/88, S. 5358.

nicht anderweitig beheben können. Das therapeutische Ziel war es, eine solche Einrichtung nicht zu brauchen[175]. Aus diesem Grund wurde die Einrichtung eines DKR gem. §1 DrogKRV Bw a.F. auch nur Stadtkreisen mit mehr als 300.000 Einwohnern gewährt.

Am 6. Dezember 2019 wurde der erste DKR BWs in Karlsruhe, der K 76, eingerichtet. Eine Evaluation der Arbeit im DKR zum Jahr 2021 hat gezeigt, dass der DKR zu durchweg positiven Ergebnissen führt. So konnten in den ersten Jahren bereits fünf Drogennotfälle erfolgreich verhindert werden[176]. Des Weiteren entstanden im Umfeld des DKRs keine weiteren Brennpunkte und die öffentliche Belastung durch Spritzenfunde im Stadtgebiet nahm spürbar ab, was auf die Einrichtung des DKRs zurückzuführen war[177]. Aufgrund der durchweg positiven Ergebnisse beschloss der Gemeinderat die dauerhafte Weiterführung des DKRs[178]. So wurde am 26. Juli 2022 die DrogKRV BW verlängert und trat gem. §14 rückwirkend zum 1. April 2022 in Kraft. Anders als die zuvor erlassene Verordnung ist diese zeitlich unbegrenzt und hat in §1 keine 300.000 Einwohnergrenze mehr. Damit können in Zukunft auch Gemeinden unter 300.000 Einwohnern einen DKR betreiben.

2.3.2 Aufbau der Landesverordnung

Die DrogKRV BW vom 26. Juli 2022 besteht aus 14 Paragrafen. Der §1 regelt dabei die Voraussetzungen für die Erlaubnis, §2 den Betriebszweck eines DKRs, die §§3 bis 11 orientieren sich an der Chronologie des §10a (2) S. 2 Nr. 1 bis 10 BtMG, §12 regelt das Erlaubnisverfahren nach §10a (3) BtMG, §13 die Überwachung der DKR durch das Gesundheitsamt und §14 das Inkrafttreten der Verordnung, ohne aufgeführte Befristung.

Gem. §1 DrogKRV BW kann auf Antrag eine Erlaubnis nur erteilt werden, wenn die Einrichtung die in §2 DrogKRV BW aufgeführten Betriebszwecke verfolgt und die Mindeststandards der §§3 bis 11 DrogKRV BW einhält. Die Betriebszwecke gem. §2 DrogKRV BW knüpfen an die Zielsetzung der DKR an. Gem. dieser Vorschrift müssen Konsumräume der „Gesundheits-, Überlebens- und Ausstiegshilfe für Drogenabhängige dienen und in das Suchthilfesystem eingebunden sein“. Die festgeschriebenen Zielsetzungen gem. §2 (2) DrogKRV BW umfassen das Senken der Gesundheitsgefahren und die Überlebenssicherung, den Einstieg in den Ausstieg durch Wecken der Behandlungsbereitschaft der Konsumenten, die Förderung der Inanspruchnahme weiterführender Hilfen und die Reduzierung der öffentlichen Belastung durch konsumbezogene Verhaltensweisen. Da sich die Verordnung chronologisch an die Mindeststandards des §10a (2) S. 2 BtMG hält und diese nahezu übernommen hat, wird im Folgenden nur auf ausgewählte Vorschriften und Weiterführungen eingegangen, die im weiteren Verlauf der Arbeit relevant bleiben.

[175] Vgl. Plenarprotokoll LT-Drs. 16/88, S. 5358.
[176] Vgl. Beschlussvorlage 2021/1144 Karlsruhe, Drogenkonsumraum K 76: Evaluation, S. 4.
[177] Vgl. Beschlussvorlage 2021/1144 Karlsruhe, S. 3.
[178] Vgl. Beschlussvorlage 2021/1144 Karlsruhe, S. 4.

2.3.3 Übernahme der Mindeststandards

§4 regelt die Gewährleistung der Notfallversorgung und schreibt insbesondere die regelmäßige Schulung des Personals in der Notfall- und Drogennotfallversorgung vor. Bezüglich der Regelmäßigkeit der Schulungen werden keine genaueren Zeitangaben gemacht. Außerdem muss der Zugang für externe Rettungsdienste schnell und problemlos erreichbar sein. Die Einzelheiten der Notfallversorgung sind in einem medizinischen Notfallplan festzuhalten.

§5 vereint die medizinische Beratung und Vermittlung von weiterführenden Angeboten nach §10a (2) S. 2 Nr. 3 und 4 BtMG. Demnach ist das Personal verpflichtet, je nach Einzelfall über weitergehende und ausstiegsorientierte Beratungs- und Behandlungsangebote zu informieren und bei Bedarf zu vermitteln. Wird ein Entgiftungswunsch geäußert, so hat das Personal die notwendigen Hilfestellungen bei der Kontaktaufnahme zu leisten.

§6 regelt die in §10a (2) S. 2 Nr. 5 BtMG geforderten Maßnahmen zur Verhinderung von Straftaten. So ist eine Hausordnung zu erlassen, in welcher darauf hingewiesen wird, dass Verstöße gegen das BtMG, mit Ausnahme des Besitzes von ärztlich nicht verschriebenen Btm zum Eigenverbrauch in geringer Menge, auch innerhalb des DKRs nicht geduldet werden. Die Einhaltung der Hausordnung ist durch das Personal zu überwachen und Verstöße sind unverzüglich zu unterbinden. Bleibt dies erfolglos, so ist das Personal oder die Leitung verpflichtet, die Straftaten ausnahmslos zur Anzeige zu bringen und gesondert zu dokumentieren. Bei einem Verstoß gegen sonstige Vorschriften der Hausordnung ist ein Hausverbot zu erlassen.

§7 setzt die Kooperation zw. den Trägern des DKRs und den zuständigen Polizei-, Ordnungs- und Strafverfolgungsbehörden voraus, welche schriftlich festzuhalten ist.

§8 regelt den zulässigen Benutzerkreis und die geduldeten Btm. Demnach dürfen grds. nur volljährige Personen mit Betäubungsmittelabhängigkeit und Konsumerfahrung den DKR nutzen. Jugendlichen mit Betäubungsmittelabhängigkeit und Konsumerfahrung darf der Zugang nur mit vorliegender Zustimmung der Erziehungsberechtigten oder, nach sorgfältiger Prüfung anderer Hilfsmöglichkeiten, mit Überzeugung des Personals vom gefestigten Konsumentschluss gestattet werden. Des Weiteren ist die in §10a (2) S. 2 Nr. 7 BtMG gemachte Negativabgrenzung des Benutzerkreises und somit der Ausschluss offenkundiger Erst- und Gelegenheitskonsumenten, etc. übernommen. Nach Absatz drei sind die mitgeführten Btm einer Sichtkontrolle zu unterziehen. Eine Substanzanalyse ist unzulässig. Die konsumierten Btm im DKR können Opioide, Kokain, Amphetamine oder deren Derivate, sowie Benzodiazepine sein und intravenös, inhalativ, nasal oder oral konsumiert werden. Näheres ist in der entsprechenden Hausordnung zu regeln.

Die weiteren §§9 bis 11 DrogKRV BW orientieren sich nahezu deckungsgleich an §10a (2) S. 2 Nr. 8 bis 10 BtMG und werden deshalb hier nicht näher beleuchtet.

2.3.4 Umsetzung im Stuttgarter Konsumraum

Um die Umsetzung der DrogKRV BW in Stuttgart darzustellen, sind insbesondere die Hausordnung und die Kooperationsvereinbarung relevant.

2.3.4.1 Hausordnung

Gem. der Hausordnung[179], die für den jetzigen Interimsstandort gilt, ist der Zutritt nur volljährigen Personen gestattet. Erst- und Gelegenheitskonsumenten, erkennbar intoxikierte Personen und Personen, denen erkennbar die Einsichtsfähigkeit in die durch Applikation erfolgende Gesundheitsschädigung fehlt, haben keinen Zutritt. Vor der ersten Nutzung ist eine Nutzungsvereinbarung zu unterzeichnen. Außerdem schreibt die Hausordnung gem. §6 DrogKRV BW vor, dass den Anweisungen des Personals Folge zu leisten ist und die Konsumregeln[180] einzuhalten sind. Jegliche Verstöße gegen das BtMG, ausgenommen der zum sofortigen Konsum im DKR bestimmten geringen Menge zum Eigenverbrauch, jegliche Ab- und Weitergabe oder Teilen von Drogen und Konsumutensilien, das Abpacken und Rationieren von Drogen und / oder Medikamenten, der Konsum von Alkohol, Cannabis und Nikotin, das Mitführen von Messern und anderen Waffen und das Mitbringen von Haustieren sind verboten und werden mit „Konsumraumverbot“ geahndet. Die einzige Ausnahme des Nikotinkonsums ist der Konsum in der „Smokebox“ zur Vorbereitung oder während des Crackkonsums.

2.3.4.2 Kooperationsvertrag

Wie bereits unter Kapitel „1.3.2.2. Kooperation“ angeschnitten, wird zw. interner und externer Kooperation unterschieden. Für die Umsetzung des §7 DrogKRV BW und §10a (2) S. 2 Nr. 6 BtMG ist nur die externe Kooperation und der dafür aufgesetzte Kooperationsvertrag[181] relevant.

Dieser Kooperationsvertrag wurde zw. dem Caritasverband Stuttgart, Release Stuttgart, dem Amt für öffentliche Ordnung der Landeshauptstadt Stuttgart, dem Sozialamt der Landeshauptstadt Stuttgart, dem Polizeipräsidium Stuttgart und der StA Stuttgart geschlossen. Die Kooperationsvereinbarung sieht einen regelmäßigen gegenseitigen Austausch sowohl auf administrativ-strategischer als auch auf operativer Ebene vor. Dafür wird einerseits auf der übergeordneten Ebene eine Steuerungsgruppe etabliert, die in einem Zeitabstand von einem halben Jahr tagt und die Aufgabe hat, den Stand der Zielerreichung zu diskutieren und ggfs. Korrekturmaßnahmen zu beschließen. Zum anderen benennt jede Organisation der Kooperation jeweilige Ansprechpartner für unmittelbare Absprachen im operativen Bereich. Dieser Austausch erfolgt regelmäßig zw. der Leitung des DKRs, der Polizei, dem Amt für öffentliche Ordnung und dem Suchthilfeplaner der Landeshauptstadt Stuttgart. Des Weiteren wird in der Vereinbarung geregelt, dass die

[179] Anhang Nr. …
[180] Anhang Nr. …
[181] Anhang Nr. …

Dokumentation die Trägerschaft übernimmt. Diese Dokumentation umfasst das Tagesgeschäft, die Beobachtung der Auswirkungen des DKRs auf das umgebende Stadtquartier und die festgestellten Straftaten. Diese Dokumentation wird v.a. in Tages- und Monatsberichten durchgeführt, die anonymisiert an die Steuerungsgruppe übersandt werden. Ein wichtiger Punkt der Kooperationsvereinbarung ist, dass sich die Kooperationspartner darauf einigen, dass der DKR und seine Umgebung keinen rechtsfreien Raum darstellen, die Polizei Stuttgart und StA dennoch beim Vorgehen gegen strafrechtlich relevante Handlungen die Akzeptanz bei den Suchtkranken nicht gefährden. Die polizeilichen Maßnahmen orientieren sich an den Vorgaben des §31a (1) S. 2 BtMG.

3 Experteninterview

Da zu diesem Zeitpunkt nur die erste Pressemitteilung über das erste Betriebsjahr von KOMBO als empirische Grundlage vorliegt, wurde zur Aufarbeitung der praktischen Umsetzung eines DKRs in Stuttgart und Überprüfung der Übertragbarkeit der bisherigen Ergebnisse auf KOMBO ein leitfadengestütztes Experteninterview geführt. Im Folgenden wird zunächst die Auswahl der interviewten Expertin begründet, kurz die Kontaktaufnahme und der Gesprächsverlauf geschildert und anschließend die Aussagen analysiert. Der Gesprächsleitfaden und die Transkription des Interviews sind den Anhängen … und … zu entnehmen. Hierbei steht **E** für Expertin und **V** für den Verfasser der Arbeit.

3.1 Auswahl der Expertin und Kontaktaufnahme

Für das hier durchgeführte Experteninterview wurde die derzeitige Leitung der Einrichtung KOMBO als Gesprächspartnerin ausgewählt. Gläser beschreibt den Begriff eines Experten als „die spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte“[182]. Als Leitung der Einrichtung verfügt die interviewte Person über Spezialwissen über das zugrundeliegende Forschungsobjekt, da ihr speziell als Leitung besondere Aufgaben zugeschrieben werden, die über die eines gewöhnlichen Mitarbeitenden der Einrichtung hinausgehen. Aufgrund dessen kann die Leitung besondere Einblicke in die tägliche Arbeit und organisatorischen Prozesse der Einrichtung bieten und wurde daher als geeignete Interviewpartnerin ausgewählt.

Die Terminfindung fand per E-Mail-Kontakt statt. Bereits bei der Terminfindung wurde eine Tonaufnahme des Interviews vereinbart. Das Interview fand am 8. September 2026 von 13:00 Uhr bis ungefähr 14:45 Uhr statt.

3.2 Gesprächsablauf

Vor dem Gespräch wurde dem Verfasser die Einrichtung gezeigt und bestimmte Herangehensweisen, wie das Bereitstellen verschiedener Safer-Use-Materialien erklärt. Zu Beginn des Gesprächs wurde die Expertin darüber aufgeklärt, dass das Gespräch, wie zuvor

[182] Glaser/Laudel 2010, Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse 4. Auflage, S. 12.

vereinbart, mittels Tonaufnahme aufgezeichnet wird. Diesem stimmte sie zu. Außerdem wurde sie darüber aufgeklärt, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen ihr Name in der Arbeit nicht erwähnt wird, jedoch zur Begründung der Auswahl der Expertin ihre Funktion und Position genannt werden, wodurch möglicherweise Rückschlüsse auf ihre Person gezogen werden können. Diesem stimmte die Expertin ebenfalls zu.

3.3 Analyse

Da nur ein Experteninterview geführt wurde, wird auf eine Kategorisierung der Antworten und qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring verzichtet. Im Folgenden werden die Antworten und Daten lediglich zur besseren Struktur zu Unterüberschriften zusammengefasst und thematisch gemeinsam behandelt.

3.3.1 Zielgruppe des Drogenkonsumraums in Stuttgart

Im Generellen lässt sich sagen, dass KOMBO über das vergangene Jahr immer mehr Anklang gefunden hat, diesen immer noch findet und sich immer mehr neue Nutzer im Konsumraum registrieren[183]. In der ersten Pressemitteilung des Caritasverbands vom 2. Juni 2026 über das erste Betriebsjahr von KOMBO wurde von knapp 200 registrierten Nutzern[184] gesprochen. Im Interview wurden keine genauen Zahlen genannt, jedoch ist davon auszugehen, dass die Zahl mittlerweile weiter gestiegen ist und die Tendenz weiterhin steigt. Laut der Expertin bleibt es bei einer Großzahl der Nutzer nicht bei einem einmaligen Besuch[185]. Ein Beispiel einer einmaligen Nutzung wird von der Expertin geschildert. So hat sich in der Vergangenheit bereits ein Paar aus Köln im Konsumraum registriert und dort konsumiert. In diesem Fall sei es klar, dass diese Nutzer in naher Zukunft den Konsumraum eher nicht erneut besuchen[186]. In Anbetracht der Tatsache, dass DKR gem. ihrer ordnungspolitischen Zielsetzung die örtliche Drogenszene ansprechen sollen, kann hier durchaus die Frage aufkommen, ob diese Nutzung überhaupt gewollt ist oder ob die im Voraus aufgekommene Befürchtung der Sogwirkung tatsächlich eingetreten ist. Auf die Nachfrage, ob diese Nutzer tatsächlich auch zur Zielgruppe gehören, entgegnet die Expertin, dass der Konsumraum als ein Hilfsangebot zu sehen ist, das jeder nutzen darf[187]. Die Betonung liegt hier gezielt auf dem Konsumraum, da die Zielgruppe des Kontaktcafés deutlich enger betrachtet wird. Im Konsumraum sei es das Ziel, dass Konsumenten kommen und das Angebot nutzen, denn „jeder Konsumvorgang hier drin ist besser als draußen“[188]. Das genannte Beispiel kann zwar als Ausnahmefall betrachtet werden, jedoch wird hier ebenfalls die Bedeutung des Konsumraums deutlich. Denn Konsumenten aus anderen Städten, die sich in anderen Drogenszenen aufhalten, haben höchstwahr-

[183] Vgl. Anhang Nr … Seite … Zeile …
[184] Vgl. Ein Jahr KOMBO: Drogenkonsumraum bewährt sich, 2026.
[185] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[186] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[187] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[188] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …

scheinlich wenig bis keine Kontakte oder Berührungspunkte mit der Stuttgarter Drogenszene, beziehungsweise dem Stuttgarter Hilfesystem. Bestehen diese Kontakte nicht, kann es für diese Konsumenten deutlich schwerer sein, an hygienisches und frisches Konsumbesteck zu gelangen, wodurch ein unhygienischer und mit mehr Risiken verbundener Konsum sehr nahe liegt. Durch das Angebot des Konsumraums kann diesem Problem entgegengewirkt werden, auch wenn externe Nutzer nicht der typischen Zielgruppe des örtlichen Hilfesystems angehören. Wie bereits angesprochen, unterscheidet sich die Zielgruppe des Konsumraums von der des im gleichen Haus befindlichen Kontaktcafés. Dabei bildet das Kontaktcafé eher ein „zweites Standbein“[189] als eine Ergänzung des Angebots des Konsumraums. Der Konsumraum richtet sich dabei ausschl. an aktiv Konsumierende, wohingegen das Kontaktcafé zusätzlich auch Personen anspricht, die nicht mehr konsumieren[190]. Aufhalten dürfe sich im Kontaktcafé zwar grds. jeder, jedoch achte man bei der Nutzung weiterer Angebote, wie beispielsweise der Beratung oder dem Wäschewaschen darauf, wo die Leute bereits angebunden sind oder in der Vergangenheit angebunden waren[191]. Hier entspricht das Paar aus Köln also nicht der Zielgruppe.

KOMBO spricht Konsumenten in jeder Altersspanne, auch unter 18-Jährige an. So hat sich bislang eine minderjährige Person registriert[192]. Das Durchschnittsalter der Nutzer liegt laut der Expertin zw. Mitte 30 und Mitte 40[193]. Dieses Durchschnittsalter stimmt mit dem Durchschnittalter der ambulanten Suchthilfe in Stuttgart überein. Auf ganz Stuttgart bezogen liegt dieses bei 38 Jahren[194]. Auch Bergmann et al. haben auf Bundesebene festgestellt, dass 36-45-jährige Konsumenten Konsumräume am häufigsten nutzen[195]. Da das Durchschnittsalter sowohl in Stuttgart als auch auf Bundesebene übereinstimmt, könnte die Aussage getroffen werden, dass besonders Konsumenten der Altersspanne von 30-49 Jahren von der gefragten Suchtproblematik betroffen sind und besonders Konsumenten dieses Alters das Angebot eines DKRs nutzen. Wichtig zu erwähnen ist, dass sich das Durchschnittsalter in Stuttgart auf das gesamte Suchthilfesystem bezieht und somit auch Klienten, die an Essstörungen oder Alkoholsucht leiden, miteinbezieht. Jedoch ist deutlich erkennbar, dass die Opioidabhängigkeit besonders in der Altersspanne 30-49 Jahre vertreten ist. Diese Altersspanne bildet hier einen Anteil von 62,6% aller Opioidabhängigen. Jüngere Klienten des Stuttgarter Suchthilfesystem, besonders 18-24-Jährige, sind v.a. von Cannabisabhängigkeit oder Essstörungen betroffen und bilden in diesen Kategorien jeweils die Mehrheit. Unter 17-Jährige waren als Klienten mit einer Opioidabhän-

[189] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[190] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[191] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[192] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[193] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[194] Vgl. Suchthilfeverbund Stuttgart, Fachgruppe Dokumentation 2026, Jahresbericht 2025 der ambulanten Suchthilfe in Stuttgart Bereiche Beratung, Betreuung und Behandlung – ausgewählte Daten, S. 7.
[195] Vgl. Bergmann et al. 2026, S. 7.

gigkeit im Jahr 2025 nicht vertreten. Auch in den anderen Abhängigkeitsformen sind unter 17-Jährige wenig vertreten[196]. Somit kann die oben genannte 16-jährige Person als deutliche Ausnahme gesehen werden, v.a. in Bezug auf die geforderte Betäubungsmittelabhängigkeit und Konsumerfahrung. Wie sich darüber vergewissert wird, wird in einem folgenden Kapitel thematisiert. Ein weiterer Aspekt, der sich mit den Erfahrungen bereits länger bestehender DKR deckt, ist die Unterrepräsentation von Frauen. Laut Schätzungen der Expertin beträgt das Verhältnis unter den Nutzern 70% Männer zu 30% Frauen[197]. Wie in Kapitel „1.6.1 Zielgruppe“ thematisiert, ist diese Unterrepräsentation eine der zentralen Kritikpunkte an DKR. Diese Unterrepräsentation wird jedoch von der Expertin, bezogen auf Stuttgart, nicht als ein Problem gesehen. So sieht sie das Verhältnis eher wie eine Wiederspiegelung der Drogenszene in Stuttgart, da generell weniger Frauen konsumieren würden[198]. Diese Annahme verdeutlicht sich ebenfalls durch den Jahresbericht der ambulanten Suchthilfe 2025. Hier ist zu sehen, dass lediglich 14,9% der in Beratung befindlichen Opioidabhängigen und 17,1% der Kokainabhängigen Frauen sind. Im Gegensatz dazu sind 93,1% der Personen, die wegen einer Essstörung Hilfen in Anspruch nehmen, Frauen[199]. Diese Zahlen können also so interpretiert werden, dass Frauen in Stuttgart weniger von den im Konsumraum angesprochenen Abhängigkeiten betroffen sind. Dementsprechend sieht die Expertin bislang auch noch wenig bis keinen Bedarf für gesonderte Angebote oder Öffnungszeiten nur für Frauen, wie es beispielsweise in Hamburg der Fall ist[200].

Eine weitere zentrale Zielsetzung eines DKRs besteht darin, neue Konsumentengruppen anzusprechen, die bisher noch nicht an das Hilfesystem angebunden waren. In Stuttgart wird diese Zielsetzung jedoch nur teilweise und aus einer anderen Perspektive erreicht. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass die meisten Nutzer derzeit an weitere Hilfsangebote angebunden sind oder in der Vergangenheit bereits Erfahrungen im Suchthilfesystem in Stuttgart gemacht haben[201]. Dennoch werden auch für das Suchthilfesystem neue Konsumenten angesprochen[202]. Aber ein zentraler Punkt, der von der Expertin hervorgebracht wurde, ist, dass die Niedrigschwelligkeit der Einrichtung nicht nur dazu dient, für das Suchthilfesystem komplett neue Konsumenten anzusprechen, sondern auch Konsumenten, „die schon lange nicht mehr an das System angebunden waren“[203], in der Vergangenheit das Vertrauen in manche Institutionen verloren haben und deshalb in gewisser Hinsicht aufgegeben haben[204]. Es kann also die Schlussfolgerung gezogen werden, dass

[196] Vgl. Suchthilfeverbund Stuttgart, Fachgruppe Dokumentation 2026, Jahresbericht 2025 der ambulanten Suchthilfe in Stuttgart Bereiche Beratung, Betreuung und Behandlung – ausgewählte Daten, S. 7.
[197] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[198] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[199] Vgl. Suchthilfeverbund Stuttgart, Fachgruppe Dokumentation 2026, Jahresbericht 2025 der ambulanten Suchthilfe in Stuttgart Bereiche Beratung, Betreuung und Behandlung – ausgewählte Daten, S. 6.
[200] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[201] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[202] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[203] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[204] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …

Konsumenten, die bereits Erfahrungen im Suchthilfesystem haben, nicht als kein Teil der Zielgruppe zu verstehen sind, oder als eine Nichterreichung der eigentlichen Zielgruppe. Denn DKR können auch für diese Konsumenten als Brücke dienen, wieder in das Suchthilfesystem aufgenommen werden zu wollen und die Bereitschaft wecken, die angebotenen Hilfen wieder anzunehmen. Somit ist die Zielgruppe weniger als „neue Konsumenten“ und mehr als „Konsumenten, die aktuell keine Hilfen in Anspruch nehmen“ zu sehen.

Auch wenn KOMBO viele Konsumenten anspricht und auch bezogen auf das Alter oder die Erfahrung der Konsumenten im Suchthilfesystem eine breit aufgestellte Nutzerschaft hat, bleiben weiterhin genug Leute nicht erreicht[205]. Gründe hierfür werden in Kapitel … beleuchtet.

3.3.2 Konsumierte Substanzen

Die meistkonsumierte Substanz im Stuttgarter Konsumraum ist Crack[206]. Dies sei auch fast durchgehend seit Eröffnung der Fall gewesen. Obwohl Crack fast ausschl. geraucht wird, ist der intravenöse Konsum die am häufigsten praktizierte Konsumform bei KOMBO, dicht gefolgt vom inhalativen Konsum[207], was möglicherweise auf die Platzverteilung im Konsumraum zurückzuführen ist. Intravenös werden v.a. Kokain und Substitute wie Methadon oder Subutex konsumiert[208]. Hier ist wichtig anzumerken, dass laut der DrogKRV BW und §10a BtMG nur der Konsum ärztlich nicht verschriebener Substanzen geduldet wird, worunter Methadon und Subutex nicht fallen. Bezogen auf das Methadon hat KOMBO mittlerweile eine eigene Substitutionspraxis im Gebäude, welche eng mit KOMBO kooperiert. In dieser Substitutionspraxis wird Patienten ausschl. Methadon verschrieben und es gibt eine interne Vereinbarung, dass Patienten der Substitutionspraxis ihr Substitut im Konsumraum konsumieren dürfen[209]. Aber auch Konsumenten, die ihr Substitut im Konsumraum konsumieren wollen, ohne Patient der eigenen Substitutionspraxis zu sein, werden nicht abgewiesen. Als Grund hierfür nennt die Expertin, dass man zum einen den Weg der Substanz nicht nachverfolgen kann und somit nur schwer nachvollziehen kann, ob es sich tatsächlich um das eigene verschriebene Substitut handelt oder um eine Substanz vom Schwarzmarkt[210]. Zum anderen würde man dadurch Teile der Zielgruppe wegschicken und so die Gesundheitsgefahr der Konsumenten erheblich erhöhen[211].

[205] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[206] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[207] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[208] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[209] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[210] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[211] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …

3.3.3 Veränderungen durch KOMBO

Wie bereits im vorherigen Verlauf der Arbeit mehrfach thematisiert, ist ein großer Punkt der Zielsetzung eines DKRs, den Gesundheitszustand der Konsumenten zu verbessern und auch die Bereitschaft zur Veränderung der eigenen Abhängigkeit zu fördern. Bezüglich der Erreichung dieser Zielsetzung konnten in Stuttgart bedauerlicherweise Erfahrungen in zwei Richtungen gemacht werden. So gibt es einerseits Konsumenten, die über das vergangene Jahr, auch bei regelmäßiger Nutzung des Raumes, stabil geblieben sind und mittlerweile auch die Beratungsangebote annehmen, was durchaus als Erfolg zu sehen ist[212]. Andererseits gibt es dennoch auch Konsumenten, bei denen man über das Jahr „zuschauen konnte“, wie diese immer weiter in die Drogenszene abgerutscht sind und sich der Zustand immer weiter verschlechtert hat[213]. Diese Bewegung wird von der Expertin klar als Nachteil der Einrichtung hervorgehoben, da in der Einrichtung zwar Kontakte geknüpft werden können, diese aber auch in „die falsche Richtung“ gehen können[214]. Diese „falsche Richtung“ meint hier Personen, die den Konsumenten Drogen verkaufen, mehr in der Szene „connecten“[215] oder nach ihrer Therapie zu neuen Drogen verführen oder ihnen diese schenken[216]. Konsumräume eignen sich also im schlimmsten Fall auch dazu, neue Quellen für Drogen zu finden[217]. Hier ist ein klarer Widerspruch in der Zielsetzung, die Drogenszene an einem Ort zu zentralisieren, erkennbar. Denn einerseits ist diese Szenenverlagerung für die Allgemeinheit positiv, indem Parks oder öffentliche Plätze von der Belastung durch die örtliche Drogenszene befreit werden. Jedoch kann sie auf der anderen Seite auch negativ für stabile Konsumenten sein, indem die Einrichtung an ihrem Status als Schutzort verliert und die Konsumenten so erneut mit der Szene in Kontakt bringt, neue Quellen gefunden werden können und die Wege, um an Btm zu gelangen, immer kürzer und schneller werden. So können Konsumräume also nicht nur negative Auswirkungen auf das unmittelbare Umfeld des Konsumraums haben, wie von Zurhold et al. gezeigt[218], sondern auch auf die Konsumenten selbst. Die Arbeit des Personals in der Hinsicht ist also besonders wichtig und dem Unterbinden von Drogenhandel innerhalb der Einrichtung ist besondere Priorität zuzuschreiben.

In Bezug auf die Auswirkungen von KOMBO wirft die Zahl der drogeninduzierten Todesfälle des Jahres 2025 einige Fragen auf. So hat sich die Fallzahl von 20 Fällen im Jahr 2024 auf 40 Fälle im Jahr 2025 verdoppelt. Dabei kann gem. dem Jahresbericht der ambulanten Suchthilfe 2025 der Anstieg nicht auf eine einzelne Ursache zurückgeführt werden. Unter anderem sei eine teils hohe Wirkstoffkonzentration todesursächlich. In 26 der 40 Fälle war ein Mischkonsum mehrerer Substanzen todesursächlich, in neun Fällen eine

[212] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[213] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[214] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[215] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[216] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[217] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[218] Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 186.

Überdosierung und zwei Personen starben aufgrund der Langzeitfolgen des Konsums[219]. Die Expertin erklärt sich den Anstieg durch vier Aspekte: die Reinheit der Stoffe verändert sich, Kokain ist derzeit so viel da wie noch nie, generell ist die Zahl der Drogenkonsumenten gestiegen und sie hält es für möglich, dass synthetische Opioide im Spiel waren[220]. Verallgemeinert lässt sich also sagen, dass die hohe Wirkstoffkonzentration und die immer größer werdende Unreinheit der Substanzen auch in der Stuttgarter Drogenszene ein zunehmendes Problem darstellen. Es ist aber anzumerken, dass KOMBO im Mai eingerichtet wurde. Aus der Statistik ist nicht ersichtlich, in welchen Monaten die Sterberate besonders hoch war. Es kann also sein, dass sich ein Großteil der Fälle vor der Eröffnung von KOMBO ereignet haben. Hier ist jedoch hervorzuheben, dass Stuttgart laut der Expertin bisher kein Problem mit synthetischen Opioiden hat. Dies sei dem Personal des Konsumraums auch durch einen Konsumenten bestätigt worden. Dieser berichtete dem Personal, „dass es vor paar Jahren mal mehr war als jetzt gerade“[221]. Dieser Austausch, beziehungsweise diese Erkenntnis, verdeutlicht erneut die Wichtigkeit der Nähe zu den Klienten und die daraus resultierende Möglichkeit, Informationen über den aktuellen Drogenmarkt zu erhalten.

Den dritten Teilbereich der möglichen Auswirkungen von KOMBO betrifft das unmittelbare Umfeld. Zur besseren Veranschaulichung des Umfelds ist Anhang Nr. … ein Screenshot von Google Maps zu entnehmen. Laut der Expertin gibt es bislang keine Rückmeldungen aus dem Umfeld, was jedoch positiv zu bewerten ist[222]. Im unmittelbaren Umfeld befindet sich unter anderem die Jakobschule, die in der Vergangenheit durch weggeworfene benutzte Spritzen betroffen war. Vor der Eröffnung bestand Skepsis bei Vertretern der Schule. Aus diesem Grund hat das Personal von KOMBO die Schule eingeladen, um in einen Austausch zu gehen und mögliche Bedenken zu besprechen. Ergebnis des Gesprächs war eine Vereinbarung darüber, dass die Vertreter der Schule den Kontakt suchen, sollte es zu weiteren Problemen kommen. Bislang wurde seitens der Schule kein weiterer Kontakt aufgenommen[223], was damit gedeutet werden kann, dass die Jakobschule nicht mehr durch die weggeworfenen Spritzen betroffen ist, beziehungsweise das Ausmaß so eingedämmt wurde, dass es nicht mehr als Problem wahrgenommen wird. Ein weiteres Thema ist das Parkhaus „Züblin“ gegenüber von KOMBO. Denn bis es KOMBO gab, war das Parkhaus ein Ort, der von vielen Konsumenten als Konsumort genutzt wurde. Bedauerlicherweise wird das Parkhaus immer noch von manchen Konsumenten genutzt, weil sie bspw. von KOMBO abgewiesen wurden. Laut der Expertin kam es in diesen Fällen bisher jedoch zu keinen Beschwerden[224]. In der gleichen Straße befindet sich der sogenannte „Utopia Kiosk“. Mit diesem hat das Personal laut der Expertin bisher

[219] Vgl. Suchthilfeverbund Stuttgart, Fachgruppe Dokumentation 2026, Jahresbericht 2025 der ambulanten Suchthilfe in Stuttgart Bereiche Beratung, Betreuung und Behandlung – ausgewählte Daten, S. 13f.
[220] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[221] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[222] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[223] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[224] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …

nur positive Erfahrungen gemacht und es herrscht ein Verhältnis gegenseitiger Unterstützung[225]. So gab es bisher noch keine negativen Erfahrungen mit dem unmittelbaren Umfeld des Konsumraums und es kamen bislang keine Beschwerden auf. Es kann also keine Aussage darüber getroffen werden, ob sich die Situation durch die Eröffnung von KOMBO verbessert hat. Es kann jedoch gesagt werden, dass sich die Situation im unmittelbaren Umfeld zumindest nicht verschlechtert hat, was sich auch mit dem Ergebnis von Zurhold et al. deckt. Diese haben erarbeitet, dass DKR von ihrem unmittelbaren Umfeld akzeptiert werden, solange keine sichtbare Drogenszene entsteht, kein öffentlicher Konsum und kein Drogenhandel stattfindet[226]. So ist davon auszugehen, dass diese Phänomene in Stuttgart nicht zu beobachten sind, beziehungsweise nicht als Problem wahrgenommen werden.

Diese Bewegungen, beziehungsweise teilweise bisher ausbleibenden sichtbaren Veränderungen können durchaus zu Bedenken in Bezug auf die Wirksamkeit und den Nutzen von KOMBO führen. Jedoch haben bereits Zurhold et al. 2001 und Poschadel et al. 2002 Stellung zu genau dieser Thematik bezogen. Führt man beide Aussagen zusammen, so lässt sich anführen, dass es sich bei einem DKR um eine strukturelle und dauerhafte Intervention handelt. Dadurch würden sich die Auswirkungen eines DKRs erst langfristig zeigen[227] und über die Zeit aufrechterhalten bleiben. Es gilt anzunehmen, dass die tatsächliche Wirkung eines DKRs mit einer leichten Zeitverzögerung von sechs bis zwölf Monaten[228] eintritt und wahrnehmbar ist, da sich die Einrichtung in der örtlichen Drogenszene erstmal etablieren und herumsprechen müsse. Somit wäre eine mögliche Veränderung eher mit den Zahlen des Jahres 2026 ersichtlich. Besonders interessant wäre dann die Zahl der drogeninduzierten Todesfälle in Stuttgart.

3.3.4 Annahme der Angebote und Weitervermittlung

Generell, so die Expertin, werden die Angebote von den Nutzern gut angenommen[229]. Aufgrund der großen Bandbreite an ergänzenden Angeboten kann auch nicht pauschalisiert werden, weshalb ein Großteil der Nutzer die Einrichtung aufsucht. Denn jeder Nutzer lebt in einer anderen Lebenssituation und hat andere Leistungen, die benötigt werden. So leben manche Nutzer beispielsweise in Wohnheimen und brauchen eher das Angebot des Wäschewaschens. Ein anderer Teil der Nutzer lebt auf der Straße[230] und benötigt eher eine Beratung in Sachen Wohnungssuche. Es gebe aber auch Konsumenten, die nur den Konsumraum nutzen und keine weiteren Angebote in Anspruch nehmen[231]. Hier sieht die Expertin auch einen Vorteil der Herangehensweise der Einrichtung, was auch von Kon-

[225] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[226] Vgl. Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 171.
[227] Vgl. Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 234.
[228] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 144f.
[229] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[230] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[231] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …

sumentenseite widergespiegelt wird. Denn bei KOMBO ist eine Beratung nicht zwingend[232] und „man kann […] auch einfach kommen, ohne was zu wollen und darf wieder gehen“[233]. Hier wird erneut der akzeptanzorientierte Arbeitsansatz deutlich[234]. Wenn ein Nutzer keine Beratung in Anspruch nehmen möchte, wird diese Entscheidung vom Personal akzeptiert. Aus Sicht der Expertin können sie als Einrichtung nur die Angebote machen. Diese anzunehmen liegt in der Eigenverantwortung der Nutzer[235]. Denn die Beratung umfasst nicht nur die Ausstiegshilfe oder Therapievermittlung. Entscheidet sich ein Nutzer dazu, weiterkonsumieren zu wollen, könne sich trotzdem gemeinsam der Konsum angeschaut, Verbesserungen empfohlen werden und der Nutzer kann sich auch im Hinblick darauf eigene Ziele setzen[236].

So kann man sagen, dass das Personal zwar verpflichtet ist, eine Beratung anzubieten und bei Bedarf durchzuführen, jedoch werden keine Ziele erreicht, wenn diese den Konsumenten aufgezwungen werden. Dies deckt sich mit dem von Springer im Jahr 2003 erarbeiteten Ergebnis. Laut Springer geschieht Gesundheitsförderung mit gezielten Interventionen und mit persönlichen Informationsgesprächen und Beratungen[237]. Die Betonung liegt hier klar auf „gezielt“, denn wie bereits angesprochen, benötigt jeder Nutzer andere Leistungen und es bringt keinen Mehrwert, die Angebote universell auf jeden Nutzer zu beziehen und anzuwenden. So muss die Beratung also auf jeden Nutzer individuell zugeschnitten und jede Situation individuell betrachtet und beurteilt werden, damit Folgeberatungen wirksam sein können. So ist der Nutzen eines DKR auch nicht auf alle Nutzer zu beziehen, sondern für jeden Nutzer einzeln messbar und einzeln zu beurteilen. Diese Schlussfolgerung bestätigt die Expertin ebenfalls. Denn aus ihrer Sicht ist Soziale Arbeit auch „Casemanagement“[238]. Ein kleines Ziel sei aus ihrer Sicht bereits erreicht, wenn ein Nutzer KOMBO ein zweites Mal aufsucht. Im besten Fall nimmt die Person dann im weiteren Verlauf ebenfalls die Beratung wahr[239].

Wird eine Therapievermittlung gewünscht, so wird diese auch vom Personal angeboten. Bei der Weitervermittlung in weitere Angebote treten, wie in der Vergangenheit durch Poschadel et al. erarbeitet[240], auch in Stuttgart teils lange Wartezeiten auf, die auf die Einsparungen im Landeshaushalt zurückzuführen sind[241]. Ein größeres Problem der Weitervermittlung sieht die Expertin jedoch darin, dass die alleinige Weitervermittlung das Ankommen des Nutzers im vermittelten Angebot nicht garantiert. Das Personal hat zwar die Möglichkeit, bei den weiteren Stellen anzurufen und auch gemeinsame Termine mit

[232] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[233] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[234] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[235] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[236] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[237] Vgl. Springer 2003, Konsumräume, Expertise im Auftrag des Fonds Soziales Wien, S. 36.
[238] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[239] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[240] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 47.
[241] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …

den Nutzern zu vereinbaren, dort ankommen müssen die Nutzer jedoch selbst, was durch das Personal unmöglich zu steuern ist[242]. Das Problem sei demnach eher, „ob das Klientel die Wege schafft“[243]. So können zwar die ersten Schritte der Therapievermittlung durch das Personal übernommen werden, die Therapie abzuschließen oder das vermittelte Angebot anzunehmen, liegt letzten Endes in der Eigenverantwortung der Nutzer und das Personal von KOMBO kann darauf ab diesem Zeitpunkt keinen Einfluss mehr nehmen. So kann der Schluss gezogen werden, dass ein DKR und die Bereitschaft, weitere Angebote anzunehmen, nicht automatisch eine Verbesserung der Situation oder ein garantierter Ausstieg aus der Sucht bedeutet. Einem positiven Ergebnis gehen viele Schritte voraus, auf die weder das Personal von KOMBO noch eine Therapie Einfluss nehmen können. Aus diesem Grund ist die Therapievermittlung eher als ein Sprungbrett zu betrachten, das eigenständig genutzt werden muss.

3.3.4.1 Warum dennoch viele Konsumenten den Konsumraum nicht nutzen

Wie unter Kapitel „3.3.1 Zielgruppe“ bereits angedeutet, bleiben bislang noch viele potenzielle Nutzer nicht erreicht. Einen großen Faktor dafür sieht die Expertin in der Pflicht, sich mit Klarnamen und echten Personalien zu registrieren. So gebe es viele Konsumenten, die das Kontaktcafé besuchen, den Konsumraum ebenfalls nutzen würden, darauf aber aufgrund der Registrierung verzichten und lieber vor der Tür in der Öffentlichkeit konsumieren[244]. Hier spiele Vertrauen eine große Rolle. Denn die Expertin nimmt an, dass viele Konsumenten zuerst nicht glauben können, „dass man [an] einem Ort wirklich Illegales legal konsumieren kann und die Daten, die ich da abgebe, wirklich auch da bleiben“[245]. Dieses Vertrauen baue sich erst über Zeit und Erfahrungen anderer Nutzer auf, da sich diese vertrauenswürdige Behandlung mit den Daten zunächst in der Szene rumsprechen müsse. Über das vergangene Jahr konnte das Personal die Erfahrung machen, dass mittlerweile um einiges weniger Diskussionen bei der Registrierung geführt werden als am Anfang. Jedoch habe dies einige Zeit gebraucht[246]. Hier wird erneut ein Grund für die Zeitverzögerung der Ergebnisse klar und zeigt, dass KOMBO sich mittlerweile herumgesprochen hat und innerhalb der Szene immer mehr Anklang findet. Ein weiteres zentrales Problem hier seien Konsumenten ohne ausweisähnliche Dokumente. Denn ohne das Vorzeigen dieser können sich Nutzer nicht registrieren und müssen abgewiesen werden, was auf keinen Fall dem Ziel der Einrichtung entspricht[247]. Auf Nachfrage und Schilderung der Möglichkeit, Decknamen für jede Person zu nutzen[248], antwortet die Expertin, dass ein solches Konzept durchaus denkbar wäre und sicherlich eine Hemmschwelle abbauen und die Arbeit vereinfachen würde[249]. Allein schon aus dem

[242] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[243] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[244] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[245] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[246] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[247] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[248] Vgl. Poschadel et al. 2002, S. 134f.
[249] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …

Grund, dass viele Konsumenten einen Spitz- oder Szenenamen haben, mit dem sie auch vom Personal angesprochen werden, deren echter Name aber ganz anders ist. In diesen Fällen müsse immer wieder im System nachgeschaut werden, ob diese Personen bereits registriert sind. Durch das Konzept der Decknamen würde hier ein erheblicher Zeitverlust behoben und durchaus mehr potenzielle Nutzer zur Nutzung von KOMBO verleitet werden.

3.3.5 Auslastung der Einrichtung

Wie bereits unter Kapitel „3.3.1 Zielgruppe“ beschrieben, ist die Anzahl der registrierten Nutzer konstant angestiegen. Wie viele Nutzer genau derzeit registriert sind, ist unklar. Für die Anzahl der Nutzer gibt es keine Begrenzung. Die einzige Begrenzung besteht bisher nur durch den fehlenden Platz im Interimsstandort[250]. Auf diese Thematik wird in Kapitel „3.3.8.1 Neuer Standort“ genauer eingegangen.

Laut der Expertin hat man, bezogen auf die Auslastung der Einrichtung, deutlich gemerkt, dass der Konsumraum erstmal anlaufen und sich in der Szene herumsprechen musste. Denn anfangs gab es Tage, an denen nur sehr wenig Konsumbetrieb stattgefunden hat[251]. Der bisher stärkste Monat war der Februar diesen Jahres, was laut der Expertin mit der Vesperkirche zusammenhing. Die Vesperkirche ist ein zeitlich begrenztes Angebot in der Leonhardskirche in Stuttgart, welches sieben Wochen von Januar bis März stattfindet. Die Vesperkirche ist ein Konzept, das bedürftigen Menschen durch die Mitarbeit von ehrenamtlichen Helfern unter anderem Essen, Trinken, medizinische Versorgung, einen Friseur und Beratungsangebote für wenig Geld oder teilweise kostenlos zur Verfügung stellt[252]. Laut Google Maps befindet sich die Leonhardskirche eine Gehminute und 60 Meter von KOMBO entfernt. Im Februar kam es dadurch zu insgesamt 400 Konsumvorgängen in einem Monat, was im Februar mit 24 geöffneten Tagen ungefähr zwölf bis 13 Konsumvorgänge pro Tag betrug. Mittlerweile pendelt es sich zw. 200 und 300 Konsumvorgänge pro Monat ein[253], was bei einem Monat mit 30 Tagen und vier betriebslosen Sonntagen ungefähr acht bis zwölf Konsumvorgänge pro Tag beträgt. Vergleicht man diese Zahlen mit anfangs 30 Konsumvorgängen pro Monat, so ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, was durchaus positiv zu betrachten ist. Die Expertin erwartet außerdem im Winter einen erneuten Anstieg der Nutzerzahlen aufgrund der Kälte und Dunkelheit, was den Konsum draußen deutlich erschwert[254]. Dieser Anstieg bestätigt auch nochmal die Aussagen von Zurhold et al. und Poschadel et al., dass die Wirkung einer solchen Einrichtung immer mit zeitlichem Verzug zu erwarten ist. Denn es ist davon auszugehen,

[250] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[251] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[252] Vgl. Vesperkirche Stuttgart https://www.stuttgart-evangelisch.de/einrichtungen/vesperkirche-stuttgart abgerufen: 30.09.2026 10:22 Uhr
[253] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[254] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …

dass die Auswirkungen mit 200 bis 300 Konsumvorgängen pro Monat deutlich spürbarer sind als mit 30 Konsumvorgängen pro Monat.

Bei mehr als 200 registrierten Nutzern wird jedoch schnell klar, dass nur sehr wenige, beziehungsweise fast keine dieser Nutzer ausschl. in den Räumlichkeiten von KOMBO konsumieren. Denn wie Zurhold et al. bereits gezeigt haben, wird täglich je nach Konsumform drei bis sieben Mal konsumiert[255]. Bei einer hypothetischen Rechnung käme ein Konsument, der täglich fünf Mal konsumiert, in einem Monat mit 26 geöffneten Tagen allein bereits auf 130 Konsumvorgänge in der Einrichtung. Bei 200 registrierten Nutzern, die zwar nicht alle das gleiche Konsumverhalten aufweisen, wären die monatlichen Konsumvorgänge jedoch deutlich mehr, würden diese ausschl. im Konsumraum konsumieren. Diese Erkenntnis muss aber nicht unbedingt schlecht sein, da die Auswirkungen von KOMBO nicht allein durch die stattgefundenen Konsumvorgänge bemessen werden können. Denn ein positiver Mehrwert ist ebenfalls erbracht, wenn ein Konsument zwar beispielsweise nur einmal wöchentlich im Konsumraum konsumiert, dafür aber eine Therapievermittlung in Anspruch nimmt und so Zugang zum Suchthilfesystem erhält und sein Konsumverhalten eventuell ändern kann.

3.3.6 Umsetzung der DrogKRV BW

Da die DrogKRV BW verschiedene Bereiche abdeckt, wird die Umsetzung dieser in die verschiedenen Teilbereiche entsprechend der Chronologie untergliedert.

3.3.6.1 §4 Gewährleistung der Notfallversorgung

Nach §4 DrogKRV BW muss eine sofort einsatzfähige Notfallversorgung gewährleistet sein. Von einem Notfall wird dabei gesprochen, sobald vom Personal medizinische Hilfe geleistet werden muss[256]. Das erste Anzeichen einer Überdosis, beziehungsweise einer angehenden Notfallsituation, ist laut der Expertin i.d.R., dass die Atmung „nicht mehr richtig funktioniert“[257]. Entsteht eine solche Situation, hat das Personal mehrere Möglichkeiten. Entweder fängt die Person auf Zuruf wieder an zu atmen oder das Personal überprüft mithilfe eines Pulsoximeters die Sauerstoffsättigung im Blut[258]. Verbessert sich die Atmung nicht, können Schmerzreize gesetzt werden, um die Atmung wiederherzustellen, was bereits als Notfall gewertet wird[259]. Ein schwerer Notfall ist dann darüber hinaus eine Situation, in der das Personal den Rettungsdienst verständigen muss. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn das Personal merkt, dass die betroffene Person anfängt, immer weniger zu atmen und der Sauerstoff vor Ort nicht mehr ausreicht[260].

[255] Vgl. Zurhold et al. 2001, Drogenkonsumräume, S. 87.
[256] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[257] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[258] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[259] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[260] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …

Auf das Rufen eines Rettungsdienstes wird jedoch verzichtet, wenn die betroffene Person äußert, dass sie keinen Rettungsdienst gerufen haben möchte[261]. Die Expertin erzählt auch von einem Vorfall, der sich kurze Zeit vor dem Interview zugetragen hat, bei dem das Personal eine Person reanimieren musste. Sie sagt auch, dass speziell in solchen Fällen mehr Unterstützung notwendig ist. Das Personal kann jedoch bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Reanimationsmaßnahmen übernehmen[262]. Die betroffene Person hat den Vorfall erfreulicherweise überlebt[263]. Hier wird erneut die Wichtigkeit der schnellen Intervention deutlich. Denn es ist durchaus davon auszugehen, dass, wäre dieser Notfall in einem Hinterhof oder einer ruhigen Ecke passiert, hätten durchaus schlimmere Folgen eintreten können. Im Gespräch vor dem Interview wurde dem Verfasser ebenfalls erläutert, dass zu jedem Zeitpunkt zwei Mitarbeitende im Konsumraum anwesend sind, um die Notfallversorgung und die gleichzeitige Verständigung des Rettungsdienstes zu gewährleisten.
Des Weiteren muss das Personal regelmäßig in der Notfall- und Drogennotfallversorgung geschult werden. Da die geforderte Regelmäßigkeit nicht mit einer Zeitangabe präzisiert wird, hat sich die Expertin dazu entschieden, alle zwei Jahre eine offizielle Erste-Hilfe-Schulung anzusetzen[264]. Da das Stammpersonal seit Eröffnung dasselbe ist, müsste die Schulung nächstes Jahr erneut erfolgen[265]. Kommen neue Mitarbeiter oder fangen Minijobber an, bei KOMBO zu arbeiten, so werden sogenannte „GFB-Abende“ oder „Minijobberabende“ veranstaltet, an denen das neue Personal geschult wird[266]. Minijobber arbeiten zwar primär im Kontaktcafé, jedoch kann es auch im Kontaktcafé zu Notfallsituationen kommen, wenn sich ein Nutzer nach dem Konsum im Kontaktcafé aufhält. Aus diesem Grund ist eine Schulung für das gesamte Personal essenziell. Über die offiziellen Erste-Hife-Schulungen hinaus schult sich das Personal regelmäßig teamintern. Unter den Mitarbeitenden finden sich unter anderem Pflegekräfte, die diese teaminternen Schulungen durchführen[267]. Beispielsweise haben sie sich innerhalb des Sozialarbeiterteams Schulungen zu Nadelstichverletzungen gegeben. Kurze Zeit vor dem Interview hat sich das Team zur Auffrischung eine Reanimationspuppe zugelegt und eine Person des Rettungsdienstes eingeladen, welche ihnen einen Crashkurs zum Thema Reanimation gegeben hat[268]. Hierfür wurde die Einrichtung zwar für ein paar Stunden geschlossen, jedoch sind solche Schulungen als sehr wichtig und essenziell zu betrachten.

[261] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[262] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[263] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[264] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[265] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[266] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[267] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[268] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …

3.3.6.2 §6 Maßnahmen zur Verhinderung von Straftaten

Gem. §6 DrogKRV BW muss eine Hausordnung erlassen werden, in der geregelt wird, dass jegliche Straftaten, mit Ausnahme des Besitzes der geringen Menge, nicht geduldet werden. Auf die erlassene Hausordnung wurde unter Kapitel „2.3.4.1 Hausordnung“ bereits eingegangen. Eine typische zu unterbindende Straftat innerhalb der Einrichtung ist der Drogenhandel gem. §29 (1) S. 1 Nr. 1 BtMG. Hier sagt die Expertin klar, dass sich das Handeln in der Einrichtung nicht vollständig vermeiden lässt, da dieser Handel ebenfalls Teil des Konsums ist und jeder weiß, dass er stattfinden muss, um im Konsumraum konsumieren zu können[269]. Das Unterbinden des Handels beginnt aber schon vor der tatsächlichen Übergabe. So werden Personen des Hauses verwiesen, wenn das Personal allein schon Absprachen mitbekommt oder wenn jemand den Konsumraum betritt, ohne seine eigene Substanz dabei zu haben und nur schauen möchte, wer gerade im Konsumraum ist[270]. Da das Personal nicht alles mitbekommen kann, hat KOMBO auch einen Sicherheitsdienst während den Öffnungszeiten, der ebenfalls auf solche Verhaltensweisen achtet[271] und bei der Unterbindung dieser unterstützt. Eine Anzeige wird, wie in der DrogKRV BW geregelt, erst erstattet, wenn den Anweisungen des Personals keine Folge geleistet wird. Dies komme laut der Expertin eher selten vor. Eher werde manchmal getestet, wo die Grenzen liegen und Personen mit einem Hausverbot würden versuchen, erneut die Einrichtung zu betreten. Weist man diese Personen auf das Hausverbot hin, folgen sie diesem i.d.R. und verlassen die Einrichtung wieder[272]. Nach Katholnigg ist zu prüfen, inwiefern dem Personal diese Aufgabe im Hinblick auf das Vertrauensverhältnis zu den Nutzern zumutbar ist, denn es könnte die Gefahr bestehen, dass das Personal durch die Überwachung das Vertrauen der Klienten verliert[273]. Auf Nachfrage antwortet die Expertin, dass diese Gefahr zwar besteht, jedoch nicht bei allen Nutzern. Demnach kann das Unterbinden der Straftaten sich negativ auf das Vertrauensverhältnis auswirken, wenn die betroffene Person das eigene Verhalten selbst beispielsweise als nicht schlimm wahrnimmt[274]. Im Gegensatz dazu kann genau dieses Unterbinden anderen Nutzern aber signalisieren, dass KOMBO wirklich ein Schutzraum sein soll und sie auch vom Personal vor unerwünschten Nutzern geschützt werden[275]. Die Expertin ergänzt, dass sie die negativen Auswirkungen auf das Vertrauensverhältnis mit einer Person in Kauf nehme, wenn sie dafür das Gefühl hat, fünf andere Nutzer geschützt zu haben. Denn bspw., genau durch Nutzer, die in der Einrichtung versuchen, ihre Drogen zu verkaufen, können bei anderen Nutzern Triggerpunkte getroffen werden, was durch das konsequente Einschreiten des Personals verhindert werden kann[276]. Somit ist die Untebrindung der Straftaten ein zentraler Aspekt der Arbeit im Konsumraum, der die ständige Aufmerksamkeit des Personals

[269] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[270] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[271] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[272] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[273] Vgl. Katholnigg NJW 2000
[274] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[275] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[276] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …

fordert und sich zwar negativ auf das Vertrauensverhältnis zu bestimmten Nutzern auswirken kann, hier aber der positive Nutzen für einen Großteil andere Nutzer überwiegt.

3.3.6.3 §8 Nutzerinnen- und Nutzerkreis, Konsumstoffe und Konsumieren

Gem. §8 (1) DrogKRV BW dürfen grds. nur volljährige Personen, im Einzelfall auch Jugendliche, mit Betäubungsmittelabhängigkeit und Konsumerfahrung den Konsumraum nutzen. Besonders bei jugendlichen Nutzern stellt sich die Frage, wie sich über die Betäubungsmittelabhängigkeit und die nötige Konsumerfahrung vergewissert wird. Hierfür muss jeder Nutzer bei seiner Registrierung einen Aufnahme-, beziehungsweise Anamnesebogen ausfüllen. Dieser ist der Arbeit ebenfalls als Anhang[277] beigefügt. In diesem Bogen werden neben den Personalien auch die bisherigen Konsumerfahrungen durch das Erfragen des Alters beim Erstkonsum, der hauptsächlich konsumierten Substanzen und Konsumformen, Orte des Drogenkonsums und Anbindung an bisherige Hilfsangebote erfragt. Laut der Expertin wird hier schnell klar, wer falsche Angaben macht. Bisher habe das Personal noch keine Probleme damit gehabt und noch nie eine Person abweisen müssen, weil der Verdacht bestand, dass die Person noch keine richtigen Konsumerfahrungen hat[278]. Somit kann also gesagt werden, dass bisher nur Konsumenten der gewünschten Zielgruppe KOMBO aufgesucht und in den Räumlichkeiten konsumiert haben.

Nach Absatz zwei sind u.a. erkennbar intoxikierte Personen von der Nutzung auszuschließen. Jedoch ist, laut der Expertin, dieser Ausschluss auch unter starker Intoxikation einzelfallabhängig, da KOMBO nach dem Leitsatz „jeder Konsumvorgang hier drin ist besser als draußen“[279] arbeitet. Kommt eine Person stark alkoholisiert in den Konsumraum, wird zunächst geprüft, ob nicht weitere Hilfsangebote wie eine Dusche oder ein kurzer Schlaf auf der Couch angebrachter wären[280]. Dennoch, äußert die Person, dass sie auf jeden Fall konsumieren wird, notfalls auch im gegenüberliegenden Parkhaus, gewährt das Personal lieber den Zutritt zum Konsumraum, anstatt diese Person abzuweisen[281]. Diese Herangehensweise kann so gedeutet werden, dass durch das Abweisen von stark intoxikierten Personen, die mit großer Wahrscheinlichkeit trotzdem konsumieren, niemand mehr geschützt wird, sondern das Gesundheitsrisiko vielleicht sogar eher erhöht wird. Bei einer starken Intoxikation ist besonders die Konsumerfahrung, bezogen auf die Toleranz und bisherige Erfahrung mit Mischkonsum, zu beachten. Es kann also deutlich sinnvoller sein, dass gerade diese Konsumentengruppe, bei der das Risiko einer Überdosis oder eines Notfalls durch bereits bestehende Intoxikation erhöht ist, im Konsumraum konsumieren, wo schnell eingegriffen werden kann, sollte sich der Zustand zunehmend verschlechtern.

---

[277] Anhang Nr.
[278] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[279] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[280] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[281] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …

Nach Absatz drei sind die mitgeführten Btm einer Sichtkontrolle zu unterziehen. Hier sagt die Expertin klar, dass im Rahmen dieser Sichtkontrolle wenig Informationen gesammelt werden können. „Im Endeffekt, die Leute zeigen uns irgendein Pulver. Ob es jetzt das ist oder das, kann ich überhaupt nicht beurteilen“[282] und bestätigt damit die zuvor vom Verfasser der Arbeit geäußerten Bedenken. Ein klarer Vorteil dieser Kontrolle sei jedoch, dass im Falle eines Notfalls den Kräften des Rettungsdienstes weitergegeben kann, welche Substanz konsumiert wurde, beziehungsweise zum Konsum angegeben wurde[283]. Zudem wird dadurch, dass die geduldeten Substanzen nicht begrenzt sind, davon ausgegangen, dass die Angaben der Personen der Wahrheit entsprechen[284]. Bei der Sichtkontrolle wird laut der Expertin dementsprechend weniger auf die Substanz an sich geachtet und mehr darauf, „dass wirklich jeder sein Eigenes auch hier reinbringt“[285]. Zwar ist hier ebenfalls der unterschiedliche Bedarf zu beachten, jedoch wird der Konsum unterbunden, sollte jemand „einen Kilobeutel“[286] mitbringen.

3.3.7 Ungeklärte Bereiche

Trotz ausführlicher Voraussetzungen und Regelungen des §10a BtMG und der DrogKRV BW stößt das Personal oftmals auf Sachverhalte, die noch nicht oder nicht ausreichend erfasst und geregelt sind. Im Folgenden werden diese Situationen aus Sicht der Expertin geschildert.

Einer dieser Sachverhalte bezieht sich auf die oben bereits angesprochene 16-jährige Person. Denn laut der Expertin gibt es bislang keine Regelungen oder Konzepte darüber, wie mit Minderjährigen Nutzern in Bezug auf den Kinderschutz zu verfahren ist. So stellt sich besonders bei der Nutzung durch Minderjährige die Frage, ab wann eine Kindeswohlgefährdung vorliegt und ab wann das Personal einschreiten, beziehungsweise entsprechend zuständige Behörden informieren muss[287]. Diese Thematik kam erst kurz vor dem Interview auf, da genau diese 16-jährige Person von einer schweren Notfallsitaution im Konsumraum betroffen war[288]. Der Expertin ist jedoch klar, dass nur, weil eine Person minderjährig ist und im Konsumraum konsumiert, nicht automatisch von einer Kindeswohlgefährdung ausgegangen werden muss[289]. Bezogen auf Minderjährige Nutzer kann gesagt werden, dass es wahrscheinlich für gerade diese Konsumentengruppe besonders wichtig ist, in einem geschützten Umfeld zu konsumieren, da durch Notfallsituationen mehr bleibende Schäden verursacht werden können als bei bereits erwachsenen Personen. So ist bei minderjährigen Konsumenten eine schnelle Notfallversorgung als besonders wichtig anzusehen. Die gleiche Thematik betrifft auch Nutzer, bei denen ein Kind im Haushalt

[282] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[283] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[284] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[285] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[286] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[287] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[288] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[289] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …

lebt. Denn laut der Expertin sollten allein in solchen Situationen schon „Alarmglocken angehen“[290]. Hier besteht also dringender Handlungsbedarf.

Ein weiterer Sachverhalt bezieht sich auf das Mitführen und Entsorgen von Substanzen. Es ist klar vorgeschrieben, dass die Substanzen zum Eigenverbrauch mitgeführt werden. Es ist aber nicht geregelt, was in Fällen passiert, in denen die mitgeführte Substanz zwar unter die Maximalmenge fällt, jedoch während des Konsums bemerkt wird, dass zu viel mitgebracht wurde. So kann es passieren, dass Nutzer ihre Substanz aufkochen, die Spritze aufziehen, konsumieren, nach dem Konsum aber noch die Hälfte der Substanz in der Spritze haben, weil sie merken, dass es gerade für diesen Moment reicht[291]. Da diese Spritze nicht mitgenommen werden darf, haben die Nutzer in diesen Fällen entweder die Wahl, die Spritze samt Restsubstanz wegzuschmeißen oder die Substanz vollständig zu konsumieren. Laut der Expertin fällt hier in fast allen Fällen die Wahl auf den Konsum der restlichen Substanz, was klar der Zielsetzung und dem Konzept von KOMBO widerspricht[292]. Denn eigentlich gehört gerade diese Situation, dass die Konsumenten merken, wann es genug ist, zur Zielsetzung im Sinne des Safer-Use. Denn durch genau diese Regel und die durchaus nachvollziehbare Entscheidung, die Reste zu konsumieren, da die Nutzer sonst viel Geld wegschmeißen würden, werden Überdosierungen in gewisser Hinsicht provoziert, die vielleicht ohne den Konsumraum so gar nicht passiert wären, da der Konsument zu Hause bspw. später weiterkonsumieren würde. Dieses Weiterkonsumieren zu einem späteren Zeitpunkt wird in der Konsumraumumgebung aber nicht geduldet, beziehungsweise nicht ausreichend geregelt. Hier ist aber klar das Gegenargument anzubringen, dass dadurch die Chance oder Gefahr erhöht wird, dass die Substanz entweder abgegeben wird und jemand anderem zum Konsum überlassen wird oder sogar die gesamte benutzte Spritze weitergegeben wird und so wieder unhygienische Konsumbedingungen geschaffen werden.

Hier wird aber erneut deutlich, dass ein DKR kein finales Konzept ist, sondern sich immer wieder im Wandel befindet und neuen Herausforderungen gegenübersteht. Denn laut der Expertin müssen manche Dinge erst passieren, damit solche fehlenden Regelungen auffallen[293] .

3.3.8 Ausblick in die Zukunft

3.3.8.1 Neuer Standort

Wie bereits unter Kapitel „1.3.2.1 Rahmenbedingungen“ beleuchtet, ist durchaus zu diskutieren, ob der jetzige Interimsstandort bezogen auf die Örtlichkeit nicht der besser geeignete Standort wäre, die Zielsetzung von KOMBO zu erreichen. Was aus Sicht des Verfassers deutlich für die Örtlichkeit im Leonhardsviertel sprechen würde, ist die Nähe zu der in der Vergangenheit belasteten Jakobschule und zur Leonhardskirche. Die Nähe

[290] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[291] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[292] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[293] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …

zur Leonhardskirche ist v.a. im Zeitraum der Vesperkirche sinnvoll, da sich viele Konsumenten und potenzielle Nutzer dadurch schon im Umfeld von KOMBO aufhalten und der Weg in den Konsumraum so um einiges kürzer wäre als in den eigentlichen Standort in der Ossietzkystraße. Dass sich dieser kurze Weg, beziehungsweise das vermehrte Aufhalten in der Nähe von KOMBO positiv auf die Nutzungshäufigkeit auswirkt, hat sich bereits diesen Februar gezeigt, der trotz steigender monatlicher Nutzerzahlen bislang immer noch der stärkste Monat für KOMBO war. Solche Zeiten wie zur Vesperkirche eignen sich besonders gut für potenzielle Nutzer, das Angebot von KOMBO auszuprobieren, sollten sonst die Wege zu lang sein oder das Umfeld selten aufgesucht werden. Die Expertin ist jedoch anderer Meinung. Auf Nachfrage antwortet sie, dass sie den Interimsstandort nicht unbedingt als besser ansehen würde. Grund dafür ist, dass bevor KOMBO eingerichtet wurde und das Gebäude noch das „High Noon" war, es bereits vor dem Gebäude das Angebot eines Spritzenabwurfs und eines Spritzenschalters gab. Hier hatten Konsumenten die Möglichkeit, 365 Tage im Jahr Spritzen im eins zu eins Verhältnis zu tauschen und so frisches Konsumbesteck für das ordnungsgemäße Entsorgen von benutztem Konsumbesteck zu erhalten[294]. Dadurch, dass die Problematik der Spritzenfunde, trotz dieser Angebote, in der Vergangenheit immer weiter zugenommen hat und zu dieser Zeit bereits viele Spritzen gefunden wurden, würde sie nicht sagen, dass KOMBO einen großen Einfluss darauf hatte[295]. Denn auch jetzt noch, obwohl es KOMBO gibt, werden täglich weggeworfene Spritzen aufgesammelt[296]. So besteht laut der Expertin im Umfeld des Interimsstandorts auf jeden Fall eine Szene, v.a. durch das dort befindliche Rotlichtviertel. Jedoch gibt es auch am Hauptbahnhof eine Drogenszene. Im besten Fall werden beim Umzug „eine Hand voll Leute" mitgenommen[297]. Ein deutlicher Vorteil des neuen Standorts in der Ossietzkystraße sei die Größe und die Barrierefreiheit. Denn derzeit ist KOMBO dadurch, dass sich der Konsumraum im zweiten Stock des Gebäudes befindet, nicht barrierefrei und erfülle somit nicht die Voraussetzungen der DrogKRV BW[298]. Aufgrund dessen liegt für den Interimsstandort nur eine Ausnahmegenehmigung vor, bis der vorgesehene Standort bereit ist, bezogen zu werden[299]. Durch die fehlende Barrierefreiheit bleiben auch manche potenziellen Nutzer noch unerreicht[300]. Die Größe des neuen Standorts ist hier als größter Vorteil zu sehen. So kommt es durch die deutlich begrenzte Anzahl an Konsumplätzen zu Wartezeiten, was die Konsumenten unter Suchtdruck dazu verleiten kann, öffentlich zu konsumieren. V.a. beim inhalativen Konsum sind Wartezeiten ein Problem, da KOMBO bisher nur über einen Platz in der „Smokebox" verfügt. Insgesamt verfügt KOMBO über vier Konsumplätze, drei für den intravenösen, nasalen und oralen Konsum und ein Platz für den inhalativen Konsum. Im neuen Standort erhöht sich die Zahl auf zwölf Konsumplätze. Hiervon werden sechs

[294] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[295] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[296] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[297] Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[298] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[299] Vgl. Beschlussvorlage 0118/2026, S. 3
[300] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …

Plätze für den intravenösen, nasalen und oralen Konsum und sechs Plätze für den inhalativen Konsum bestimmt sein[301]. Hierdurch erhofft sich das Personal von KOMBO nochmal mehr Konsumenten zu erreichen. Denn v.a. Crack sei eine Droge, die besonders gerne in Gemeinschaft konsumiert wird[302], was im jetzigen Standort schlichtweg nicht möglich ist. Unter dem Konsum in Gemeinschaft ist hier nicht das Teilen der Substanz, sondern das gleichzeitige, eigenständige Konsumieren zu verstehen.

Es kann also gesagt werden, dass das Leonhardsviertel sowohl mit als auch ohne KOMBO von der örtlichen Drogenszene betroffen ist. Dabei ist es bisher unklar, inwiefern sich KOMBO wirklich auf das Leonhardsviertel auswirkt. Bezogen auf die Wirksamkeit des Standortes ist ein größerer Fokus auf die angesprochenen Konsumenten und die Verbesserung ihrer Situation zu legen. So ist jeder Standort und jede Örtlichkeit die bessere, bei der eine größere Zahl an Konsumenten erreicht werden, die den Konsumraum nutzen und die Angebote in Anspruch nehmen.

[301] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …
[302] Vgl. Anhang Nr. … Seite …. Zeile …

III. Fazit

Abschließend lässt sich also sagen, dass auch KOMBO grds. die Zielsetzungen eines DKR erreicht. So spricht KOMBO ausschl. die gewünschte Zielgruppe an. Zwar bleiben bisher viele Konsumenten nicht erreicht, jedoch ist davon auszugehen, dass die Nutzerzahl, v.a. ab Eröffnung des neuen Standorts, weiter ansteigen wird. Auch bei KOMBO ist ein Missverständnis unter den Nutzern zw. Männern und Frauen festzustellen, jedoch wird dieses in Stuttgart, anders als in der Vergangenheit in Hamburg, nicht als ein Problem gesehen. KOMBO hatte über das vergangene Jahr v.a. in Bezug auf den Gesundheitszustand der Nutzer einen gespaltenen, aber durchaus positiven Nutzen. Denn erfreulicherweise, trotz zahlreicher Notfälle und einer Reanimation, kam es bisher zu keinen Todesfällen innerhalb der Einrichtung. Es ist davon auszugehen, dass mind. die reanimierte Person außerhalb der Einrichtung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ohne weiteres unbeschadet überlebt hätte. Dadurch erfordert die Arbeit in der Einrichtung die ständige Aufmerksamkeit des Personals und auch beim Unterbinden des Drogenhandels innerhalb der Einrichtung ist das Personal ständig gefordert. Der Nutzen von KOMBO ist für jeden Nutzer individuell zu betrachten und bietet dementsprechend, wie in der Arbeit aufgezeigt, auch nicht jedem Nutzer einen positiven Mehrwert. Unter den Nutzern von KOMBO befand sich zwar die Mehrheit bereits in externen Hilfeprogrammen, jedoch hilft KOMBO auch dabei, diese wieder an das Suchthilfesystem anzugliedern. Dabei ist die Annahme der Angebote durch die Nutzer wie ein Prozess zu betrachten, weshalb sich der Nutzen sowohl auf Konsumentenebene als auch auf ordnungspolitischer Ebene nur mit zeitlicher Verzögerung bemessen lässt. Es kann auch gesagt werden, dass die zuvor geäußerten Bedenken, bspw. Einer Sogwirkung, nicht eingetreten sind. Die Arbeit hat ebenfalls verdeutlicht, dass sowohl KOMBO als auch §10a BtMG und die DrogKRV BW nicht wie ein finales Produkt gesehen werden dürfen. So wie der Drogenmarkt und die Drogenszene sollten sich auch KOMBO und die gesetzlichen Rahmenbedingungen immer im Wandel befinden und an die aktuellen Prozesse und Bewegungen angepasst werden. Dieser nötige Wandel verdeutlicht sich besonders in der Erweiterung durch den in der Praxis festgestellten Regelungsbedarf. Ein zentraler Mehrwert von KOMBO liegt dabei ein der Nähe zu den Konsumenten und dadurch gewährten Einblicken in die Szene, wodurch ein solcher Handlungsbedarf frühzeitig erkannt und schnell umgesetzt werden kann.

1 Ausblick und weiterer Forschungsbedarf

Es gilt abzuwarten, wie sich KOMBO in Zukunft entwickelt und wie sich die Auswirkungen der Einrichtung weiter bemerkbar machen. Dabei wird besonders interessant zu sehen, inwiefern die durch §10b BtMG und die in Zukunft erlassene Landesverordnung

über die Durchführung von Modellvorhaben zu Substanzanalysen, welche bereits entworfen wurde[303], umgesetzt werden. Besonders in der Hinsicht, ob dafür externe Angebote geschaffen werden oder ob KOMBO selbst solche Substanzanalysen durchführt. Des Weiteren muss im Zuge dessen die DrogKRV überarbeitet werden. Ein zentrales Ereignis in der Zukunft von KOMBO ist der Standortwechsel in die Ossietzkystraße. Hier wird ebenfalls interessant zu sehen, wie sich der neue Standort etabliert und sich dieser auf die Auslastung der Einrichtung und das Nutzungsverhalten der Konsumenten auswirkt.

Die vorliegende Arbeit hat sich primär auf die Sicht der Einrichtung bezüglich der Umsetzung des Konzeptes eines DKR fokussiert und zusätzlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen aufgearbeitet. Weitergehende Forschungen könnten sich mit einer Evaluation der Einrichtung aus Nutzersicht befassen und dabei mithilfe von Umfragen das Nutzungsverhalten, Änderungen im Konsumverhalten, den aus Konsumentensicht positiven und negativen Aspekten der Einrichtung und Gründen der ausbleibenden Nutzung der Einrichtung analysieren

[303] O.V. 2026, „Land bereitet Drug-Checking-Verordnung vor“ https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-bereitet-drug-checking-verordnung-vor abgerufen: 30.09.2026 21:07 Uhr

Literaturverzeichnis

Anhangsverzeichnis

1. HAUSORDNUNG VIII

2. KONSUMREGELN IX

3. KOOPERATIONSVEREINBARUNG 1

4. INTERVIEWLEITFADEN 1

5. TRANSKRIPTION 1

6. ERSTAUFNAHMEBOGEN XIII

1. Hausordnung

release Stuttgart e.V.

caritas STUTTGART

Hausordnung

Drogenkonsumraum in gemeinsamer Trägerschaft des Caritasverbandes für Stuttgart e.V. und Release Stuttgart e.V.

1. Die Hausordnung gilt in dem Drogenkonsumraum (Konsumplätze und Wartebereich), Lazarettstraße 8, 70182 Stuttgart für die Dauer des Betriebs im Rahmen der Öffnungszeiten.

2. Der Zutritt ist nur volljährigen Personen gestattet. Begleitpersonen haben keinen Zutritt. Keinen Zutritt haben Erst- und Gelegenheitskonsumierende, erkennbar intoxikierte Personen und Personen, denen erkennbar die Einsichtsfähigkeit in die durch die Applikation erfolgende Gesundheitsschädigung fehlt. Vor der erstmaligen Nutzung ist die Nutzungsvereinbarung zu unterzeichnen.

3. Den Anweisungen des Personals ist ausnahmslos Folge zu leisten. Die Konsumregeln sind einzuhalten. Wir erwarten einen freundlichen, respektvollen Umgang miteinander (ohne Gewalt, Sexismus, Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art).

4. Verboten sind:

- Verstöße gegen das BtMG, auch der Besitz von Drogen – geduldet wird ausschließlich die zum sofortigen Konsum im Drogenkonsumraum bestimmte und von § 8 Abs. 3 Satz 3 DrogKRV BW 2022 umfasste geringe Menge zum Eigenverbrauch (§§ 31a Abs. 1 Satz 3; 10a BtMG; § 6 Abs. 1 Satz 2 DrogKRVO BW 2022)
- jegliche Ab- und Weitergabe, auch das Teilen, von Drogen, Konsumutensilien (auch Filter etc.) und/oder Medikamenten
- Abpacken, Rationieren von Drogen und/oder Medikamenten
- der Konsum von Alkohol und Cannabis
- der Konsum von Nikotin. Ausnahme ist der Konsum von Nikotin in der "Smokebox" zur Vorbereitung oder während des Crackkonsums.
- Messer und andere Waffen
- das Mitbringen von Hunden und anderen Haustieren

Bei Zuwiderhandlung erfolgt zwingend Konsumraumverbot!

2. Konsumregeln

release Stuttgart e.V.

caritas STUTTGART

Konsumregeln für den Drogenkonsumraum

- Die mitgeführten Betäubungsmittel sind dem Personal an der Anmeldung zur Sichtkontrolle vorzuzeigen.
- Mobilgeräte, Smartphones etc. dürfen nicht genutzt werden. Bild- und Tonaufnahmen sind verboten
- Vor und nach dem Konsum müssen die Hände gewaschen und desinfiziert werden
- Es dürfen nur vom Drogenkonsumraum zur Verfügung gestelltes Spritzbesteck, Löffel, Folien, Filter und Scheren verwendet werden.
- Das Mitbringen von Filtern, Aufkochen von Filtern sowie das Mitnehmen von Filtern ist nicht gestattet.
- Betäubungsmittel oder Spritzbesteck dürfen nicht geteilt werden.
- Das Öffnen der „Plombe“ erfolgt mit der Schere.
- Jede Person konsumiert für sich allein. Betäubungsmittel dürfen nicht gegenseitig injiziert werden. Es wird keine aktive Hilfe geleistet.
- Die Injektionsstelle wird vor dem Konsum desinfiziert.
- Nadeln dürfen nicht abgebrochen werden, mit „offener“ Nadel darf nicht herumgelaufen werden.
- Benutztes Spritzbesteck, Verpackungsmaterial und Filter sind in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen.
- Der inhalative Konsum erfolgt ausschließlich in dem hierfür vorgesehenen Bereich. Für den inhalativen Konsum dürfen Pfeifen mitgebracht werden.
- Der Konsumplatz wird nach dem Konsum gereinigt und desinfiziert.
- Nach Abschluss des Konsumvorgangs ist der Konsumraum zeitnah zu verlassen.

  Bei Zuwiderhandlung erfolgt ein Konsumraumverbot!

- Es wird empfohlen, vor Verlassen des Konsumraums den Sauerstoffgehalt im Blut mit einem Oxymeter durch das Personal überprüfen zu lassen.
- Wir weisen darauf hin, dass das Führen von Kraftfahrzeugen unter der Wirkung berauschender Mittel verboten ist.

3. Kooperationsvereinbarung

Kooperationsvereinbarung

Drogenkonsumraum Stuttgart

Vereinbarung über die Grundzüge der Zusammenarbeit zum Betrieb des Drogenkonsumraumes in der Landeshauptstadt Stuttgart auf der Grundlage des S 7 der „Verordnung der Landesregierung über den Betrieb von Drogenkonsumräumen" vom 26.07.2022

Mit der „Verordnung der Landesregierung über den Betrieb von Drogenkonsumräumen" vom 26.07.2022 der Landesregierung Baden-Württemberg (im Weiteren als „Verordnung" benannt) liegen die rechtlichen Voraussetzungen zum Betrieb eines Drogenkonsumraumes in der Landeshauptstadt Stuttgart vor. Auf dieser Grundlage werden die Suchthilfeträger Caritasverband Stuttgart e.V. und Release Stuttgart e.V. (Nachfolgend: Caritasverband Stuttgart und Release)
gemeinsam einen Drogenkonsumraum in der Lazarettstraße 8, 70182 Stuttgart betreiben.

Die unterzeichnenden Organisationen vereinbaren vor diesem Hintergrund folgende Grundsätze der Zusammenarbeit im Rahmen des Betriebes des Drogenkonsumraums:

1. Die Zusammenarbeit im Rahmen dieser Vereinbarung wird getragen von:

   - Caritasverband Stuttgart
   - Release
   - Amt für öffentliche Ordnung LHS Stuttgart
   - Sozialamt der LHS Stuttgart
   - Polizeipräsidium Stuttgart
   - Staatsanwaltschaft Stuttgart

2. Die Vertreter_innen der unterzeichnenden Institutionen werden einen regelmäßigen gegenseitigen Austausch sowohl auf administrativ-strategischer als auch auf operativer Ebene pflegen.

   Auf der übergeordneten Ebene wird dazu eine Steuerungsgruppe etabliert, deren Mitglieder von den beteiligten Organisationen namentlich benannt werden, und die halbjährlich tagt. Darüber hinaus benennen die Organisationen ihre jeweilige Ansprechpartnerzinnen für unmittelbare Absprache im operativen Bereich.

   Die Einladungen werden von dem Suchthilfeplaner der LHS Stuttgart ausgesprochen. Anlassbezogene Sitzungen sind jederzeit möglich und können von allen Organisationen initiiert werden.

   Die Steuerungsgruppe verfolgt die Aufgabe, den Stand der Zielerreichung gem. § 2 der Landesverordnung fortlaufend zu diskutieren und ggf. Korrekturmaßnahmen zu beschließen.

Der Austausch auf der operativen Ebene erfolgt regelmäßig zwischen der Leitung des Drogenkonsumraumes, der Polizei, dem Amt für öffentliche Ordnung und dem Suchthilfeplaner der LHS Stuttgart. Da dieser Austausch im Rahmen der Kooperation bezüglich des bisher vom Caritasverband betriebenen Kontaktladens in der Lazarettstraße 8 bereits gelebte Praxis darstellt, muss dieser operative Austausch nicht neu etabliert werden, sondern lediglich thematisch um den Drogenkonsumraum erweitert werden. Zukünftig werden der Kontaktladen und der Drogenkonsumraum als integriertes Angebot von Caritasverband und Release betrieben.

3. Die Träger Caritasverband Stuttgart und Release stellen die Dokumentation des Tagesgeschäftes gem. den Anforderungen der Landesverordnung sicher. Dazu zählt insbesondere das Verfassen von Tages- und Monatsberichten gem. S 9 der Verordnung.
   Neben den gem. § 9 der Verordnung zu dokumentierenden Punkten ist insbesondere auch die Beobachtung der Auswirkungen des Drogenkonsumraumes auf das umgebende Stadtquartier gem. § 7 und die Dokumentation festgestellter Straftaten gem. § 6 Abs. 2 der Verordnung Bestandteil der Dokumentation.

   Die Steuerungsgruppe erhält die anonymisierten Monatsberichte zur Kenntnis.

4. Inhaltliche Änderungen im Dokumentationsverfahren, der Hausordnung oder wesentliche Ablaufänderungen, die den Betrieb des Drogenkonsumraumes betreffen, sind der Steuerungsgruppe bekannt zu geben und dort abzustimmen.

5. Die Vertreter_innen der unterzeichnenden Organisationen sind sich darüber einig, dass weder der Drogenkonsumraum selbst, noch das Umfeld einen rechtsfreien Raum darstellen. Gleichzeitig gewährleisten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Stuttgart aber auch, dass beim Vorgehen gegen strafrechtlich relevante Handlungen die Akzeptanz des Drogenkonsumraumes bei den Suchtkranken nicht gefährdet wird. Die polizeilichen Maßnahmen werden sich im unmittelbaren Umfeld an den Vorgaben des § 31a Abs. 1 Satz 2 BtMG orientieren. Diese Vorschrift lautet wie folgt: „Von der Verfolgung soll abgesehen werden, wenn der Täter in einem Drogenkonsumraum Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch, der nach § 10a geduldet werden kann, in geringer Menge besitzt, ohne zugleich im Besitz einer schriftlichen Erlaubnis für den Erwerb zu sein. *(Variante DKR Freiburg)*

   Weder der DKR selbst, noch das Umfeld stellen einen rechtsfreien Raum dar. Die Vertreter*innen der unterzeichnenden Parteien sind sich darüber einig, dass das Polizeipräsidium Karlsruhe weiterhin gegen jede strafrechtlich relevante Handlung auch im Umfeld des DKR vorgeht, gleichzeitig dieses Umfeld mit Betrieb des DKR aber nicht zum intensivierten Schwerpunkt von Bestreifung, Kontrollen oder ähnlichen Maßnahmen macht.
   (Variante DKR Karlsruhe)

6. Die Hausordnung (siehe Anlage) wurde mit den Unterzeichnenden in der vorliegenden Fassung abgestimmt

Ort, Datum	Vorstand Caritasverband Stuttgart
Ort, Datum	Vorstand Release
Ort, Datum	Amt für öffentliche Ordnung LHS Stuttgart Amtsleiterin
Ort, Datum	Sozialamt LHS Stuttgart Amtsleiterin
Ort, Datum	Polizeipräsidium Stuttgart Der Polizeipräsident
Ort, Datum	Staatsanwaltschaft Stuttgart Der Leitende Oberstaatsanwalt

4. Interviewleitfaden

Einleitung

- Begrüßung
- Für die Bereitschaft zur Durchführung des Interviews bedanken
- Für die vorherige Bereitstellung der Dokumente bedanken, die mir sehr bei der Erarbeitung und der Vorbereitung des Interviews geholfen haben
- Ziel der Untersuchung und welche Rolle das Interview dabei spielt
- Hinweis auf die Audioaufzeichung des Gesprächs zur Transkription im Nachgang (wie bereits zuvor per E-Mail besprochen) und Einverständnis dazu
- Hinweis, dass sie nicht auf Fragen antworten muss, die ihr unangenehm sind
- Hinweis, dass sollte sie Bedenkzeit brauchen, wir Fragen verschieben können oder eine kurze Pause machen können
- Hinweis darüber, dass ihre Position in der Arbeit erwähnt wird

Interview

Einstiegsfrage: Zum Einstieg erläutern, wie sich der Konsumraum im letzten Jahr im Suchthilfesystem in Stuttgart etabliert hat

Themenblock 1: Zielgruppe

Wie wird der Konsumraum von den Konsumenten angenommen?

- Wiederkehrende Nutzer - wie oft ungefähr pro Woche?
- Anstieg der neuen Nutzer / Nutzerzahlen seit Eröffnung (auch im Vergleich zum Jahresbericht)
- Positive Rückmeldungen der Nutzer

Welche Zielgruppe wird angesprochen?

- Sind die Nutzer bereits an das Suchthilfesystem angegliedert
- Werden tatsächlich neue Nutzergruppen angesprochen? - Dient der Konsumraum tatsächlich als Brücke in das Suchthilfesystem; falls nein: Wieso? Wie könnte man diese Konsumentengruppen besser ansprechen?

- Gibt es Konsumentengruppen, die das Angebot besonders nutzen oder bisher noch gar nicht benutzt haben?

Was zeichnet einen typischen Nutzer aus (Musterbeschreibung)

- Geschlecht, Alter, Konsumverhalten, langjährige Suchtbelastung
- Wie könnten mehr Frauen angesprochen werden?
- Was ist das Nutzungsmuster / Grund für die Nutzung (nur der Konsum oder auch Inanspruchnahme weiterer Hilfen)

Themenblock 2: Erreichung der Zielsetzungen

Gibt es bemerkbare Veränderungen bei wiederkehrenden Nutzern?

- besserer Gesundheitszustand; auch außerhalb des Konsumraums hygienischeres Konsumverhalten, Verbesserung der Suchtbelastung

Inwiefern wirkt sich der Konsumraum auf die gesamte Drogenszene in Stuttgart aus?

- mehr Drogentote (Verdopplung von 2024 zu 2025)
- Wie erklären Sie sich den Anstieg der Drogentoten im Jahr 2025
- eventuelle Deutung, dass der Konsumraum stärkere Verbesserungen für den einzelnen Nutzer aufweist, als auf die komplette Drogenszene als Gesamtes?

Gibt es Rückmeldungen aus dem direkten Umfeld zu den Auswirkungen des Konsumraums?

- weniger öffentliche Belastung, weniger offene Drogenszene

Wird der Konsumraum auch von Klientenseite als tatsächliche Ausstiegshilfe gesehen?

- Wie viele nehmen das Angebot der Weitervermittlung in Anspruch
- Wie funktioniert die Weitervermittlung in weitere Hilfsangebote
- Ereignet sich die Weitervermittlung als unproblematisch oder gibt es Hürden / Verzögerungen (lange Wartezeiten)

Themenblock 3: Die Arbeit im Konsumraum

Könnten Sie einen typischen Besuch im Konsumraum / Konsumvorgang beschreiben?

- namentliche Registrierung der Nutzer (begrenzte Plätze?)

- Sichtkontrolle - auf was wird geachtet?

Gibt es Auffälligkeiten der konsumierten Substanzen?

- welche werden am meisten / besonders häufig konsumiert
- Wandel der Konsumform

In der ersten Pressemitteilung nach einem Jahr Betrieb wird gesagt, dass Sie im neuen Standort mehr Potenzial sehen. Inwiefern bezieht sich dies auch auf das Umfeld, beziehungsweise die Drogenszene als Gesamtes?

- Jetziger Standort im zuvor stark belasteten Leonhardsviertel
- Ist nur die Immobilie besser oder auch der tatsächliche Standort?

Themenblock 4: Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Gem. der Rechtsverordnung muss Ihre Arbeit dokumentiert und evaluiert werden. Als wie umsetzbar gestaltet sich diese Vorschrift?

- eventuelle Hinderung der Arbeit
- oder aufschlussreiche Informationsgewinnung

Außerdem muss Personal anwesend sein, das regelmäßig in der Notfall- und Drogennotfallversorgung geschult wird. Ist grds. jeder Mitarbeiter darin geschult?

- wie gestaltet sich die Umsetzung der regelmäßigen Schulungen
- beschränkt sich die Schulung nur auf die Erstversorgung oder könnte ein Notfall komplett ohne Alarmierung externer Rettungsdienste bewältigt werden

Es wird außerdem eine enge Zusammenarbeit mit der Polizei vorgeschrieben. Wie gestaltet sich diese?

- Einsätze (auf Kooperationsvereinbarung beziehen, dass Einsätze so wenig wie möglich durchgeführt werden)
- Auswirkungen auf das Nutzungsverhalten (Angst vor Kontrollen)
- Anzeigehäufigkeit von Straftaten im Konsumraum
- inwiefern bietet die Überwachung von Straftaten ein Problem in der Vertrauensgewinnung der Klienten?

Gem. der Rechtsverordnung müssen Sie sich vergewissern, dass es sich um Betäubungsmittelabhängige und keine Erstkonsumenten handelt. Wie überprüfen Sie die Angaben der Nutzer?

Themenblock 5: Ausblick und Verbesserungen

Bisher waren genauere Substanzanalysen verboten. Die Landesregierung arbeitet aber an einer Vorschrift, diese einzuführen. Wo sehen Sie die Chancen dieser Substanzanalysen?

- inwiefern würde es die Arbeit vereinfachen oder erschweren?
- hat Stuttgart überhaupt das Problem der neuen psychoaktiven Substanzen?
- Gesundheitsrisiko minimieren, weniger Überdosierungen

Gibt es Ihrer Meinung nach Regelungen oder Vorschriften, die sich in der Praxis schwer umsetzen lassen?

Gibt es Situationen oder Sachverhalte, die bisher noch nicht ausreichend geregelt oder diskutiert wurden?

5. Transkription

V: Also ich würde mich am Anfang nochmal jetzt für die Bereitschaft bedanken für`s Interview, und auch für die vorherigen Dokumente, die geschickt wurden. Die haben mir jetzt auch bei der Bearbeitung oder bei der Erarbeitung von dem Interview und Vorbereitung geholfen. Genau. Über das Ziel von der Bachelorarbeit haben wir ja schon gesprochen. Also, dass ich quasi den Konsumraum aus Stuttgart eigentlich rechtlich beleuchte, aber generell auch so, mehr oder weniger, die erste empirische Erhebung, sozusagen, durchführen möchte. Und da spielt eben das Interview die Rolle, dass ich die Theorie aus der Literatur jetzt auf die Praxis beziehen kann. Genau, wir haben uns ja schon drauf geeinigt, dass das Gespräch audioaufgezeichnet wird, damit ich`s dann später auch gescheit transkribieren kann …

E: Voll.

V: Wenn irgendwelche Fragen zu weit gehen, oder nicht ganz passen, müssen die auch nicht beantwortet werden, und, wenn Nachdenkzeit oder so gebraucht wird, können wir auch eine kurze Pause machen. Genau und in meiner Arbeit, wenn ich das Interview analysiere, würde ich den Namen nicht reinschreiben, aber quasi die Position als Leitung, damit man auch sieht, dass das Interview Sinn ergeben hat, beziehungsweise, dass das einen Wert hat.

E: Ja.

V: Dann können wir ja zum Einstieg mal drüber reden, wie sich der Konsumraum jetzt so im letzten Jahr im Suchthilfesystem in Stuttgart so etabliert hat.

E: Mittlerweile hat der sich gut etabliert. Also wir merken´s natürlich daran, dass immer mehr Leute zu uns kommen und sich auch nach wie vor regelmäßig neue Leute bei uns registrieren. Wir wissen auf jeden Fall, dass unsere Kolleg*innen aus anderen Einrichtungen innerhalb vom Suchthilfeverbund uns kennen und wissen, wer wir sind und wos, ja, wo man uns finden kann. Die Klient*innen aus der Szene wissen auf jeden Fall auch, dass es KOMBO gibt, bleiben natürlich immer noch genug Leute nicht erreicht von uns. Das ist einfach so. Alleine schon wegen dem zweiten Stock, in dem wir hier sind, dass wir nicht barrierefrei sind. Genauso gibt es einfach Leute, die das Angebot nicht nutzen möchten, aber so grundlegend ist es schon gut angekommen mittlerweile, ja.

V: Und so von den Konsumenten, die jetzt schonmal hier waren, kommen die dann auch wieder, oder …

E: Ja.

V: … bleibt`s bei manchen auch beim einmaligen, also…

E: Haben wir natürlich auch, also wir haben sowohl als auch. Leute, die sich irgendwie einmalig bei uns registriert haben. Ich erinnere mich jetzt spontan auch an ein Pärchen,

die aus Köln gekommen sind, die zum Konsumieren dann hierher gekommen sind. Da ist klar, die sehen wir so schnell natürlich nicht mehr wieder. Aber im Großen und Ganzen die meisten Leute kommen irgendwann eigentlich schon wieder.

V: Gehören die aus Köln dann eigentlich auch zur Zielgruppe? Also, beziehungsweise ist die Zielgruppe so definiert, dass man sagt, okay, wir wollen eigentlich gezielt aus Stuttgart Konsumenten erreichen, oder ist es einfach ein generelles Hilfsangebot, wo jeder kommen kann?
E: Ist ein generelles Hilfsangebot, wo jeder kommen kann. Unten im Kontaktcafé sieht es ein bisschen anders aus, da stecken wir schon nochmal unsere Zielgruppe bisschen anders ab und gucken, wo die Leute zum Beispiel auch schon angebunden sind, wenn sie eine Beratung möchten und so. Gerade im Sinne der Einsparungen, die jetzt hier stattfinden mussten, sind natürlich Ressourcen sparen bei uns schon auch ein Thema, aber hier oben, ist schon das Ziel auch, dass Leute natürlich zu uns kommen und deswegen sind wir da erstmal eigentlich offen, woher die Leute kommen, ja.

V: Okay, also ist quasi das Kontaktcafé unten eher getrennt von hier zu sehen oder als Ergänzungsangebot?

E: Gute Frage. Also es ist schon, eine Ergänzung ist es nicht, ich würd`s als zwei Standbeine einfach unserer Einrichtung eigentlich betrachten. Und hier oben richtet sich, oder ist die Zielgruppe einfach Leute, die aktiv konsumieren und unten ist die Zielgruppe Leute, die aktiv, aber auch passiv, oder beziehungsweise konsumiert haben.

V: *Ah*

E: Genau, deswegen beides.

V: Okay.

E: Unten ist es im Kontaktcafé aufhalten, erstmal können sich natürlich alle Leute, die generell dieser Zielgruppe entsprechen. Dann wiederum verschiedene Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, wie Beratung, wie Wäsche waschen zum Beispiel, da würden wir dann schon genauer auch nochmal abstecken, eben, wo sind Leute vielleicht schon angebunden und, genau, wenn die aus Köln kommen, dann würde das wenig Sinn machen, die hier unten natürlich zu beraten.

V: Ja, klar.

E: Deswegen, genau, gucken wir da.

V: Interessant. Und Du hast jetzt auch schon gesagt, quasi, es sind mehr Nutzer jetzt, also es kommen immer mehr Nutzer, gibt`s da irgendeine Begrenzung oder so wie viele kommen dürfen?

E: Verneinendes Mhm. Open end.

V: Also einfach von der Bereitschaft dann?

E: Genau. Unsere Kapazitäten, dadurch, dass wir ja erstmal nur vier Plätze haben, müssen wir natürlich schon manchmal irgendwie managen im Wartebereich und, ja Geduld ist natürlich in dem Moment nicht gerade, irgendwie die größte Stärke, wenn Suchtdruck da ist, aber ansonsten, haben wir da keine Begrenzung.

V: Gut. Und was sind so jetzt die positiven Rückmeldungen, vielleicht auch so der wiederkehrenden Nutzer?

E: Also erstmal heißt es immer, wie nett wir alle sind. Das ist so die Hauptrückmeldung. Die Leute kommen in der Regel gerne zu uns, also die mögen es, dass wir hier einfach respektvoll, auf Augenhöhe mit den Leuten umgehen. Man kann bei uns auch einfach kommen, ohne was zu wollen und darf wieder gehen. Also es ist weder von deren Seite noch von unserer Seite aus was groß wollen, solange es natürlich alles im Rahmen der Hausordnung irgendwie passiert, …

V: Klar.

E: … sind wir da auch unkompliziert. Die Leute sind froh, dass es ein Angebot gibt mittlerweile und, ja, ich glaube die wissen das schon auch zu schätzen. Also das Gefühl habe ich schon. Wir haben wenig Ärger hier oben mit den Leuten, eigentlich. Wenn dann eher unten im Kontaktcafé. Da ist dann Alkohol eher im Spiel, wenn jemand betrunken zum Beispiel reinkommt oder so, weil unten trinken dürfen sie nicht.

V: Ja.

E: Was davor natürlich passiert, kann man jetzt erstmal nicht heben und die meisten Konflikte, die wir eigentlich haben, sind wie gesagt unten im Café, wenn Alkohol im Spiel ist, ja.

V: Und Alkoholisierte dürfen ja hier eigentlich nicht hoch. Beziehungsweise oder den Raum nicht nutzen?

E: Ja, kommt bisschen drauf an. Also man kann jemanden abweisen, wenn die Person zu intoxikiert ist, aber generell arbeiten wir so unter dem Leitsatz, dass jeder Konsumvorgang hier drin besser ist als draußen, das heißt, wenn jetzt jemand hier reinkommt, ultra besoffen und sagt “ich will konsumieren”, dann würden wir schon erstmal checken, was für andere Möglichkeiten gibt`s noch. Also reicht Dir eine Dusche, reicht dir ein Kaffee, dann kriegst du auch einen ausgegeben, oder möchtest du eine Runde schlafen, dann leg dich unten auf die Couch. Oder sagt die Person, “ne, ich werd auf jeden Fall konsumieren. Dann geh ich halt rüber in´s Parkhaus”, dann würden wir halt sagen, ne dann bleib auf jeden Fall hier und mach das bei uns, bevor du`s im Parkhaus machst.

V: Wir haben ja jetzt schon über die grobe Zielgruppe von dem Raum gesprochen. Wie ist denn so, wie kann man die Zielgruppe vielleicht definieren? Also zwecks Nutzungsdauer oder Konsumerfahrung und allem?

E: Also ich würde sagen, da ist irgendwie alles dabei. Wir haben Leute, wir haben einen 70-jährigen Klienten, der hier regelmäßig, der seit 50 Jahren Heroin konsumiert, der das sehr kontrolliert, find ich, konsumiert. Also wir haben aber auch Leute, jetzt, ja tatsächlich vor kurzem eine 16-Jährige. Generell dürfen natürlich den Raum auch nur nutzen, wenn sie schon Erfahrungen haben, also es wäre jetzt nicht hier in Ordnung, wenn jemand sich zum aller ersten Mal intravenös … Wobei, ne würde ich glaub ich sogar streichen, gerade, was ich gesagt habe. Ich glaub auch da wieder, wenn jemand wirklich die Erfahrung natürlich hat mit den Substanzen, Erst- / Gelegenheitskonsumierende müssen wir ausschließen, das ist einfach so. Das ist natürlich auch nicht unser Ziel, dass Leute irgendwie zu uns kommen in dem Sinn. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich, ich müsste es mir im Einzelfall anschauen, aber ich würde tatsächlich niemanden pauschal ablehnen, der sich jetzt das erste Mal hier vielleicht spritzen möchte. Ich glaube, ich würde schon versuchen, irgendwie auch da wieder Alternativen, oder "warum rauchst du`s vielleicht nicht?" oder "möchtest du`s nicht ziehen?" oder so. Aber das Ziel wäre natürlich schon eigentlich, dass niemand im besten Fall hier das erste Mal mit der Nadel konsumiert.

V: Das ist ja auch zum Beispiel in der Verordnung oder so ein riesen Thema, dass es sich gezielt gegen Abhängige richtet oder auch, dass Erstkonsumenten ausgeschlossen werden. Wie vergewissert man sich da, dass das wirklich ein Abhängiger ist, oder der wirklich nicht zum ersten Mal konsumiert? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es oft vielleicht auch gar nicht ansehbar ist.

E: Voll. Also ansehen tut man`s den Leuten nicht immer, das stimmt auf jeden Fall. Durch Fragen stellen. Also wir haben so einen Erstaufnahmebogen, so einen Anamnesebogen, wo wir so ein paar Basics abfragen, zum Beispiel auch "was konsumierst du; was ist deine Hauptsubstanz; wie lange konsumierst du das?". Und da merkt man das raus, ob dich jemand anlügt oder auch einfach nicht und, also, bisher haben wir noch nie jemanden abweisen müssen, weil wir das Gefühl hatten, die Person hat noch nie richtig konsumiert. Also ja, ich würde wirklich behaupten, dass sich bisher noch keiner hierher verirrt hat, der nicht eigentlich auch den Bedarf für den Konsumraum hat.

V: Gut. Die Nutzer, die jetzt hier herkommen, beziehungsweise sich registrieren. Sind das tatsächlich auch Nutzer, die noch gar nichts mit dem ganzen Hilfesystem hier in Stuttgart zu tun haben, oder ist es so, quasi, wie Du schon anfangs gesagt hast, mit dem ganzen Netzwerk, dass man von der einen Hilfeeinrichtung sagt "hier probier das mal aus" oder …?

E: Beides. Also es gibt Leute, die einfach, ich sag mal ein Stück weit durch das Hilfesystem auch gefallen sind, die irgendwie seit vielen Jahrzehnten meinetwegen auch irgendwie Erfahrung haben, von der Wohnungslosenhilfe, über die Drogenhilfe. Da ist ja dann irgendwie auch ganz viel andere Unterstützung schon mit drin gewesen, mit Schuldnerberatung oder bestimmt auch Bewährungshilfe zum Teil. Oh, sorry, was war die Frage, jetzt habe ich den Faden gerade verloren.

V: Ob man hier auch Leute erreicht, die …

E: Ah, Neuzugänge, gell? Deswegen ich würde eigentlich sagen, die meisten haben schon Erfahrungen irgendwie, aber haben so ein bisschen das vielleicht auch aufgegeben, würd ich sagen, oder so ein bisschen das Vertrauen in manche Institutionen verloren. Und dadurch, dass das halt hier so niedrigschwellig ist, kommen die wieder hierher. Wir wollen ja, also da sind wir wieder, wir wollen ja eigentlich nicht so viel von den Leuten. Komm hierher, konsumier und geh einfach wieder, wenn dir danach ist. Und ich glaube diese Niedrigschwelligkeit kann aber auch Türen öffnen, wiederum für Leute, die einfach schon lange nicht mehr ans System angebunden waren. Und wir haben aber auch Leute, die noch nie im System waren, das schon auch. Also wir fragen das auch ab auf unserem Anamnesebogen, welche Erfahrungen gibt`s da schon. Es gibt auch, wir hatten vor kurzem zwei junge Kumpels irgendwie hier, die halt schon konsumiert haben und trotzdem noch beide daheim gewohnt haben. Also, volljährig, ja, waren volljährig, wohnen daheim und hatten einfach noch nie Berührungspunkte, frag mich nicht genau, wie die an den Stoff das erste Mal gekommen sind, aber ja.

V: Ja. Wie ist da so der Anteil vielleicht? Also, wenn man das irgendwie definieren kann?

E: Vom Alter?

V: Oder beziehungsweise, wie viel, wenn man jetzt sagt, von zehn Nutzern, wie viele sind da schon angegliedert gewesen oder haben schon Erfahrungen?

E: Boah. Zahlen kann ich Dir wirklich gar nicht nennen, da müsste ich dann die ganzen Bögen irgendwie durchgucken, aber ich würde behaupten, dass die Mehrheit eigentlich schon Kontakte hatte irgendwie ins Suchthilfesystem.

V: Kannst Du Dir da vielleicht irgendwie was vorstellen, wie man vielleicht mehr Konsumenten, die bis jetzt durch das Raster vom Suchthilfesystem gefallen sind, erreichen kann? Weil das ist ja schon auch eine Zielsetzung auch vom Konsumraum, so eine Brücke, sozusagen darzustellen.

E: Voll. Ich weiß gar nicht, ob es da so die Musterlösung gibt, ist natürlich immer sehr individuell, wer was braucht irgendwo, aber ich weiß auch nicht, ob für alle die Niedrigschwelligkeit wie wir sie hier haben auch die Lösung irgendwie ist. Also genauso gibt`s Leute, die irgendwie besser mit Regeln und Vorgaben klarkommen, als jetzt hier, wo`s irgendwie wenig Rahmen oder Begrenzung gibt irgendwie. Ne, ich kann`s dir tatsächlich grad nicht sagen.

V: Okay. Ja, und kann man vielleicht irgendwie so eine Aussage drüber treffen, was für Konsumentengruppen das Angebot besonders häufig vielleicht nutzen oder welche jetzt vielleicht noch gar nicht da sind? Also so typische Merkmale vielleicht

E: Also Crack konsumieren natürlich ultra viele Leute hier, aber ich, also, ich glaub das wird mittlerweile irgendwie überall viel konsumiert, deswegen würde ich das gar nicht

nur auf den Konsumraum grade schließen. Auch da kann ich Dir, kann ich Dir das gar nicht so genau beantworten. Es gibt natürlich Leute, die kommen hierher, aber wohnen zum Beispiel in einem Wohnheim und es kommen Leute hierher, die auf der Straße leben. Und ich glaube jeder kommt dann vielleicht auch aus unterschiedlichen Gründen zu uns. Manche kommen wegen Mittagessen, manche kommen morgens, weil es hier irgendwie schön ruhig ist, manche kommen im Winter, weil sie sich aufwärmen wollen. Also manche kommen wirklich nur für den Konsumraum, manche nur für Beratung, andere waschen nur ihre Wäsche. Ich glaube, da kommt es so bisschen auch drauf an, was die Leute hierher treibt letzenenedes.

V: Das wäre tatsächlich auch noch eine Folgefrage gewesen, also was so die Hauptgründe vielleicht sind für jemanden herzukommen. Also zum Beispiel eine Mehrheit, die vielleicht einfach nur sagt, "ich bin hier nur zum Konsumieren und dann mach ich wieder mein eigenes Ding", oder diese Folgeberatung oder so, ob die vielleicht auch ein Grund ist, für die meisten oder für viele?

E: Ich denke, ich bin auch mal gespannt auf den Winter, weil die Erfahrung haben wir ja einfach bisher natürlich noch nicht so. Ich denke da werden nochmal mehr Leute kommen in den Konsumraum und ich denke da wird halt der Grund sein, die Kälte, dass die Venen gut zu sehen sind, Dunkelheit, das. Ich glaube es gibt aber auch Leute, also der Großteil unserer Besucher*innen hält sich nur im Kontaktcafé auf und gar nicht hier oben im Konsumraum. Also genau, mehr Leute nutzen unten eigentlich die Räumlichkeiten. Mittagessen ist glaube ich ein ganz großer Punkt, warum die Leute hier zu uns herkommen, weil wir jeden Tag frisch kochen. Vier Tage die Woche, sonst gibt es immer Sandwiches, ich glaub, also günstig Geld, wenn jemand kein Geld hat, dann kriegt er auch so irgendwie ein Essen von uns ausgegeben. Ab 14:30 Uhr ist es eh kostenlos. Und ich glaube das ist schon was die Leute hierher zieht.

V: Ja.

E: Und so ein bisschen unter Gleichgesinnten zu sein auch. Und natürlich ist unser Ziel auch einen Schutzraum hier zu geben für die Leute, die einfach sonst oft keinen finden, ja, wo sie sich aufhalten können, in Ruhe, ja, ungestört sein können, genau.

V: Aber sind das dann hier auch großteilig Leute, die sich dann, ohne den Konsumraum jetzt, in der, also offenen Szene, zum Beispiel, aufhalten würden?

E: Auch. Wir haben auch Leute, die wollen einfach nicht hier oben sich registrieren. Das ist irgendwie einfach so. Und die konsumieren dann lieber vor der Haustür, kriegen dann ein Hausverbot dafür, anstatt, dass sie sich einfach hier kurz hochbemühen und sich registrieren. Ich weiß nicht, woran es da scheitert. Also, es gibt auch Leute, die chillen unten, konsumieren irgendwo ums Eck von mir aus auch und kommen aber nicht hier hoch.

V: Also ist dieses Registrieren schon ein sehr großes Hemmnis?

E: Ich würde schon sagen. Es ist eine Hürde auf jeden Fall, weil natürlich auch gerade, ja, die Leute, wie ich vorhin meinte, die hierher kommen haben auch einfach oft schon Erfahrungen und sind irgendwie durchs Hilfesystem und auch Vertrauen ist natürlich ein riesen riesen Thema und ich glaube, dass viele Leute das auch gar nicht erstmal glauben können, dass man einem Ort wirklich Illegales legal konsumieren kann und dann die Daten, die ich da abgeb, wirklich auch da bleiben. Also ich glaube, das ist viel auf einmal.

V: Ja.

E: Und das musste sich rumsprechen. Das haben wir schon gemerkt, dass das sich verändert hat und dass wir, wenig, viel weniger Diskussion auf jeden Fall haben bei der Registrierung als am Anfang, aber die Erfahrungen hat es einfach gebraucht und das hat Monate gedauert, wenn nicht sogar fast ein Jahr, bis jetzt, also, dazu nicht mehr diskutieren müssen. Aber nichts desto trotz gibt es eben Leute, die es einfach nicht haben so, dann brauchen wir über gar nichts diskutieren. Wenn mir jemand gar nichts zeigen kann, kann er sich halt nicht registrieren.

V: Ja. Und da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, wär`s dann vielleicht denkbar, so ein Konzept zu entwickeln, dass man sagt, okay, man gibt nicht den richtigen Namen, sondern quasi irgendeine Zuordnung oder einen Decknamen, damit vielleicht nicht unbedingt mit dem richtigen Namen, also, die nicht mit dem richtigen Namen bekannt sind, sondern sozusagen sich noch selber irgendwie schützen können?
E: Voll. Auf jeden Fall. Also das würde auf jeden Fall eine Hemmschwelle abbauen, auch, ja, wie gesagt das mit dem ausweisähnlichen Dokument. Wir müssen Leute wegschicken, wenn die uns nichts zeigen und das würde man natürlich auch vermeiden, weil das ist natürlich nicht unser Ziel, Leute wegzuschicken hier. Und dazu kommt, es gibt ja hier einfach Leute, die einen Spitznamen haben, oder einen Szenenamen und mit denen sprechen wir die hier genauso an, die heißen aber im echten Leben komplett anders, also das kann man sich gar nicht herleiten. Da muss ich trotzdem wieder nachschauen im System, ist die Person unter ihrem Klarnamen angelegt, anstatt, ja.

V: Ja. Dann bei den Nutzern, die jetzt immer wieder herkommen, gibt`s da irgendwas, was man schon so an Veränderungen merkt? Also im Konsumverhalten, Gesundheitszustand vielleicht, irgendwie in die Richtung?

E: Leider ja. Also in beide Richtungen, tatsächlich würde ich sagen. Wir haben Leute, die relativ stabil geblieben sind über`s Jahr und Beratung mittlerweile annehmen und das ganze Angebot, was für uns natürlich ein mega cooler Erfolg ist, weil es, ja, unser Ziel irgendwo ist. Wir haben leider aber schon auch Leute, die, muss man sagen, bei denen konntest Du über ein Jahr lang zuschauen, wie sich der Zustand halt immer weiter verschlechtert hat, die halt einfach so tief in die Szene reingerutscht sind. Das ist halt natürlich ein Nachteil der Einrichtung, dass man einfach Kontakte knüpft und die können gut sein, die können aber auch in die falsche Richtung gehen. Und mit falsche Richtung mein ich jetzt einfach jemand, der Dir Drogen verkauft, oder Dich irgendwie mehr connected,

der dich zu neuen Drogen verführt, der dir Drogen schenkt, wenn du gerade frisch aus Therapie kommst, kommt leider auch vor, um die Leute wieder drauf zu bringen, also das ist richtig assi. Aber ja, dementsprechend kannst Du hier natürlich schon auch deine Quellen irgendwie finden, auch wenn wir Dealen absolut natürlich gar nicht zulassen hier im Haus, aber das bringt ja das ganze Viertel hier irgendwo mit sich im Endeffekt. Und von daher haben wir schon auch Leute, wo wir wirklich zugucken konnten, wie sich`s körperlich irgendwie verschlechtert, psychischer Zustand verschlechtert sich, weil der Konsum einfach immer krasser wurde und gerade Crack eben immer mehr wird und das die Leute schon auch einfach abbaut, ja.

V: Also das hört sich jetzt bisschen so an, als würde zwar das Ziel auch sein, quasi die Szene von der Öffentlichkeit vielleicht eher in diesen Bereich zu lenken, aber das gerade auch sowas dann Nachteile für recht stabile Konsumenten sein kann.

E: Ja. Also Thema Dealen ist auf jeden Fall was, was bei uns direkt mit einem Hausverbot irgendwie verbunden ist, wenn wir das mitbekommen, wenn wir auch nur Absprachen zum Beispiel mitbekommen, fliegen die Leute raus, wenn jemand hier hoch in den Konsumraum kommt, ohne, dass jemand seine eigene Substanz dabei hat, sondern irgendwie checken will, wer hier ist, fliegt auch für den Tag raus. Also wir sind schon natürlich streng in der Hinsicht, nichts desto trotz ist mir schon auch klar, dass sich das nicht zu 100% vermeiden lässt. Wir haben auch einen Sicherheitsdienst, der die Augen und Ohren offen hat, aber wir sitzen nicht bei jedem Gespräch, was da am Tisch natürlich passiert, irgendwie dabei und von daher, in irgendeiner Form wird das trotzdem stattfinden, was wir nicht mitbekommen. Und, wie war da Deine Frage nochmal, jetzt hab ich`s wieder vergessen, sorry.

V: Quasi, dass diese Szenenbildung …

E: Ah, dass die hier reinkommt. Ja, deswegen ein Stück weit schon, ein Stück weit schon. Und ich denk mir halt, da sind wir halt irgendwie beim Punkt Microdealing, aber Dealen ist halt Teil des Konsums. Und natürlich ist das verboten und da halten wir uns dran, müssen wir auch und ich will es wie gesagt hier auch nicht, nichtsdestotrotz wissen wir alle, dass es stattfinden muss auch, um den Konsum hier oben machen zu können.

V: Ja.

E: Ja, es ist schwierig zu sagen, weil draußen ist es nicht in meinem Blickfeld, nicht in meiner Verantwortung und ich kann`s irgendwie laufen lassen. Draußen werden sie aber natürlich, wenn sie dann erwischt werden, gibt`s dann halt, also grad von der Polizei irgendwie, sind natürlich die Strafen härter, wie wenn es jetzt hier ein Hausverbot gibt.

V: Ja.

E: Beides scheiße. Beides scheiße.

V: Wie ist das, wenn jetzt hier jemand beim Dealen erwischt wird? Weil das wäre ja theoretisch, also es ist ja eine Straftat dann auch. Wird die dann auch zur Anzeige gebracht?

E: Erstmal nicht. Also wir sind dann verpflichtet, anzuzeigen, wenn dem Personal nicht Folge geleistet wurde. Also, wenn sich gar nicht dran gehalten wird, das immer wieder vorkommt, so. Dann schon, aber wenn ich jemanden erwischen würde, dann fliegt die Person hier einfach raus, ja.

V: Und wie oft kommt das dann vor, dass die sich dann dem Widersetzen?

E: Nicht so oft.

V: Okay.

E: Nicht so oft. Also wir haben einen Sicherheitsdienst hier. Wir haben Leute, die versuchen das dann immer mal wieder irgendwie doch reinzukommen, aber in der Regel klappt das, wenn der Sicherheitsdienst sagt, "Hey, du hast Hausverbot", "ja okay, alles klar". Also so ein bisschen getestet was das dann eher, ja.

V: Gab´s dann schonmal so Vorfälle, dass jemand hier angezeigt werden musste quasi? Oder dass Polizeieinsätze hier drinne in der Einrichtung …

E: Hatten wir tatsächlich. Waren aber unabhängig von Drogenhandel. Also die waren dann eher, wir hatten einen Gewaltvorfall Anfang August. Ist ein Klient ultra ausgerastet, genau. Da wurde Polizei gerufen, die war dann auch drin. Wir hatten einmal die Situation, dass ein Klient sich mit unserem Sicherheitsdienst geprügelt hat, tatsächlich. Also das ist so eskaliert, dass es handgreiflich wurde. Und, was hatten wir noch? Boah, bestimmt noch andere Sachen, ja ja. Wir versuchen Thema Polizei immer draußen zu lassen, aber sind Situationen, also wenn es sein muss, dann bin ich Gott dankbar, dass die reinkommen und dass die uns hier irgendwie unterstützen, ja.

V: Wie funktioniert, also wie läuft so die Zusammenarbeit mit der Polizei?

E: Eigentlich gut, würde ich sagen. Wir haben im Steuerungskremium, was wir bilden mussten auch, also mit Amt für öffentliche Ordnung, Stadt ist drin, genau, das weißt du ja alles, wer da, wer da drin ist. Und das ist wirklich ein guter Austausch. Was uns halt aufgefallen ist, ist irgendwie so, das ist gerade aber wieder ruhiger geworden, dass es zwischendurch auch wieder ein paar Monate gab, wo wirklich die Polizeipräsenz direkt vor unserer Haustür echt hoch war und das ist immer scheiße für uns. Das schreckt die Leute ab, irgendwie, da haben wir keinen Bock drauf, da haben die keinen Bock drauf. Wir haben schon auch die Erfahrung gemacht, dass wir hingehen ans Polizeiauto, irgendwie kurz erklären, wer wir sind, dass es mega nett wäre, wenn die Leute hier wegfahren würden und das machen die eigentlich alle auch. Also in der Hinsicht wirklich gut. Sind nicht alle immer nett, aber ja im Endeffekt können wir`s natürlich auch nicht, wir können

nichts dagegen tun oder sagen, wenn die vorne an der Kirche halt kontrollieren, dann ist es nicht mehr unser Ding.

V: Ja.

E: Ja. Und theoretisch dürfen die`s auch direkt vor der Tür, aber das ist anders abgesprochen, das, ja ja. Aber Kirche gehört halt nicht mehr so zu uns. Da findet`s manchmal statt.

V: Ja. Also ihr müsst ja auch quasi überwachen und die dann ja wegschicken, wie Du schon gesagt hast, wenn die hier dealen oder Straftaten begehen …

E: Genau.

V: … ist das irgendwie vielleicht auch ein Hemmnis vielleicht von der Arbeit, beziehungsweise verschlechtert das vielleicht auch das Verhältnis oder die Vertrauensbasis zu den Klienten in irgendeiner Hinsicht?

E: Ich glaube manche schon, weil manche das wirklich irgendwie von eins bis zwei dann nur denken und denken "hä, aber das war doch gar nicht so schlimm, ist ja nur ein bisschen Koks" wie auch immer. Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass das anderen signalisiert, dass das hier wirklich ein Schutzraum sein soll. Also ich glaube die Person, die das dann eher mitbekommen, sich im Café aufhalten, die relativ stabil vor allem sind, ich glaube, dann verkack ich`s mir lieber mit einer Person im Zweifel, aber habe das Gefühl, fünf andere da auch ein Stück weit geschützt zu haben vor. Weil dann natürlich wieder Triggerpunkte aufkommen können, verlockt werden können, ja, was wir vorhin schon hatten. Und das vermeidet sich natürlich dadurch einfach.

V: Ja.

E: Ja.

V: Gibts vielleicht auch irgendwie, so, inwiefern wirkt sich vielleicht auch der Raum hier auf die generelle Drogenszene in Stuttgart aus?

E: Gute Frage. Kann ich dir auch nicht so genau sagen. Also, es gibt ja so mehrere Szenen hier in Stuttgart, aber wie das genau sich auswirkt …

V: Okay.

E: … keine Ahnung. Ich mein im besten Fall natürlich durch weniger Hepatitis, weniger HIV das ganze, aber das ist nichts, was irgendwie jetzt erstmal offensichtlich für uns natürlich ist. Oder weniger Wunden, die durch falsches Konsumieren entstehen und sowas. Aber kann ich nicht genau benennen.

V: Ja. Gut, die Auswirkungen könnten ja auch zum Beispiel sein, dass die generellen Drogenumschlagplätze zum Beispiel in Stuttgart freier werden, oder nicht mehr so eine öffentliche Belastung …

E: Ja, ja.

V: Gibt`s da schon irgendwie, vielleicht Erfahrungen?

E: Nicht dass ich wüsste.

V: Okay. Ich hab im Bericht von, also von den Drogenhilfen, also der Jahresbericht 2025 gelesen, dass die Drogentoten wieder sehr stark angestiegen sind. Wie erklärst Du Dir vielleicht diesen Anstieg?

E: Also ich denke schon, dass ein Ding synthetische Opioide sind. Man sagt zwar, klar durch Abwasseruntersuchungen und so sieht man schon auch, dass das jetzt nicht so da ist, wie man`s vielleicht befürchtet hat. Ich glaube trotzdem, dass es irgendwo da ist, also hab vorhin kurz erzählt, dass wir hier einen schweren Notfall im Konsumraum hier hatten.

V: Ja.

E: Da sind wir uns relativ sicher, dass es synthetische Opioide mit im Spiel waren. Ich denke das ist ein Ding, auf jeden Fall. Gleichzeitig ist ja auch Koks grade irgendwie so viel da wie noch nie.

V: Ja.

E: Die Reinheit verändert sich, ich glaube das ist auch immer was, du weißt gar nicht genau, was hast du jetzt bekommen, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass generell einfach immer mehr Leute einfach konsumieren im Vergleich zu früher, dass die Zahlen generell einfach zunehmen. Ja, ich glaube damit hängt`s schon auch ein Stück weit zusammen, ja.

V: Mal auf den Notfall jetzt bezogen. Da, ihr guckt ja quasi, also ihr habt ja eine Sichtkontrolle davor.

E: Ja.

V: Auf was achtet ihr da so?

E: Also eigentlich nicht viel, weil *lachen* okay, das hört sich jetzt falsch an, vielleicht nicht ganz zitieren wörtlich mit nicht viel, aber *lachen*. Im Endeffekt, die Leute zeigen uns irgendein Pulver. Ob es jetzt das ist oder das, kann ich überhaupt nicht beurteilen.

V: Ja.

E: So, aber dadurch, dass man natürlich alles hier konsumieren darf, gehe ich einfach mal davon aus, dass es stimmt, was man mir sagt. Worauf wir schon achten ist halt, also wie Felix vorhin meinte, dass wirklich jeder sein Eigenes auch mit hier reinbringt, die Menge ist natürlich ein Ding, aber auch da, jeder hat irgendwie einen unterschiedlichen Bedarf von dem, wie viel er konsumiert, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber wenn jetzt jemand mit einem Kilobeutel hier reinkommt, das geht natürlich halt nicht so.

V: Ja.

E: Also ist schon für den unmittelbaren Verbrauch gedacht. Und es ist aber schon auch irgendwie für uns ganz gut, wenn jetzt ein Notfall eben eintritt, wir rufen den Rettungsdienst, die Person selber ist nicht ansprechbar, dass wir auch sagen können, die hat wirklich das und das konsumiert. Das wir es gesehen haben einfach, ja.

V: Ja. Da arbeitet ja zum Beispiel die Landesregierung jetzt gerade schon an einer Verordnung für die Substanzanalysen, die sind ja bis jetzt noch verboten. Würde das vielleicht, also inwiefern sind da vielleicht die Chancen, das nochmal zu verbessern?

E: Boah, das wäre an sich mega natürlich. Also da bin ich aber ehrlicherweise noch nicht genug im Thema drin, weil in meiner Vorstellung, also vielleicht weißt du es besser, deswegen korrigier mich, aber, wenn ich jetzt Drug-Checking mach und das dauert ja eine gewisse Zeit, bis ich die Auswertung hab. Das würde in dem Moment im Konsumraum nicht funktionieren. Also die Leute kommen und die wollen jetzt konsumieren, die warten keine halbe Stunde, bis das Ergebnis da ist …

V: Ja.

E: … oder wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert. Das wäre natürlich trotz allem sinnvoll, um irgendwie zu checken, hey, gestern war halt das und das drinnen, also schon, wenn es irgendwelche Folgetermine als Konsequenz hat im positiven jetzt gemeint. Aber wenn jetzt jemand einmal kommt, konsumiert, ich glaube jetzt nicht, dass die Person sich das groß angucken möchte, wenn das eine halbe Stunde später, oder noch länger vielleicht sogar, das Ergebnis erst kommt. Und natürlich ist ein Ding, dass ich ja etwas wegnehmen muss von der Substanz.

V: Ja.

E: Und das weiß ich nicht, inwieweit die Leute das, vielleicht Anfang des Monats eher zulassen, als Ende des Monats. Kann ich mir noch nicht so genau vorstellen. Vielleicht gibt es aber auch irgendwelche Geräte, also ich weiß, dass es so einen, das ist kein richtiges Drug-Checking Gerät in dem Sinne, aber das sieht ein bisschen so aus wie so eine Taschenlampe von Nirlab, heißt die Marke. Und da kann man das quasi so über die Substanz wie einscannen, mit so Infrarot funktioniert das glaub ich. Und das wäre vom Prinzip mega cool, da nimmst du nichts weg, so, da kannst du irgendwie sehen, aber die sind nicht genau genug. Da wird Fentanyl beispielsweise erst ab so und so viel Prozenten angezeigt, da bist du schon halb tot, wenn du das konsumiert hast, so, ja.

V: Gibt`s da vielleicht bei den Notfällen dann im Nachhinein vielleicht von Krankenhausberichten oder so so Analysen, welche Substanz dafür ursächlich war vielleicht, oder ob es eine Dosierung ist oder so?
E: Kann ich mir schon vorstellen, dass es so einen toxikologischen Bericht gibt, aber die kriegen wir nicht.

V: Okay.

E: Also wenn dann kriegen wir den über die Klient*innen ausgehändigt und hatten wir noch nie hier.

V: Okay. Aber das wäre ja sonst dann interessant, dann könnte man so eine…

E: Das stimmt.

V: … Abhängigkeit vielleicht…

E: Drug-Checking aus dem anderen Ding raus, ja.

V: Gut bei dem Drug-Checking ist es ja so, dass, also da gibt es so Modellvorhaben mit so Schnelltests und so, wo man dann auch recht schnell das Ergebnis hat …

E: Ja.

V: … und das dann wie bei so einem Coronatest anzeigt, …

E: Cool.

V: … was so drinne ist. Das würde ja dann funktionieren eigentlich.

E: Ja, ja. Wie lange gehen die Tests, weißt Du das?

V: Die Zeit weiß ich nicht genau, aber …

E: Paar Minuten dann irgendwie.

V: Ja, wahrscheinlich, ja.

E: Das könnte ich mir eher vorstellen, ja. Deswegen ich meinte, ich weiß nicht genau, wie lange die einzelnen, ja, ja.

V: Aber ist da, fehlt`s an so Angeboten generell oder ist da jetzt generell wenig Bedarf?

E: Ich würde sagen, bisher ja, einfach dadurch, dass wir neu sind und tausend Dinge hier irgendwie aufgebaut haben, verändert und Routinen und Alltag gefunden haben, hat`s bisher noch nicht gefehlt in dem, aber ich merk schon auch, dass jetzt eben so eine Routine reinkommt und wir irgendwie nach und nach wieder Kapazität hätten für so ein neues Projekt. Ich glaube wir müsstens uns genau anschauen.

V: Ja.

E: Wir müsstens uns nochmal anschauen, was bedeutet das, wie sieht es in der Umsetzung aus, kriegen wir das gestemmt auch personell, irgendwie dieses Angebot auch noch durchzuführen, wie viel Ressourcen bindet das, aber grundlegend wäre das schon was, was auf jeden Fall mega cool wäre irgendwie umsetzen zu können, ja.

V: Ja.

E: Also, es kann nur helfen.

V: Ja, ja. Du hast gesagt, der Notfall jetzt mit der 16-Jährigen war wegen psycho… wegen diesen neuen …

E: Synthetischen …

V: Genau.

E: Vermuten wir, ja.

V: Ja. Wie stellt ihr da ein Problem generell in Stuttgart fest?

E: Noch gar kein Problem in dem Sinne tatsächlich. Also wir haben schon immer mal wieder nachgefragt bei den Leuten, was die so wahrnehmen, was irgendwie in der Szene gerade so rumgeht und so und da hieß es mal von einem Klienten jetzt, dass es vor paar Jahren mal mehr war, als es jetzt gerade ist wohl. Wenig Thema hier, wenig …

V: Okay.

E: … bis gar nicht eigentlich. Es gibt ein paar Leute, die das mal probiert haben, aber ja.

V: Okay. Und so die Reinheit von den Stoffen oder irgendwie so, dass sich das …

E: Kann ich auch nicht sagen.

V: Okay.

E: Also glaub die Leute selber auch zum Teil nicht.

V: Dann nochmal zu den Auswirkungen jetzt vielleicht, gibt es Rückmeldungen hier aus dem Umfeld oder aus der Nachbarschaft, sag ich mal, wie es sich so auswirkt?

E: Eigentlich nicht. Also, was gut ist natürlich, weil wir schon einfach Sorge hatten. Hier ist ja direkt ums Eck die Schule, die Jakobsschule …

V: Ja, ja.

E: … und da war, bevor wir eröffnet haben, natürlich schon eine Skepsis da, die ich komplett nachvollziehen kann. Hier sind Kinder irgendwie auf dem Schulweg, hier war vor vielen Jahren auch Thema, dass Spritzen rumliegen und so. Da hat man ja dann aber extra eine Stelle geschaffen und jetzt haben wir jemanden, der jeden Tag Spritzen aufsammelt, genau. Und wir haben dann die Schule einfach eingeladen. Wir haben gesagt, "Hey, kommt vorbei, wir tauschen uns aus, wir nehmen eure Sorgen einfach auch ernst" und dann hat man aber auch gesagt, wir hören einfach voneinander. Die melden sich, wenn es irgendwelche Themen gibt und ich habe nie mehr was von denen gehört. Und von daher, Parkhaus ist natürlich auch immer ein Thema, weil da einfach viele Leute, bis es uns gab, auch zum Konsumieren rübergegangen sind und es leider immer noch Leute gibt, die rübergehen, weil sie zum Beispiel abgewiesen werden irgendwie. Die sehe ich jeden Morgen. Ich parke nämlich auch drüben mein Fahrrad, aber die haben sich noch nie irgendwie beschwert. Und wir haben am Anfang halt schon irgendwie, ich habe mich

kurz vorgestellt, gesagt, wer ich bin und so, nichts. Dann gibt`s ja das Kiosk da unten, das "Utopia Kiosk", mit denen sind wir ultra cool, also da durften wir auch unser Sommerfest feiern, mit denen ist es eher im Gegenteil, dass die uns voll unterstützen und so. Genau, von daher eher positive Erfahrungen als schlechte auf jeden Fall, ja.

V: Gut. Du hast ja jetzt auch schon die Jakobsschule angesprochen, dass da dieser riesen, also diese Spritzenfunde in der Vergangenheit waren. Macht dann nicht vielleicht der Standort hier vom Standort her mehr Sinn? Sag ich mal, diese Belastung einzudämmen, weil eigentlich ist ja die Ossietzkystraße geplant. Da weiß ich jetzt tatsächlich nicht ganz, wie es da mit der Belastung ist, ich habe halt nur von hier gelesen, …

E: Ja, ja.

V: … aber ob nicht vielleicht hier vom Standort her besser wäre?

E: Hm. Ich weiß nicht, ob ich besser auch sagen würde. Also auch aus dem Grund, weil es gab schon immer zum Beispiel unten vor der Tür, als es noch "High Noon" war und nicht Konsumraum, so einen Spritzenabwurf. Also die Möglichkeiten hatten die Leute trotz allem schon immer. Es gab ja auch den Spritzenschalter, wo Du eins zu eins tauschen konntest, 365 Tage im Jahr. Und dadurch, dass es das halt irgendwie schon immer gab und trotzdem damals schon viele Spritzen gefunden wurden, würde ich gar nicht sagen, ob es jetzt mehr oder weniger wurden. Also ich glaube, hier ist auf jeden Fall Szene mit dem Rotlichtviertel und so, ich glaube aber, Hauptbahnhof ist auf jeden Fall auch Szene und im besten Fall nehmen wir natürlich aber auch eine Hand voll Leute da mit rüber. Ich glaube es schenkt sich nichts letztenendes.

V: Okay.

E: Ich glaube dadurch, dass es größer ist am Hauptbahnhof können wir dadurch trotzdem mehr Leute noch erreichen. Und barrierefrei sind wir dann eben auch. Und Hauptbahnhof ist ja schon auch eine Szene um den Weg und von daher würde ich eigentlich eher denken, dass Hauptbahnhof sogar besser ist in der Gesamtsumme.

V: Okay.

E: Ja.

V: Ich habe gelesen, dass hierfür eigentlich nur eine begrenzte Genehmigung ist. An was liegt das?

E: Dass wir nicht barrierfrei sind.

V: Ah, ja.

E: Also wir erfüllen nicht die Voraussetzung von der Landesverordnung, ja. Und deswegen haben wir nur eine Ausnahmegenehmigung.

V: Ja, okay. Der Konsumraum hat ja das Ziel, sag ich mal, also ordnungspolitisch sag ich mal, die Leute an das Suchthilfesystem anzugliedern oder vielleicht den Ausstieg zu motivieren. Inwiefern wird der auch so von den Klienten gesehen? Also als Ausstiegshilfe?

E: Wenig. Also generell arbeiten wir hier akzeptanzorientiert und nicht mehr wie früher, wie man`s halt oft gemacht hat, abstinenzorientiert. Und von daher sind wir auch, wir können Angebote machen, aber da sind wir wieder bei diesem Punkt Niedrigschwelligkeit, wenn jemand nicht will, dann will er nicht und dann ist es auch vollkommen okay. Also jeder ist irgendwie, darf selbstbestimmt leben, darf selbstbestimmt konsumieren und wenn es in der Konsequenz bedeutet, dass Du im schlimmsten Fall vielleicht sogar daran stirbst, dann ist es auch deine freie Entscheidung irgendwie. Also muss man manchmal auch zugucken tatsächlich, grad wo ich meinte vorhin die Leute, wo man jetzt so ein Jahr irgendwie beobachten kann …

V: Ja.

E: … ist schon was, wo man irgendwie lernen muss, auch mit umzugehen. Wir können nur die Angebote machen, ja.

V: Ja.

E: Die Leute sind selber verantwortlich.

V: Wie werden die Angebote so angenommen?

E: An sich gut. Also für mich ist schon irgendwie so ein kleines Ziel erreicht, wenn ich merk, dass jemand ein zweites Mal zu uns kommt. Dann denke ich mir, "cool, okay, war wohl nett für Dich hier beim ersten Mal" oder "hat gepasst", wie auch immer. Und dann, ich mein im besten Fall bekommst du die Leute in Beratung. Das ist halt irgendwie ein Ziel. Und dann kannst du immer noch gucken, ja, was für Möglichkeiten gibt`s. Und selbst wenn sich jemand ja auch entscheiden würde, "ich will nicht abstinent leben, ich will weiterhin konsumieren", haben wir ja Möglichkeiten, um zu sagen "okay, aber gucken wir trotzdem deinen Konsum an, du darfst deine eigenen Ziele festlegen und wenn dein Ziel ist, weiterhin konsumieren, dann ist, dann darf das auch dein Ziel irgendwie sein".

V: Ja. Wenn sich jetzt jemand dazu entscheidet, vielleicht weitere Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen, wie, wie funktioniert da die Weiterleitung?

E: Machen wir auch viel tatsächlich.

V: Ja.

E: Also grad so Therapievermittlungen gucken wir, Substitution ist natürlich oft ein großes Ding, sowohl bei uns jetzt im Haus, aber dadurch, dass wir nur Methadon haben, da haben jetzt nicht alle Bock drauf, natürlich auch Substitutionspraxen irgendwo anders versuchen wir zu vermitteln. Generell ist soziale Arbeit ja auch Casemanagement. Also

wir gucken auch Schuldnerberatung, Wohnungslosenhilfe ist ein riesen Ding irgendwie. Dann haben wir ja auch, wenn wir eine eigene Suchtberatungsstelle sind, gibt`s schon auch Leute, die wir zum Beispiel an Release U21 eher vermitteln würden, um zu gucken, hey, son bisschen die Leute ausm Haus zu bekommen und woanders anzubinden, wo`s passender für sie ist. Genau.

V: Gibt´s da irgendwie Probleme in der Kette? Also lange Wartezeiten oder …

E: Durch die Einsparungen müssen natürlich jetzt alle Stellen irgendwie grade gucken, wie sie Ressourcen sparen können und das bedeutet bei manchen auch auf jeden Fall länger Wartezeiten. Ich glaube, das ehere Problem ist, und das wäre unabhängig von den Kürzungen, ist einfach, ob unser Klientel die Wege schafft. Also, genau, da anzurufen, das können wir ja auch alles machen, wir können auch mit den Leuten gemeinsam einen Termin bei einer anderen Stelle vereinbaren. Aber letztenendes müssen sie dort selber ankommen. Und das ist was, das können wir nicht steuern.

V: Ja.

E: Ich glaube, das ist halt die eigentliche Herausforderung. Nicht eigentlich die Wege quasi zu checken, also die wissen dann schon, wo, was und so, aber sie schaffen`s einfach manchmal nicht. Ja.

V: Okay. Wie sieht denn so ein typischer Besuch hier im Konsumraum aus?

E: Im Konsumraum? Also es kommt natürlich darauf an, ob du jetzt das erste Mal kommst, oder, ob du dich schon mal registriert hast.

V: Ja.

E: Wenn Du noch nie bei uns warst, dann musst Du dich registrieren, paar Sachen unterschrieben: Konsumordnung, Hausregeln, Datenschutz, das was ich Dir, hatte ich Dir das alles geschickt?

V: Ja.

E: Ja. Und, genau, dann führt man ein kurzes Aufnahmegespräch, wir versuchen das so kurz wie möglich zu halten, weil wir natürlich wissen, dass die Leute auch einfach Suchtdruck in der Regel haben und gar nicht so ein Ohr gerade für uns in dem Moment, aber müssen sie halt kurz durch. Da fragen wir einfach so ein paar Basics eben. Und dann ist es so, dass die Leute an den Tresen gehen, uns irgendwie kurz zeigen, was sie mitgebracht haben, sagen uns, welche Safer-Use Materialien sie brauchen, welche Spritzen-, Pumpengrößen. Die gehen Hände waschen, in der Zeit richten wir eigentlich dann diese Nierenschale, können sich einen Platz aussuchen, loslegen, konsumieren. Wenn sie fertig sind wird alles abgeworfen, Spritzenabwurf, Müll in Mülleimer, Plätze werden desinfiziert, die Nierenschale wird auch wieder zurückgestellt in so einen extra Behälter, wo wir das

dann abends in die Spülmaschine schmeißen. Danach werden die Hände nochmal gewaschen, oder zumindest desinfiziert. Und that`s it. Und beim zweiten Mal eigentlich genau das gleiche, nur ohne halt die Registrierung, ja.

V: Ist es dann so, dass die dann noch im Kontaktcafé vielleicht sich noch aufhalten oder?

E: Ja, ja. Manche so, manche so, genau. Aber die meisten gehen eigentlich runter nach dem Konsum, trinken vielleicht noch einen Kaffee, gehen auch wieder. Manche chillen länger, manche kommen auch einfach wieder hoch, alles dabei.

V: Wir haben ja jetzt auch schonmal über die Sichtkontrolle gesprochen. Gibt´s da irgendwie Auffälligkeiten bei den Substanzen, also vielleicht, was sich vielleicht gewandelt hat jetzt in dem Jahr, …

E: Ne.

V: oder so, ob es da irgendwas schon was gibt?

E: Ne, verneinendes mhm

V: Okay. Du hast ja gesagt, am meisten wird Crack …

E: Genau.

V: … konsumiert. Und …

E: Intravenös, ja, ja.

V: Intravenös, ja. Okay. Gibt´s da einen Wandel, vielleicht von den Konsumformen, oder?

E: Also da fehlen uns natürlich die Vergleichswerte. Dadurch, dass wir jetzt letztes Jahr erst eingestiegen sind und letztes Jahr Crack auf jeden Fall auch schon Thema hier war, war Crack fast von Anfang an unsere Hauptsubstanz hier, fast, also die ersten Monate wirklich noch nicht, aber relativ schnell. Das kann ich nur aus den Erfahrungen von anderen Konsumräumen wiedergeben, die eher die letzten Jahre über gemerkt haben, dass Crack überhaupt kommt. Also davor wurde eher Heroin geraucht, aber da war mit Abstand intravenös die meiste Konsumform und genau. Mittlerweile ist es immer noch die meiste, aber dicht gefolgt von inhalativen Konsum und da ist einfach Crack viel viel mehr als Heroin konsumiert wird.

V: Und beim intravenösen ist dann …

E: Koks vor allem …

V: Ja.

E: … und Subsitute sind so die Hauptsubstanzen. Jemand, der sein Methadon mitbringt, sein Subutex, oder nicht unbedingt seins, aber auch sowohl sein eigenes Verschriebenes, als auch vom Schwarzmarkt.

V: Okay.

E: Beides, ja.

V: Weil eigentlich ist ja laut dem Gesetz quasi, sollten es ja ärztlich nicht verschriebene Substanzen hier konsumiert werden. Weist ihr dann Leute ab, die im Substitutionsprogramm schon sind, oder …?

E: Ne. Einfach aus dem Grund, weil wir ja auch nicht wissen, ist es wirklich das Substitut, was Du verschrieben bekommen hast, …

V: Ah, ja.

E: … oder hast du´s vielleicht auch draußen gekauft. Das können wir gar nicht nachverfolgen, den Weg.

V: Und die von unten, von der Substitutionspraxis die dürfen dann hier … ?

E: Die dürfen hier oben konsumieren, genau. Da hatten wir auch davor mit der Praxis gesprochen, wie die das möchten. Irgendwie hebt sich das bisschen auf, wenn Leute hier oben was konsumieren dürfen und unten in der Behandlung sind, aber das wäre nicht realitätsnah, also die Leute abzuweisen, würden wir einfach Teile unserer Zielgruppe wegschicken.

V: Ja.

E: Ja.

V: Aber macht ihr dann so Hinweise irgendwie, dass das ein erhöhtes Gesundheitsrisiko für die darstellt, oder … ?

E: Wenn sie Methadon konsumieren, meinst du?

V: Oder halt das Substitut quasi parallel zum Beikonsum?

E: Das wissen die meisten. Also wir haben schon auf jeden Fall, grad wenn jemand Methadon konsumiert, das ist ja eigentlich nicht für intravenösen Konsum ausgelegt, letztendes kannst du dir aber ja irgendwie auch alles spritzen und da weisen wir schon darauf hin, dass es irgendwie besser wäre, anders einzunehmen. Das machen wir aber natürlich nicht jedes Mal, wenn die gleiche Person kommt. Der fallen ja sonst auch die Ohren ab.

V: Ja, ja, klar.

E: Die wissen´s dann irgendwann und dann ist es so, ja.

V: Ja. Ich muss mal ganz kurz schauen, was wir schon abgearbeitet haben.

E: Ja.

V: Genau, dann würde ich jetzt noch ein bisschen auf die Rechtsverordnung eingehen, wie das umgesetzt wird. Also ihr müsst ja eure Arbeit dokumentieren und evaluieren.

Inwieweit ist das möglich überhaupt oder vielleicht auch ein Hemmnis, wenn jetzt viel los ist oder so?

E: Wir machen das mit einer Excel-Tabelle. Und das ist eigentlich echt easy, also du trägst da einfach Datum ein, Geschlecht muss eingetragen werden. Wenn konsumiert wurde, weil wir machen hier eben auch medizinische Behandlung, aber meistens wird konsumiert, dann, was konsumiert wurde, wie konsumiert wurde, welche Beratung wir hatten, hatten wir überhaupt eine Beratung, hatten wir noch eine medizinische Hilfe, gab es irgendwelche Auffälligkeiten, musste ich jemand abweisen, gab´s ein Hausverbot. Das Ganze wird in einer Excel-Zeile im Endeffekt dokumentiert und das ganze wird automatisch in dieser Excel in Tagesblätter übertragen, das rechnet die dann selber aus und die ganzen Tagesblätter werden automatisch in ein Monatsprotokoll oder in eine Monatsdatei gezählt und diese, dieses Monatsprotokoll ist es letztendes, was ich dann rumschick an dieses ganze Steuerungskremium unter anderem, ja.

V: Bietet das, also inwiefern wird das dann vielleicht für Veränderungen, oder bietet das dann aufschlussreiche Informationen für Weiterentwicklungen sag ich mal?

E: Voll, also grade so die ersten Monate ist das natürlich, musste das hier erstmal anlaufen, also wir hatten schon auch lame Tage manchmal. Und da merkt man halt jetzt natürlich, dass wir mehr, also wir hatten im, ich glaub Februar war unser stärkster Monat, weil da auch die Vesperkirche draußen war, da hatten wir über 400 Konsumvorgänge in einem Monat. Und von anfangs dreißig und jetzt pendelt´s sich so zwischen zwei und 300 im normalen Monat ein, in Sommermonaten, ist es natürlich schon ein riesen Anstieg. Und ich glaub das überhaupt zu sehen, okay es zieht an, die Leute kommen, wir erreichen Leute, ja, Du kannst ja alles aus dieser Excel immer rauslesen. Haben wir Leute weitervermittelt, zum Beispiel, wie viel Notfälle gab´s, wie viele schwere Drogennotfälle. Und das sind natürlich schon alles Daten, die glaub ich auch über die sozialen Träger hinaus, die Politik irgendwie interessiert, …

V: Ja.

E: … weil das natürlich die Frage, rechtfertigt sich dann ein Drogenkonsumraum oder nicht. Grad mit diesem neuen Projekt, was dann bald kommen soll, und es viel Gelder im Endeffekt sind, muss man natürlich schon gucken, lohnt sich´s, ja.

V: Ja. Und wie ist dann, wenn jetzt so ein rapider Anstieg war der Konsumvorgänge, wie ist so die Auslastung?

E: Schon stressig zwischendurch, schon stressig, auf jeden Fall. Ja, also jemand, der hier reinkommt, möchte halt direkt direkt konsumieren natürlich und wenn es dann heißt, ja du musst jetzt noch warten, das ist vor allem beim Rauchen so, weil wir nur eine Raucherkammer haben, da haben wir Leute oft nicht so Bock drauf, dann kurz zu warten, ja.

V: Wird das dann durch den neuen Standort besser? Weil in der Pressemitteilung stand ja, dass da mehr Platz ist und so.

E: Genau. Also wir haben insgesamt im neuen Standort zwölf Konsumplätze, jetzt haben wir ja vier. Dort werden dann sechs für intravenösen, nasalen, oralen Konsum sein und sechs Stück für inhalativen Konsum. Und jetzt ist ja nur einer für inhalativ und die Raucherkabine wurde die ersten Monate gar nicht genutzt. Und wir haben dann schon auch nachgefragt bei den Leuten, ja warum ist das denn so, wir wissen, Crack ist ein Ding, aber warum halt nicht bei uns.

V: Ja.

E: Und dann hieß es, Crack wird gern in Gemeinschaft konsumiert. Und das ist halt was, was wir hier überhaupt nicht bieten können, da darf nur jeder einzeln reingehen in die Raucherkammer. Und im neuen Gebäude können dann eigentlich sechs Leute gleichzeitig konsumieren und denk dadurch werden wir schon auf jeden Fall auch nochmal mehr Leute erreichen, ja.

V: Du hast gesagt, ihr erhebt auch das Geschlecht, wie ist so die Verteilung geschlechtlich?

E: Mehr Männer. Ich würd sagen 70/30.

V: Okay.

E: Ja.

V: Wie könnte man mehr Frauen ansprechen vielleicht?

E: Es gibt ja Konsumräume, die extra nur für Frauen zum Beispiel ausgelegt sind, in Hamburg glaub ich.

V: Ja.

E: Und ich glaub, es gibt auch Konsumräume, die extra Tage einrichten für Frauen.

V: Oder auch vor der eigentlich Öffnung vielleicht zwei Stunden noch aufmachen.

E: Ah, ja. Ah, ja.

V: Nur für Frauen.

E: Sowas zum Beispiel. Ich glaub ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, ob Frauen hier weniger kommen, weil eine Hemmung da ist, das weiß ich nicht. Es konsumieren ja generell auch einfach wirklich weniger Frauen als Männer in unserer Gesellschaft, deswegen kann ich das gar nicht sagen, ob das, ja, ob das unsere Frauen hier bräuchten, ob die irgendwie nicht kommen, weil die sich nicht wohlfühlen, weil vielleicht Männer drin sind. Ja, das kann ich gar nicht sagen.

V: Okay. Also ist das dann eher die generelle Szene quasi, die so widergespiegelt …

E: Ist einfach überwiegend Männer, ja, ja genau. Ich denk dadurch, dass unsere Szene nicht so groß ist, wie jetzt in Hamburg beispielsweise, …

V: Ja, ja.

E: … haben wir hier halt grade noch nicht oder wie auch immer den Bedarf für einen Konsumraum nur für Frauen zum Beispiel, ja.

V: Und Du hast auch gesagt, ihr erhebt, welche Beratung durchgeführt wurde, also was sind denn so die Beratungen, die vielleicht am meisten in Anspruch genommen werden?

E: Safer-Use-Beratung machen wir auf jeden Fall. Also, dass wir irgendwie verschiedene Nadelgrößen anbieten, wenn wir merken, es funktioniert nicht, verschiedene Filter, wo Dir Felix vorhin erklärt hatte, kurz. Das machen wir, wir machen auch Drogenberatungen, also grad sowas, was Mischkonsum angeht, wenn jetzt beispielsweise jemand besoffen hier reinkommt, würde ich schon vorschlagen, dass die Person vielleicht nicht gerade Opioide konsumiert, sondern wenn die Wahl besteht, halt lieber Koks. Das machen wir und psychosoziale Intervention. Also einfach erstmal zu allen Lebensbereichen, Lebenslagen. Was wir schon auch viel machen, ist, sind Kriseninterventionen. Also es gibt Leute, die psychotisch werden nach dem Konsumvorgang und das ganze ein bisschen aufzufangen, das machen wir hier auch viel.

V: Wie läuft das dann ab? Also wie fängt man solche …

E: Kommt ein bisschen drauf an, wie die Psychose ausgeprägt ist. Es gibt Leute, die sind gar nicht mehr ansprechbar, also die sind auch harmlos, aber man muss es erstmal, man muss sie erstmal kennen, um zu wissen, "ah ja, ist normal bei dem mittlerweile" und es gibt einfach Leute, die kommen in so einen Redefluss zum Beispiel. Die labern aber dann auch manchmal nur unzusammenhängende Dinge. Da kommt es ein bisschen drauf an, kannst Du die bremsen und steuern, oder müssen die das einfach gerade nur rauslassen, ja.

V: Zählt sowas auch als Notfall dann …

E: Ne.

V: … so ein psychotischer Schub?

E: Verneinendes mhm

V: Okay. Was wird als Notfall erfasst alles?

E: Sobald wir medizinische Hilfe leisten müssen. Also sei es zum Beispiel, oder ich sag mal, das erste, was in der Regel bei einer Überdosis passiert, ist eigentlich, dass die Atmung irgendwie nicht mehr richtig funktioniert. Daran erkennst Du´s eigentlich. Und es gibt aber auch Möglichkeiten, zum Beispiel auf Zuruf, dass jemand dadurch wieder atmet. Wir haben so ein Pulsoxymeter, da können wir die Sauerstoffsättigung nachgucken im Blut. Wenn wir merken, die wird schlechter, dann, wie gesagt, auf Zuruf. Wenn wir merken, das funktioniert nicht mehr, kannst Du Schmerzreize setzen, irgendwie mit Deinem Knöchel hier über die Knochen, einfach wehtun, also es ist kacke, aber es funktioniert.

Dann atmen die Leute. Das ist zum Beispiel ein Notfall dann schon. Und ein schwerer Notfall ist es eigentlich dann, wenn wir Rettungsdienst dazurufen müssen, wenn wir für uns merken, okay, die Person fängt jetzt immer weniger an zu atmen, Sauerstoff haben wir auch immer vor Ort, reicht auch nicht mehr, dann, genau. Da unterscheiden wir so ein bisschen.

V: Ja. Ihr werdet ja auch, quasi, ihr seid ja alle geschult in der Notfallversorgung …

E: Genau.

V: … und das greift jetzt vielleicht, hat vielleicht bisschen schon vorweggegriffen, aber ist die Schulung dann, dass ihr quasi auch Notfälle komplett alleine handeln könntet, oder wird dann bei den meisten grundsätzlich der Rettungsdienst dazugerufen?

E: Also eigentlich versuchen wir sogar eher ein Rettungsdienst zu rufen, weil das auch die Leute oft abschreckt, wir hier dann wieder so eine action vorm Haus haben und so. Aber es kommt natürlich immer drauf an, also, wenn einer notwendig wird, dann rufen wir auf jeden Fall natürlich. Solange Leute aber auch noch äußern können, sie möchten´s nicht, machen wir´s auch nicht. Generell würde ich schon sagen, können wir erstmal alle Notfälle irgendwie ein Stück weit selber regeln, aber das Ganze hat natürlich Grenzen. Also wir mussten vor Kurzem eben reanimieren, das, ja, da brauchen wir auf jeden Fall mehr Unterstützung, da haben wir gar nicht die Geräte. Was wir können, ist halt zu reanimieren, bis dann jemand kommt im Endeffekt. Aber das ist schon auch nochmal next level Reanimation, also das ist schon auch für uns nicht Alltag, Gott sei Dank, ja.

V: Ja. Die Person hat´s aber auch dann überlebt?

E: Die hat´s überlebt, ja.

V: Gab´s schonmal, also Todesfall gab´s hier auch noch nicht.

E: verneinendes mhm.

V: Wie gestaltet sich so die Umsetzung, weil ihr müsst ja regelmäßig geschult werden nach der Rechtsverordnung. Wie regelmäßig ist das?

E: Steht da eine Zahl drin?

V: Ne.

E: Ne, oder? Ne, nur regelmäßige Schulungen, ja. Also ich hatte mir jetzt mal, mein Plan war, alle zwei Jahre, tatsächlich. Was wir gucken, wenn neue Mitarbeitende anfangen, also mein Hauptamtliches Team ist eigentlich von Anfang an das gleiche gewesen, das ist cool, aber paar Minijobber wechseln natürlich durch, die arbeiten jetzt nicht hier oben im Konsumraum, aber die arbeiten alleine unten im Café und deswegen kriegen die auch eine erste Hilfe Schulung für Notfälle, weil man weiß ja nie, ob jemand hier oben konsumiert, runter geht und dann wird´s hier unten irgendwie doof. Und das muss aber nicht

offizielles sein. Deswegen machen wir das teamintern. Also wir haben hier Pflegefachkräfte, wir haben, genau, so GFB-Abende, Minijobberabende, wo die dann, wo sowas passiert, zum Beispiel. Und was wir aber machen, ist uns tatsächlich innerhalb vom Team regelmäßig zu schulen, also wir haben schon Schulungen, also mit wir mein ich jetzt uns Sozialarbeitende auch, zu Nadelstichverletzungen haben wir uns gegeben. Wir hatten vor kurzem nochmal extra für uns so eine Reanimationspuppe geholt, haben vom Rettungsdienst jemanden eingeladen, der uns nochmal so ein bisschen Crashkurs gibt und haben einfach für einen Tag die Einrichtung paar Stunden geschlossen gehabt und haben das für uns nochmal geübt. Aber das ist nichts offizielles in dem Sinne, sondern das ist nur für uns zur Auffrischung. Und das machen wir schon regelmäßig intern, genau, und die offiziellen Erste-Hilfe-Kurse alle zwei Jahre, war da mein Plan. Also nächstes Jahr wär´s dann wieder soweit, genau.

V: Okay. Dann, ich guck mal, ob ich noch irgendwas vergessen hatte. Genau, gibt es vielleicht Deiner Meinung nach noch irgendwelche Regelungen, die schwer umzusetzen sind, oder die quasi so vorgeschrieben sind, die aber gar nicht in die Praxis übertragbar sind?

E: Oh, ja.

Lachen

E: Also das mit dem Ausweis ist tatsächlich ein Ding. Das ist jetzt nicht, also ultra schlimm, wäre natürlich aber cool, wenn das nicht wäre. Was mega ätzend ist, ist tatsächlich die Tatsache, dass wenn Leute sich ihre Substanz zum Beispiel aufgekocht haben, Spritze aufgezogen, konsumieren und haben aber noch die Hälfte in der Spritze drin, weil sie sagen, “okay, mir reicht das grade, ich möchte nicht mehr konsumieren”, ist ja eigentlich ein Ziel von uns, im Sinne des Safer-Use, dass die Leute checken, “okay, mir reicht's gerade auch”. Diese Spritze darf nicht mit rausgenommen werden. Und die Konsequenz ist, dass sie´s entweder wegschmeißen müssen, macht kein Mensch, oder konsumieren müssen. Und dann konsumieren sie’s natürlich. Und das ist halt, das widerspricht total eigentlich unserem Konzept hier. Ja, das wäre auf jeden Fall was, was verändert werden dürfte, dass die Leute einfach das mit rausnehmen können. Was ich voll sehe, ist jetzt nicht, dass Leute, also oder wo ich mitgehen könnte auch, wenn man sagt, Leute dürfen nicht hier reinkommen, nur um aufkochen, nur um zu rationieren, das okay, aber ich finde im Sinne des Safer-Use, wenn jemand merkt, “oh, mir ist es doch zu viel, ich konsumier’s lieber nachher”, ist es doch tausend Mal mehr unser Ziel erreicht, anstatt, dass er sich’s noch wegballert, weil er’s nicht wegschmeißen will, ja.

V: Gut, ich glaube, dass da vielleicht das Problem ist, dass man dann sagen könnte, “ja, aber er kann ja die Spritze wieder jemand anderem geben” und dann wäre ja auch wieder das Ziel …

E: Ja.

V: … völlig verfehlt.

E: Ja.

V: Ich glaube, dass da …

E: Das stimmt.

V: Fass ohne Boden sozusagen.

E: Ja, das stimmt.

V: Gibt's vielleicht auch noch irgendwie Sachverhalte oder Situationen, die bisher gar nicht diskutiert wurden oder wo vielleicht auch die Regelung fehlt?

E: Boah, bestimmt.

Lachen.

E: Manchmal müssen halt Sachen auch passieren, damit wir merken, "ah, ja, das gibt's auch noch", um's uns anzuschauen, irgendwie. Was müssen wir uns denn jetzt angucken… . Abläufe … . Wir haben mehrere, zum Beispiel haben wir ja auch eben die Substitution im ersten Stock. Da müssen wir uns nochmal angucken, wie kriegen wir da irgendwie eine richtig gute Zusammenarbeit raus, also auch bei uns, aber intern. Zum Beispiel sind wir gerade dran zum Thema Kinderschutz uns was zu erarbeiten, weil wir schon im Schirm hatten, oder aufm Schirm hatten, dass wir ja, wenn jemand bei uns im Konsumraum konsumiert und ein Kind bei der Person im Haushalt lebt, ist irgendwie, sollten schon irgendwelche Alarmglocken angehen. Heißt nicht automatisch Kindeswohlgefährdung, heißt aber für uns, okay, bisschen im Auge behalten, Blick drauf haben, so, das hatten wir auf dem Schirm. Was dann aber durch diesen Drogennotfall von der 16-Jährigen uns halt irgendwie selber erst kam ist, ja okay, aber was ist, wenn Minderjährige bei uns konsumieren, ab wann ist es dann eine Kindeswohlgefährdung, wie greift da der Kinderschutz, wann müssen wir was machen, welche Meldungen machen, weil nur weil jemand mit 16 bei uns konsumiert ist es halt nicht automatisch eine Kindeswohlgefährdung. Und das sind halt so Sachen, genau, die so Zeit brauchen einfach und die manchmal halt auch aufkommen müssen erst, damit man's auf den Schirm kriegt.

V: Ja. Vielleicht jetzt nochmal zu der 16-Jährigen, wie ist denn so, also anteilig mit Minderjährigen oder Durchschnittsalter? Also wir viele Minderjährige …

E: Hatten wir? Eine.

V: Nur eine?

E: Ja, ja.

V: Okay. Und was ist so das Durchschnittsalter vielleicht von Konsumenten?

E: Mitte 30 würde ich sagen, ja.

V: Okay.

E: Ja, doch so Mitte 30 bis Mitte 40, so eine Altersrange haben wir da in dieser Excel und das ist glaub ich mit die, die am meisten angegeben wird, ja.

V: Gibt's jetzt noch irgendwas, wo wir gar nicht drauf eingegangen sind in dem Interview? Vielleicht, was noch wichtig wäre.

E: Ich glaube nicht, ich glaube, wir haben alles.

V: Gut, dann wäre ich mit meinen Fragen auch durch.

E: Gut.

6. Erstaufnahmebogen

KOMBO

Ersterfassung zur Nutzung des Drogenkonsumraums

Datum: _____

Allgemeines

Name: _____ Vorname: _____

Geschlecht: ☐ männlich ☐ weiblich ☐ divers

Geburtsdatum: _____

Geburtsland: ☐ Deutschland ☐ anderes: _____

Nationalität: ☐ deutsch ☐ anderes: _____

Wohnsituation: ☐ Mietswohnung ☐ bei Freunden/Familie

☐ Wohnungsnotfallhilfe ☐ obdachlos

☐ anderes: _____

Postleitzahl: _____

Konsum

Alter bei Erstkonsum: _____ Jahre alt

Hauptdrogen: ☐ Heroin ☐ synthetische Opiate ☐ Substitut ☐ Crack

☐ Benzodiazepine ☐ Kokain ☐ Amphetamine ☐ Alkohol

☐ Cannabis ☐ _____ ☐ _____

Droge 1: _____

Konsumform: ☐ intravenös ☐ nasal ☐ anal ☐ inhalativ ☐ oral

Häufigkeit: ☐ täglich ☐ wöchentlich ☐ monatlich

Droge 2: _____

Konsumform: ☐ intravenös ☐ nasal ☐ anal ☐ inhalativ ☐ oral

Häufigkeit: ☐ täglich ☐ wöchentlich ☐ monatlich

Orte des Konsums: ☐ zu Hause ☐ bei Freunden

☐ öffentliche Orte ☐ sonstige Orte _____

Bisherige Angebote der Drogenhilfe genutzt? ☐ nein ☐ ja, und zwar:

☐ Substitution ☐ Beratung

☐ Entgiftung ☐ Therapie

☐ sonstiges: _____